



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JUNI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI).....	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	6
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	7
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	24
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik.....	24
3.3.2 Rawat Inap.....	27
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	35
3.3.4 High Care Unit (HCU)	36
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	37
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO).....	38
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	40
3.4.1 Instalasi Farmasi	40
3.4.2 Laboratorium.....	60
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	64
3.4.4 Radiologi	71
3.4.5 Gizi	76
3.4.6 CSSD - Laundry	89
3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan.....	97
3.5.1 SDM	97
3.5.2 IPSRS.....	105
3.5.3 Security.....	111
3.5.4 Parkir	114
3.5.5 Humas Marketing	114
3.5.6 Penjaminan	120
3.5.7 PIPP – MOD - MPP.....	121
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	129
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	130
3.5.10 IT - SIMRS	132
3.6 Komite dan Tim	133
3.6.1 Komite Mutu.....	133
3.6.2 Komite PPI.....	185
3.6.3 Tim PKRS	199
3.6.4 Tim Prognas.....	201
3.6.5 Tim PPRA	242
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	248
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	250
3.8 Profil SDM	265
Bab IV Kesimpulan dan Saran	269
Bab V Penutup	270
Lampiran	271

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juni Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



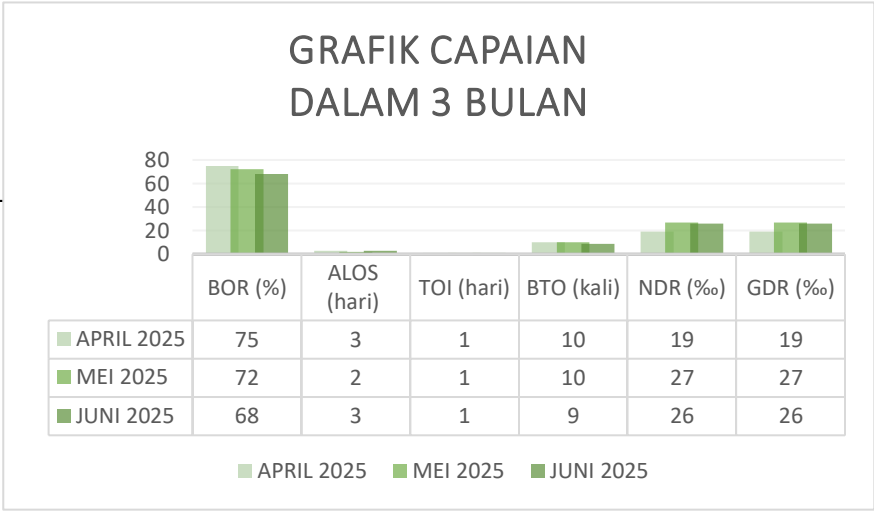
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	CATATAN
BOR	81%	75%	72%	68%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

INDIKATOR	NILAI JUNI 2025	STANDAR IDEAL	EVALUASI SINGKAT
BOR	68%	60%-85%	Masih dalam standar, batas rendah
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	9 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Masalah :

a. BOR (Bed Occupancy Rate)

Data : April (75%), Mei 72%), Juni (68%)

Analisis :

- a) Terjadi tren penurunan okupansi tempat tidur selama tiga bulan berturut-turut.
- b) Penurunan BOR bisa mengindikasikan :
 - 1. Penurunan jumlah kunjungan/rawat inap pasien.
 - 2. Perpindahan pasien ke fasyankes lain.
 - 3. Adanya persepsi Masyarakat terhadap kualitas layanan yang menurun.

b. LOS (Length of Stay)

Data : stabil di 3 hari

Analisis :

- a) Waktu rata-rata perawatan pasien tidak berubah.
- b) LOS yang stabil menunjukkan efisiensi pengelolaan klinis dan administrasi

relatif terjaga.

- c) Namun, bila dikaitkan dengan BOR yang menurun, LOS stabil tidak cukup menahan BOR agar tetap tinggi.

c. TOI (Turn Over Interval)

Data : stabil di 1 hari

Analisis :

- a) Menunjukkan bahwa waktu tunggu tempat tidur kosong sebelum digunakan kembali cukup singkat, yang berarti pengelolaan tempat tidur cukup efisien.
- b) Namun, karena BOR menurun, ada kemungkinan kekosongan tempat tidur karena rendahnya jumlah pasien masuk, bukan karena efisiensi rotasi.

d. BTO (Bed Turn Over)

Data : April (10 kali), Mei (10 kali), Juni (9 kali)

Analisis :

- a) Ada sedikit penurunan frekuensi penggunaan tempat tidur.
- b) Hal ini mendukung Kesimpulan bahwa jumlah pasien yang dirawat mulai menurun.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Evaluasi Pelayanan

- a) Lakukan survey kepuasan pasien dan identifikasi factor-faktor penurunan kunjungan.
- b) Periksa apakah ada perubahan kebijakan BPJS, tarif, atau pelayanan yang mempengaruhi pasien.

2. Peningkatan Promosi Pelayanan

Tingkatkan promosi layanan unggulan rumah sakit untuk menarik pasien baru, termasuk promosi online dan kerja sama dengan faskes primer (puskesmas/klinik).

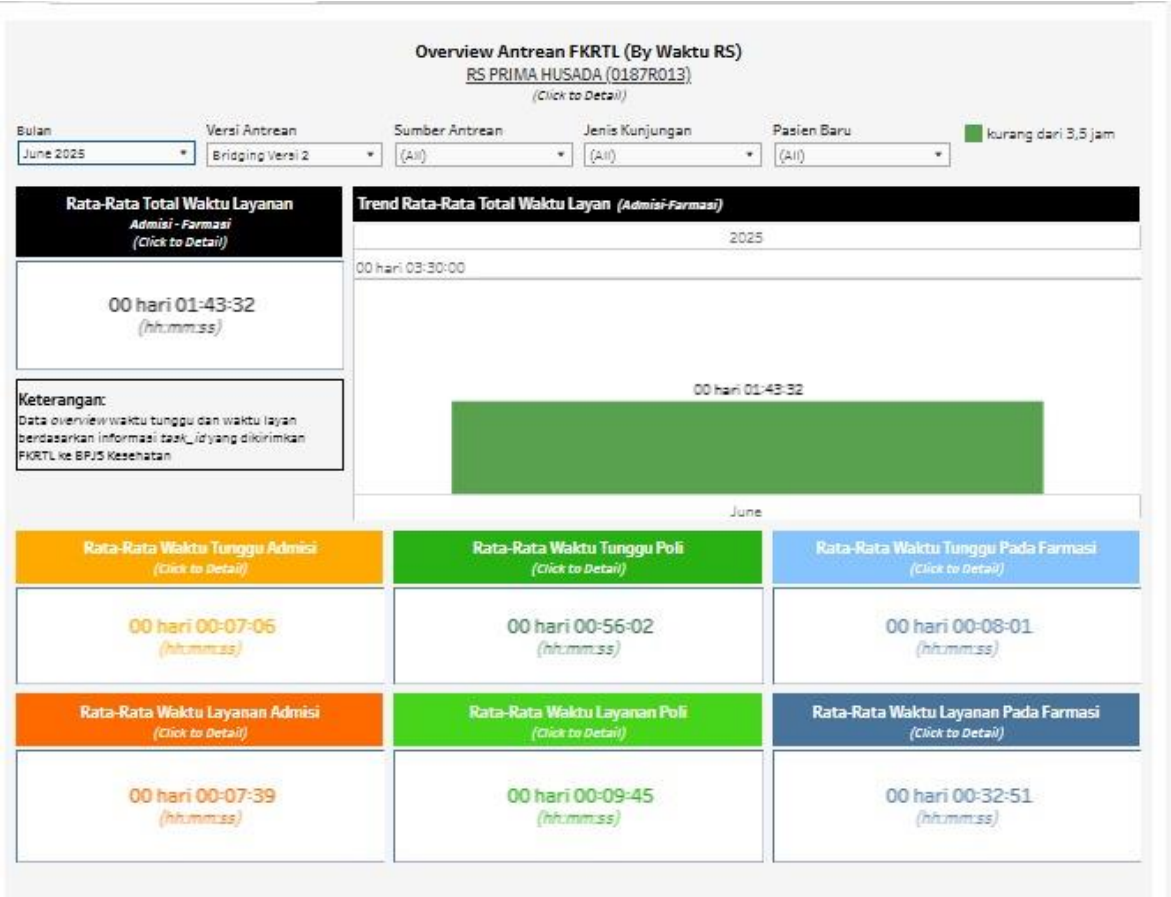
3. Koordinasi dengan Tim Medis dan Manajemen

- a) Adakan rapat untuk meninjau performa masing-masing bangsal.
- b) Evaluasi efektivitas system rujukan dan komunikasi antar unit.

4. Pemantauan Lanjutan

- a) Tetapkan indikator peringatan dini jika BOR terus menurun (<65%).
- b) Tinjau kemungkinan **revisi kapasitas tempat tidur** jika tren rendah terus berlanjut agar efisiensi tetap terjaga.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2025)					
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2024						
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	02:07:27	01:59:21	02:09:52	02:18:27	02:08:00	01:43:32
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	00:07:37	00:04:57	00:06:52	00:05:18	00:05:52	00:07:06
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	00:05:49	00:04:58	00:05:36	00:07:16	00:08:24	00:07:39
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	01:06:01	01:05:56	01:02:05	01:08:06	01:00:46	00:56:02
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	00:09:41	00:10:08	00:10:47	00:09:38	00:10:39	00:09:45
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	00:11:17	00:09:31	00:12:56	00:13:02	00:10:22	00:08:01
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	00:44:57	00:38:06	00:48:35	00:51:36	00:50:31	00:32:51

Analisis :
Pada bulan ini terjadi perbaikan di keseluruhan waktu layanan. Terutama Waktu Tunggu Farmasi dan Waktu Layanan Farmasi membaik.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	Jenis	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	30%	46,43%	47.64%	49.61%	50.19%	48.42%	48.20%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	95.11%	94.28%	92.04%	94.61%	94.20%	94.36%

Analisis :
Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpis-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.1 Bidang Pelayanan Dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	Terkendala dengan tempat saat hall di buat untuk acara pelatihan dan rapat
		Penambahan TT rawat inap,untuk VIP kelas 1 dan kelas 2	Sudah selesai	Fasilitas seperti tv masih belum terpasang
		Foto bayi	Sudah berjalan	Fasilitas dari unit sendiri

		ERM rawat inap	Sudah berjalan mulai mei tanggal 23 dan samapai saat ini	Untuk ERM rawat inap sudah berjalan dengan baik akan tetapi untuk pasien lodingan masih menggunakan ERM manual sehingga belum 100% memakai ERM
3	IRJA	Poli Eksekutif	Sudah berjalan mulai dari 2024 untuk bulan april 2025 ada 31 pasien,15 pasien di dominasi oleh pasien obgyn dan anak 10 pasien	Pasien saraf sakura masih belum ada pasien sama sekali untuk bulan Juni 2025
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi, sudah terpasang poster di IGD tentang pelayakit yang tidak terkafer bpjs	Sudah terpasang di IGD
5	NICU	Pelatihan pemasangan ventilator oleh vendor	Pemasangan ventilator ini dimaksimalkan oleh unit NICU sehingga pasien yang pro ventilator tidak di rujuk	Belum semua perawat bisa mengoprasikan ventilator

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 126. e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	Dalam antrian progamer
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada

			Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .
		5. Website PRIMANTARA	a. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23/09/2024. b. Presentasi MOCKUP oleh Vendor pada tanggal 20/12/2024, notulen sudah masuk	Permintaan dihold menunggu kenaikan pasien PRIMANTARA. Monitoring dan Evaluasi

			ke PT, menunggu ACC Pendaftaran pasien PRIMANTARA ke farmasi masih menggunakan kertas manual. c. Belum ada fitur jasa pengiriman obat (Primantara) ke rumah pasien di SIMRS dan diperlukan penanda di resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat telah disiapkan.	
		6. Jasa pengantaran obat	a. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. b. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. c. Subsidi promo untuk obat tertinggal menggunakan pengantaran gratis. d. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet dan perubahan alur pembayaran di Kasir.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		8. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah	Dalam antrian progamer.

			berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		9. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk	Pengajuan fitur ke progamer.

			melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		11. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat"	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat" untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	Rencana trial menunggu Programmer PT
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaikan sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat	Monitoring dan Evaluasi.

			IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaikan alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu :	
--	--	--	---	--

			- Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan	
--	--	--	---	--

			sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 :	
--	--	--	---	--

			a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi” bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih di sistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke	
--	--	--	--	--

			pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada di depo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada di inputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock.	
--	--	--	--	--

			- Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	a. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. b. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu diserahkan kepada Programmer PT.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.
		2. Penggunaan ERM Rawat Inap	a. Kolaborasi dengan Programmer PT. b. Melakukan trial pada awal Bulan Mei 2025.	Follow up. Monitoring dan Evaluasi.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan	Monitoring dan Evaluasi.

			Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	
		4. Dokumentasi DRM lama.	a. Melakukan scanning form kedalam SIMRS. b. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. c. Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
		5. Retensi DRM	a. Data DRM yang akan diretensi menunggu Programmer PT sebelum dilakukan pemilahan dan pemusnahan DRM. b. Pemusnahan terakhir dilakukan pada Tahun 2018.	Follow up Programmer PT.
		6. Rekap Data Laporan Dinkes	a. Data yang dibutuhkan tidak semua bisa ditarik oleh system. b. Pengajuan fitur ke Programmer PT. c. RM membuat Google Spreadsheet untuk diisi oleh unit-unit terkait setiap harinya. d. Tujuannya untuk memudahkan Karu RM dalam pelaporan RL ke Dinkes tepat waktu.	Dalam Proses.
2.	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	a. Melakukan studi banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain. b. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam proses dan diajukan ke Program Kerja Tahun 2025.
		2. Penetapan petugas jaga.	Melakukan penetapan PJ disetiap divisi, Pendaftaran Central, CSO dan	PJ Pendaftaran Central : Tyas PJ Pendaftaran IGD : Riri

			Pendaftaran IGD dengan personil tetap, dengan tujuan supaya petugas menguasai permasalahan dan fokus pelayanan, memudahkan telusur dan perbaikan jika ada komplain dan masalah.	Pendaftaran CSO : Shinta Bella
		3. Pendaftaran pasien	a. Reservasi pasien umum dan asuransi melalui web, disertai pembayaran melalui VA. b. Kolaborasi dengan IT dan SIMRS.	Proses mengerjakan TOR
Instalasi Radiologi				
1.	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Surat pemberitahuan kebutuhan Sp.Rad sudah diterima oleh Ketua Kolegium.
		3. Respon Time Radiologi	Kolaborasi dengan perawat untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet secara real time.	Mulai dijalankan awal Tahun 2024.
Instalasi Laboratorium				
1.	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	a. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. b. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Stok Opname BDRS	BDRS berjalan mulai 29 November 2024.	SO akan dilakukan Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.
		3. Penambahan fitur	a. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS. b. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam antrian Programmer PT.
Instalasi Gizi dan Dapur				
1.	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan/MCU Gizi.	a. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. b. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		2. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
		3. Daftar Menu	Book Menu sudah proses dikerjakan oleh PKRS.	Dalam proses.

		Makanan Penunggu VIP.		
		4. Registrasi alat makan	a. Kolaborasi dengan penyaji untuk melakukan pencatatan keluar masuknya sendok di Google Spreadsheet. b. Perbaikan alur saat mengambil peralatan makan di ruangan, jika ditemukan sendok hilang maka dicatat di Google Spreadsheet dan dioperkan ke perawat ruangan untuk ditagihkan ke saat pasien KRS. c. Dilakukan stok opname setiap bulan untuk menghitung peralatan makan. d. Membuat SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS.	Registrasi alat makan sudah berjalan sejak Bulan Januari 2024 Proses dibuatkan SPO kehilangan alat makan, penggantian biaya dilakukan di Kasir, jika tidak tertagihkan maka tanggungjawab unit bersama.
		5. Pemesanan diet melalui SIMRS	a. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet dari DPJP ke perawat, perawat ke ahli gizi. b. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di SIM-RS jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. c. Proses cetak label langsung efisien tanpa harus mengetik ulang dan tidak menulis manual di label. d. Koordinasi dengan bagian SIM-RS supaya segera di realisasikan ke unit.	Monitoring dan evaluasi.
2.	Dapur	6. QC sesuai sistem HACCP	a. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. b. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. c. Memastikan 7 prinsip HACCP. d. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.	Menunggu jadwal pelatihan.
		1. Perbaikan menu makanan dan plating.	a. Sudah dilakukan supervisi oleh Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. b. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO	Monitoring dan Evaluasi. Revisi tampilan sedang diproses oleh PKRS (Eriko).

			plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan.	
		2. Menu makanan buka puasa senin-kamis.	Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : a. Daftar siklus menu makanan. b. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). c. Link google form untuk pemesanan (+). d. Kebijakan pemesanan makanan hari H maksimal pukul 06.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi.
3.	Pantry	Food Waste	Perbaikan pencatatan sisa makanan berdasarkan menu makanan untuk mengetahui makanan yang kurang diminati.	Monitoring dan Evaluasi
Instalasi CSSD dan Laundry				
1.	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilikator (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli 2024.	a. Kolom tidak terisi lengkap. b. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
		3. Perbaikan jam kerja	Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Berjalan per Bulan Desember 2024. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
2.	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	a. Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. b. Belum terealisasi.	Berjawal awal Tahun 2025.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP dan LINEN IKO.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP, kerusakan linen IKO.	Linen IKO dan VIP sudah diproses. Selimut VIP sudah diajukan.
		4. Perbaikan jam kerja	Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
Lain-lain				
1.	Lain-lain	1. Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman	1. RM dan Pendaftaran Hari : Senin, 14-07-2025.

		Kabid.	pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : c. Tanya Jawab d. Role Play	Waktu : 13.00 WIB sd selesai. Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom). 2. Farmasi Hari : Selasa, 15-07-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 3. Gizi Hari : Rabu, 16-07-2025 Waktu : 11.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 4. Laboratorium Hari : Kamis, 17-07-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 5. Radiologi Hari : Jum'at, 18-07-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 6. CSSD dan Laundry Hari : Sabtu, 19-06-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Laundry (Yang
--	--	--------	--	--

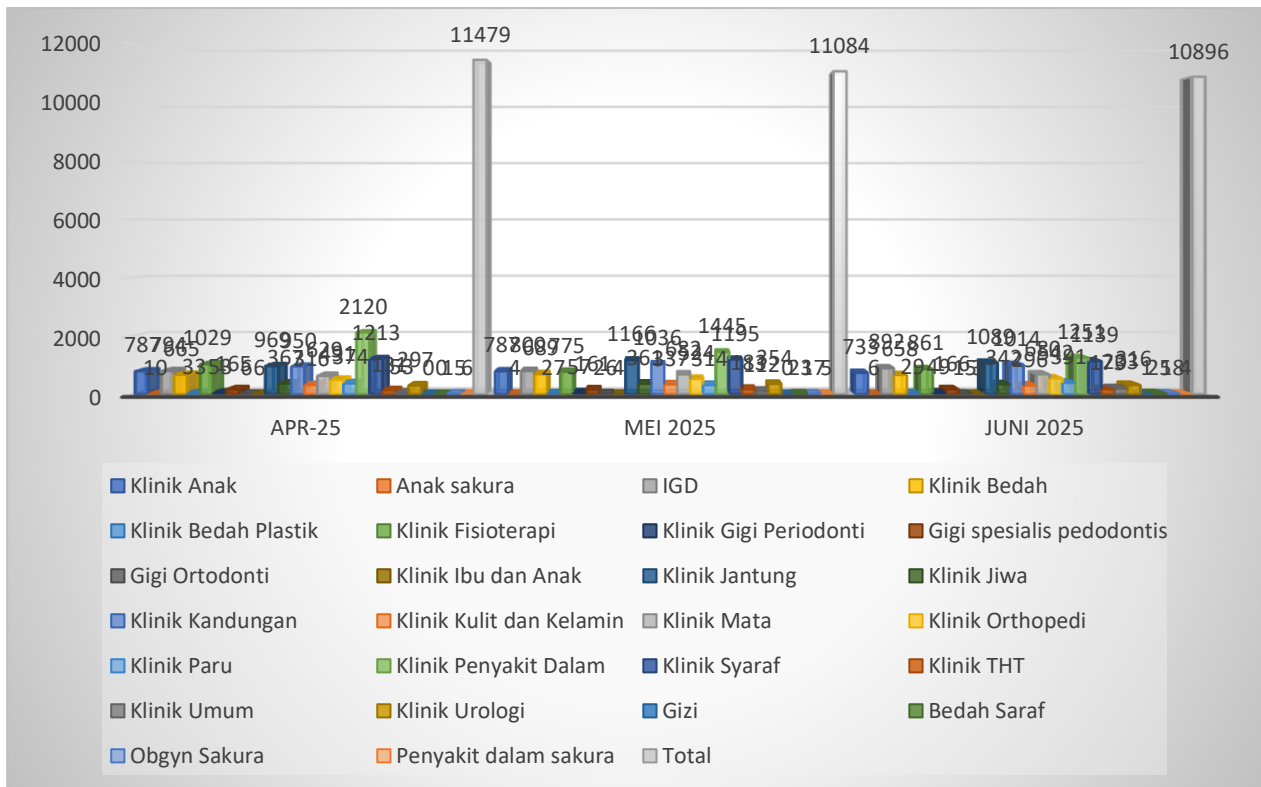
				berhalangan hadir menggunakan Zoom) 7. Rapat All Karu Penunjang Hari : Sabtu, 26-07-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Ruang Direktur RS
--	--	--	--	---

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	APRIL 2025			MEI 2025			JUNI 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	50	737	787	42	745	787	36	697	733
2	Anak sakura	2	8	10	1	3	4	0	6	6
3	IGD	260	534	794	259	541	800	286	606	892
4	Klinik Bedah	55	610	665	35	654	689	36	622	658
5	Klinik Bedah Plastik	2	31	33	1	26	27	0	29	29
6	Klinik Fisioterapi	2	1027	1029	1	774	775	1	860	861
7	Klinik Gigi Periodonti	12	41	53	3	54	57	7	42	49
8	Gigi spesialis pedodontis	14	151	165	15	146	161	14	152	166
9	Gigi Ortodonti	1	5	6	4	22	26	2	13	15
10	Klinik Ibu dan Anak	0	6	6	0	4	4	0	3	3
11	Klinik Jantung	11	958	969	19	1147	1166	16	1073	1089
12	Klinik Jiwa	13	354	367	9	352	361	13	329	342
13	Klinik Kandungan	102	848	950	97	939	1036	122	892	1014
14	Klinik Kulit dan Kelamin	39	279	316	35	302	337	36	260	296
15	Klinik Mata	44	585	629	53	629	682	58	622	680
16	Klinik Orthopedi	20	471	491	30	494	524	27	515	542
17	Klinik Paru	8	336	374	10	304	314	6	385	391
18	Klinik Penyakit Dalam	47	2063	2120	43	1402	1445	36	1215	1251
19	Klinik Syaraf	35	1178	1213	35	1160	1195	44	1095	1139
20	Klinik THT	40	91	131	32	151	183	36	137	173
21	Klinik Umum	29	24	53	76	36	112	125	78	203
22	Klinik Urologi	30	267	297	43	311	354	29	287	316
23	Gizi	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	Bedah Saraf	0	0	0	1	22	23	1	24	25
25	Obgyn Sakura	3	12	15	2	15	17	2	16	18
26	Penyakit dalam sakura	2	4	6	1	4	5	2	2	4
Total		821	10620	11479	847	10237	11084	935	9961	10896



Analisis :

1. Kunjungan di bulan juni menurun dari bulan sebelumnya,sebanyak 1,69% dari bulan mei 2025. Analisanya ada dokter cuti haji dengan pasien terbanyak sehingga kunjungan menurun sekitar 188 pasien di poli rawat jalan
2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 1251 ,jumlah pasien ini menurun dibandingkan bulan mei 2025 karena ada 1 dokter ipd cuti selama 1 bulan dan dengan pasien yang terbanyak
3. Kunjungan poli bedah saraf sudah stabil untuk bulan mei karena dokter bedah saraf sudah aktif kembal dari bulan sebelumnya
4. Untuk poli pedodonti anak dalam 3 bulan terakhir belum stabil dikarenakan setiap praktek ada pembatasan kuota sehingga jumlah pasien tidak banyak dalam 3 bulan terakhir
5. Kunjungan poli eksekutif adalah bulan juni meningkat 13,3% dari bulan mei 2025 disebabkan pasien lebih memilih umum biasa di bandingkan poli Sakura karena tidak terlalu mahal

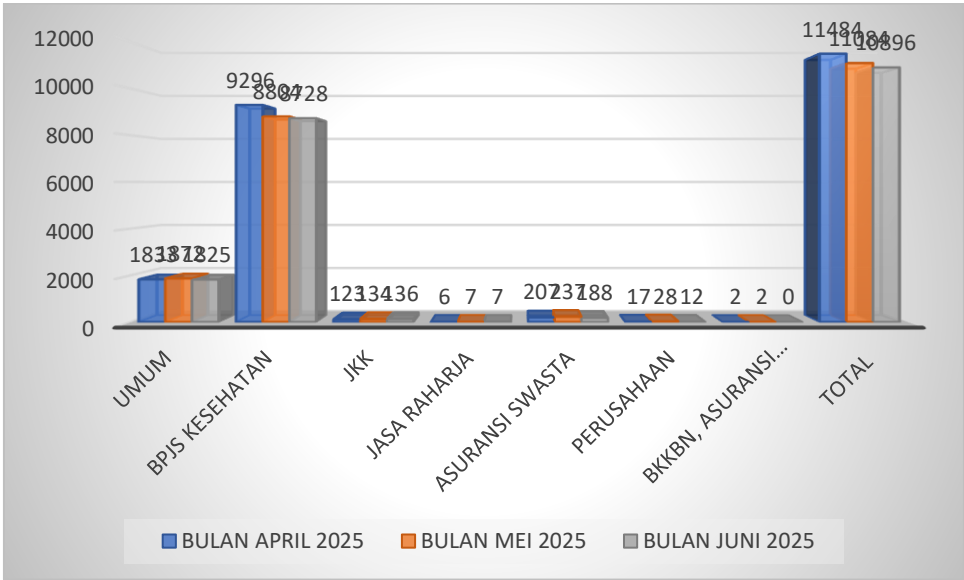
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli sakura
3. Menambah jam HFIS untuk poli pedodonti sehingga akan menambah jumlah pasien
4. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
5. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
6. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
7. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
8. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
9. Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS,bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura
10. Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
11. Mengajukan pelayanan baru otho,bedah,uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN APRIL 2025	%	BULAN MEI 2025	%	BULAN JUNI 2025	%
1	Umum	1833	15,96%	1872	16,89%	1825	16,75%
2	BPJS Kesehatan	9296	80,95%	8804	79,43%	8728	80,10%
3	JKK	123	1,07%	134	1,21%	136	1,25%
4	Jasa raharja	6	0,05%	7	0,06%	7	0,06%
5	Asuransi swasta	207	1,80%	237	2,14%	188	1,73%
6	Perusahaan	17	0,15%	28	0,25%	12	0,11%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	2	0,02%	2	0,02%	0	0
	Total	11484	100%	11084	100%	10896	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien bulan Juni 2025 berdasarkan cara pembayaran menurun 1,69% dari bulan mei 2025 . Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 80,10%. Kunjungan bpjs meningkat di bandingkan bulan mei 2025 dikarenakan untuk pasien umum dan asuransi menurun di bulan juni 2025

Kunjungan terendah berdasarkan cara pembayaran kunjungan asuransi pemerintah dengan tidak ada kunjungan

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

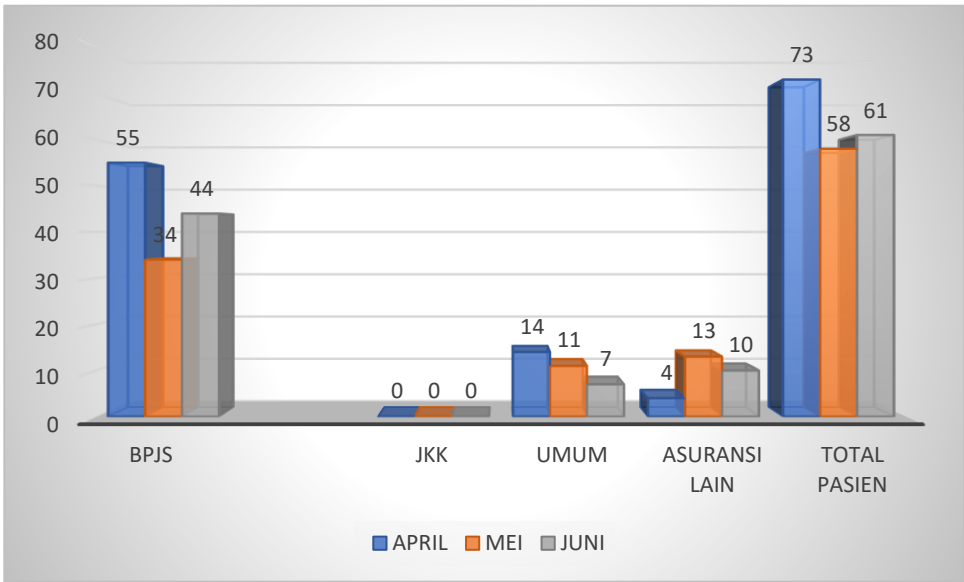
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	55	34	44	↑ 29,4%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	14	11	7	↓ 36,3%
4	Asuransi Lain	4	13	10	↓ 23,0%
Total Pasien		73	58	61	↑ 20,5%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (April - Juni 2025)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANS I	
1	Juni 2025	44	7	0	10	61
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni meningkat 29,4% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan dari di IGD banyak yang naik kelas dan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juni mengalami penurunan 36,3% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan IGD yang masuk VIP dan VVIP	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum ada pasien untuk bulan juni pasien di irna 2c tidak ada untuk cara bayar jkk	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni mengalami penurunan 23,07% dari bulan sebelumnya	Total pasien bulan juni 2025 mengalami peningkatan 5,17% (3 pasien) dari bulan sebelumnya

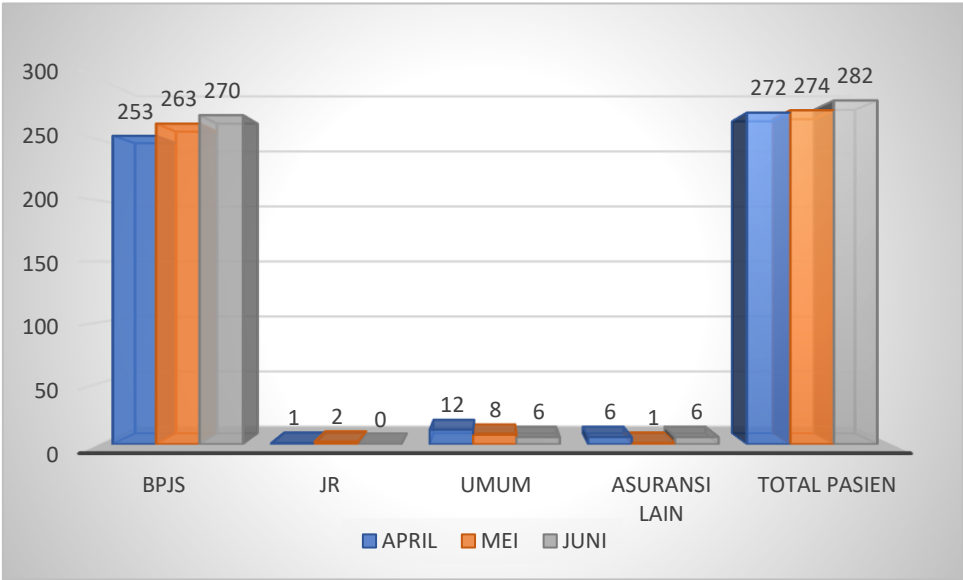
		pasien VIP dan VVIP meningkat	menurun dengan penjamin umum			
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran 2. Rencana penambahan VVIP 1 TT 3. Memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP 4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap 5. Bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru 6. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien 7. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (April - Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	253	263	270	↑ 2,6%
2	JR	1	2	0	↓ 100%
3	Umum	12	8	6	↓ 33,3%
4	Asuransi Lain	6	1	6	↑ 83,3%
Total Pasien		272	274	282	↑ 2,8%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

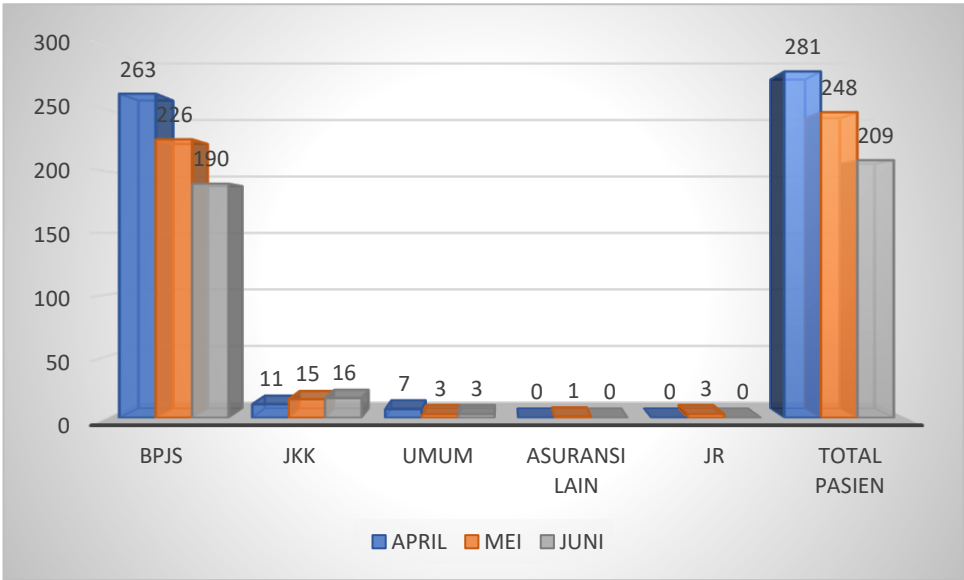
NO.	BULAN JUNI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 2,6% dari bulan mei 2025 di sebabkan kunjungan dari IGD terutama diagnose tf dan df pasien anak meningkat dan banyaknya pasien yang MRS saat periksa di rawat jalan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir menurun, untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 33,3% dari bulan sebelumnya di sebabkan pasien menggunakan cara bayar BPJS	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 83,3% dari bulan sebelumnya	Total keseluruhan bulan juni mengalami peningkatan 2,8% dari bulan mei 2025 (8 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Program taman anak-anak harus di terealisasikan di irna anak untuk tahun ini 5. Berkoordinasi dengan Marketing untuk kunjungan ke TK atau paud tentang pelayanan gigi anak baru				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	263	226	190	↓ 15,92%
2	JKK	11	15	16	↑ 6,66%
3	Umum	7	3	3	0%
4	Asuransi Lain	0	1	0	↓ 100%
5	JR	0	3	0	↓ 100%
Total Pasien		281	248	209	↓ 25,62 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

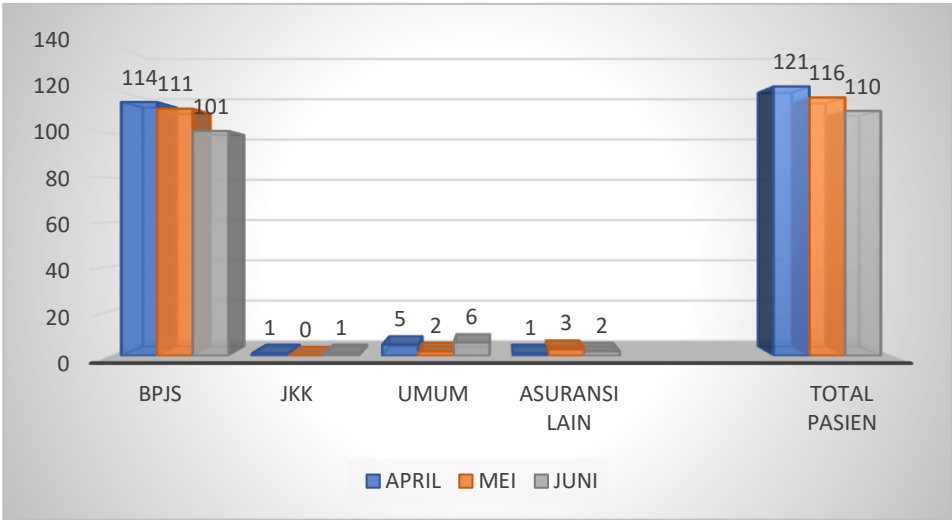
NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Juni 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan pasien khususnya kelas 2 untuk bulan juni mengalami penurunan 15,92% dari bulan sebelumnya disebabkan kunjungan di IGD menurun terutama pasien dengan BPJS kelas 2	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni mengalami stagnan dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk kunjungan bulan juni mengalami peningkatan 6,6 % dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan rujukan dari perusahaan meningkat dari IGD yang masuk rawat inap	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami penurunan 25,62% (39 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Pemberian edukasi yang baik 7. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	114	111	101	↓10%
2	JKK	1	0	1	↑100%
3	Umum	5	2	6	↑67%
4	Asuransi Lain	1	3	2	↓50%
Total Pasien		121	116	110	↓6%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

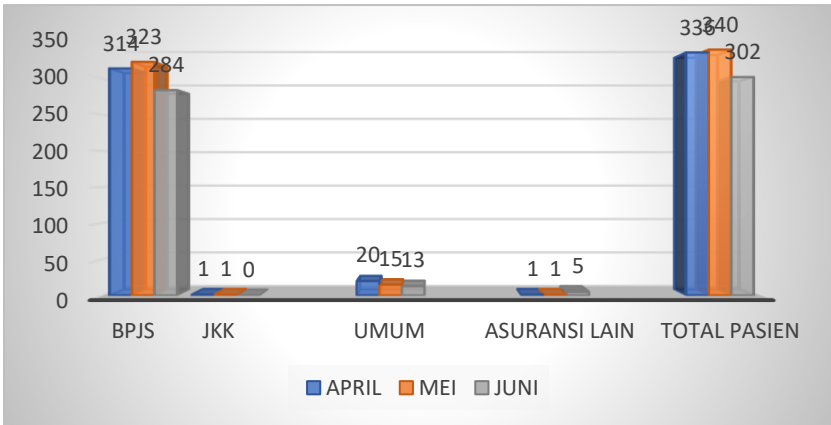
NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juni menurun 10% dari bulan sebelumnya	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni mengalami peningkatan 67% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 50% dari bulan sebelumnya	Pada bulan juni 2025 total pasien mengalami penurunan 6% dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)

NO	PENJAMIN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	314	323	284	↓ 12%
2	JKK	1	1	0	↓ 100%
3	Umum	20	15	13	↓ 13,3%
4	Asuransi Lain	1	1	5	↑ 100%
Total Pasien		336	340	302	↓ 11%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

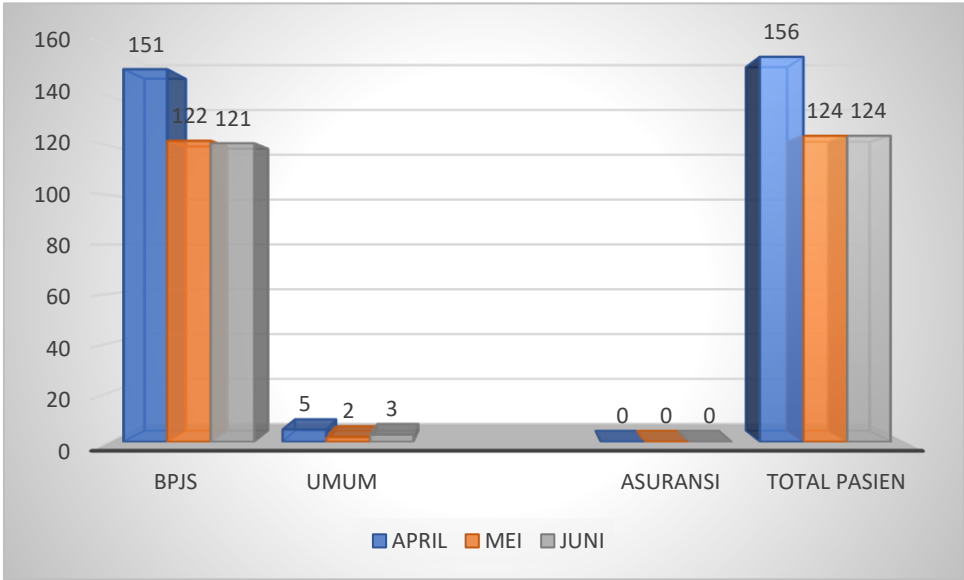
NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir kunjungan di irna 6,7 dan 8 A belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 12% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan di IGD sudah stabil meningkat untuk kelas 3	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir menurun untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 13,3% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juni 2025 jumlah pasiennya menurun 100% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 100% bandingkan bulan sebelumnya	Total semua pasien mengalami penurunan pasien 11 % dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	151	122	121	↓ 0,81%
2	Umum	5	2	3	↑ 33,3 %
3	Asuransi	0	0	0	0%
Total Pasien		156	124	124	0%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO	BULAN JUNI	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian mei 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan mengalami penurunan untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 0,81% dari bulan sebelumnya disebabkan kunjungan yang tindakan obgyn menurun dari IGD dan poli	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 33,3% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien yang lahiran menggunakan asuransi swasta selain BPJS	Total pasien bulan juni 2025 mengalami stagnan dari bulan sebelumnya
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing terutama untuk kunjungan ke	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

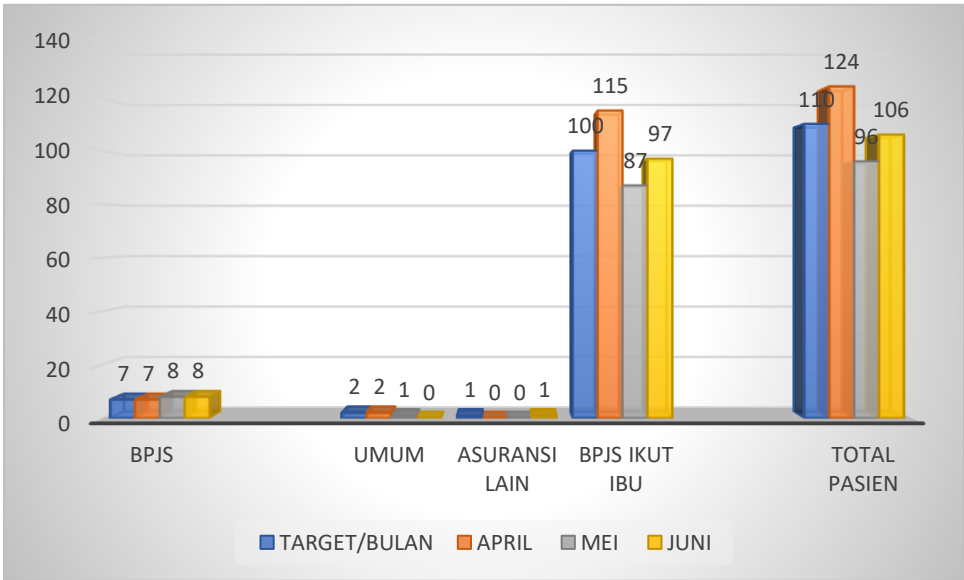
		bidan bidan praktek yang mempunyai BPJS	di maternitas		
--	--	---	---------------	--	--

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	7	8	8	0%
2	Umum	2	2	1	0	↓ 100%
3	Asuransi Lain	1	0	0	1	↑ 100%
4	BPJS IKUT IBU	100	115	87	97	↑ 11,5%
Total Pasien		110	124	96	106	↑ 10,41%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Juni 2025	8	0	1	97	106
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami stagnan dari bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 100% yaitu pasien 1	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 11,5 % dibandingkan bulan sebelumnya	Total pasien dalam bulan juni 2025 mengalami peningkatan 10,41% di bandingkan bulan mei 2025
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai	Meningkatkan pelayanan dan	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai	Meningkatkan pelayanan agar

		tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing	bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing,membuat program foto bayi dari unit neo
--	--	---	--	---	--	--

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

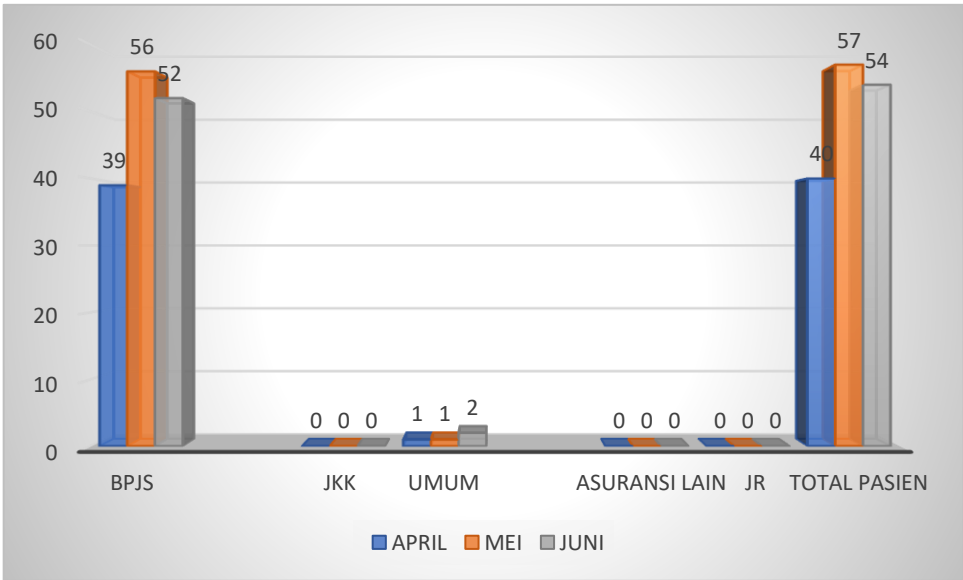
3.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar

(April - Juni 2025)

NO	PENJAMIN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	39	56	52	↑ 42,5%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	1	1	2	↑ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		40	57	54	↓ 5,5%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar

(April -Juni 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 7,80% dibandingkan bulan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan bulan juni mengalami peningkatan 100% 2025 di bandingkan bulan dengan bulan	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 tidak ada kunjungan sama dengan bulan sebelumnya	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien belum stabil untuk bulan juni total pasien menurun 5,5% dibandingkan bulan sebelumnya

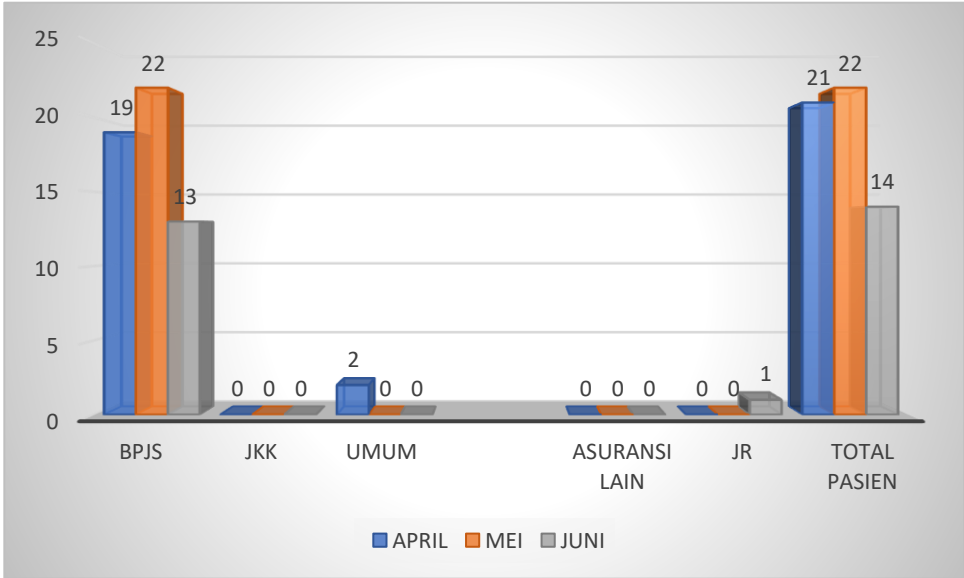
		sebelumnya	sebelumnya			
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	19	22	13	↓ 69,2 %
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	2	0	0	0%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	1	↑ 100%
Total Pasien		21	22	14	↓ 57,1%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

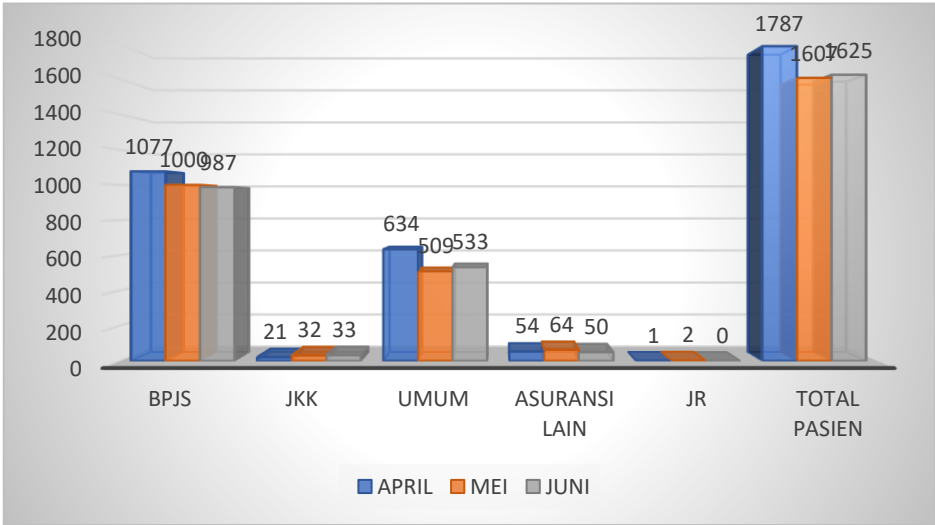
NO.	BULAN JUNI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan tkhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 69,2% di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien bulan juni 2025 mengalami penurunan 57,1% dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1077	1000	987	Type equation h ↓ 1,3%
2	JKK	21	32	33	↑ 3,03%
3	Umum	634	509	533	Type equation h ↑ 4,5%
4	Asuransi Lain	54	64	50	↓28%
5	JR	1	2	0	Type equation h ↓ 200%
Total Pasien		1787	1607	1625	Type equation h 1,1%

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2025)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

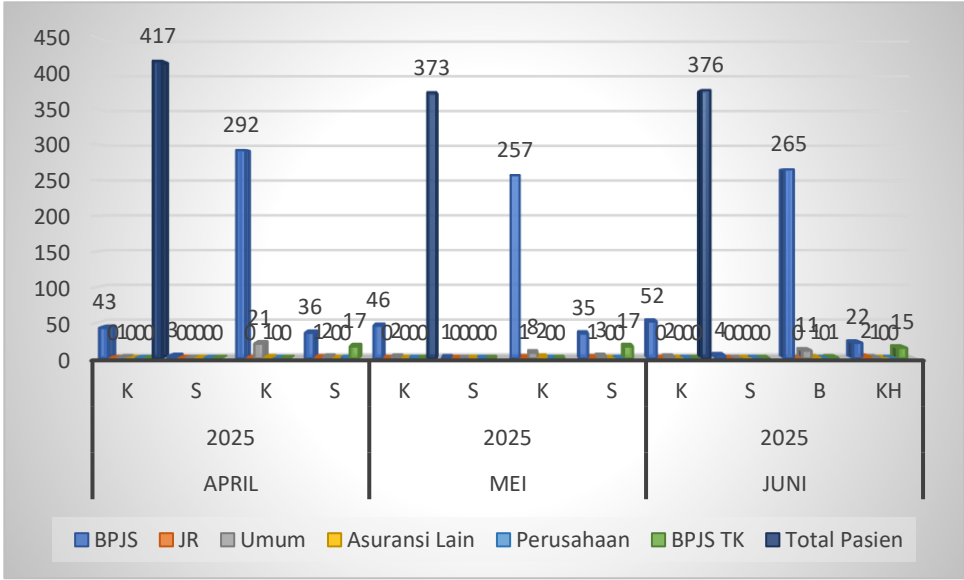
NO.	BULAN JUNI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 1,3% dari bulan sebelumnya di sebabkan penurunan kasus gawat darurat secara umum dan meningkatnya gaya hidup sehat	Kunjungan pasien dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 4,5% dari bulan sebelumnya disebabkan peningkatan pasien umum karena banyaknya fals emergency pasien yang datang ke IGD	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan juni 2025 mengalami peningkatan 3,04% dari bulan sebelumnya di sebabkan banyaknya kunjungan JKK di prima husada ini di bantu oleh marketing yang selalu kolaborasi dengan perusahaan	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 200% dari bulan sebelumnya disebabkan tidak ada pasien KLL yang masuk ke IGD prima husada malang	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan bulan juni 2025 mengalami peningkatan 1,1% dari bulan sebelumnya
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (April-Juni 2025)

NO	HAL	APRIL 2025				MEI 2025				JUNI 2025				MEI 2025
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	43	3	29	36	4	1	25	35	52	4	265	22	Peningkatan 0,79%
2	JR	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	
3	Umum	1	0	21	2	2	0	8	3	2	0	11	1	
4	Asuransi Lain	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	1	15	
	Total Pasien	417				373				376				

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin
(April-Juni 2025)



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JUNI	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS meningkat 1,1% dari bulan sebelumnya	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan operasi belum stabil untuk bpjs TK menurun untuk bulan juni 5,8%, di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan juni 2025 mengalami penurunan 7,8% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir stagnan tidak ada operasi selama 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk juni 2025 mengalami penurunan 25% di bandingkan bulan sebelumnya	Total pasien untuk bulan juni 2025 meningkat 0,7% di bandingkan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vynil 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

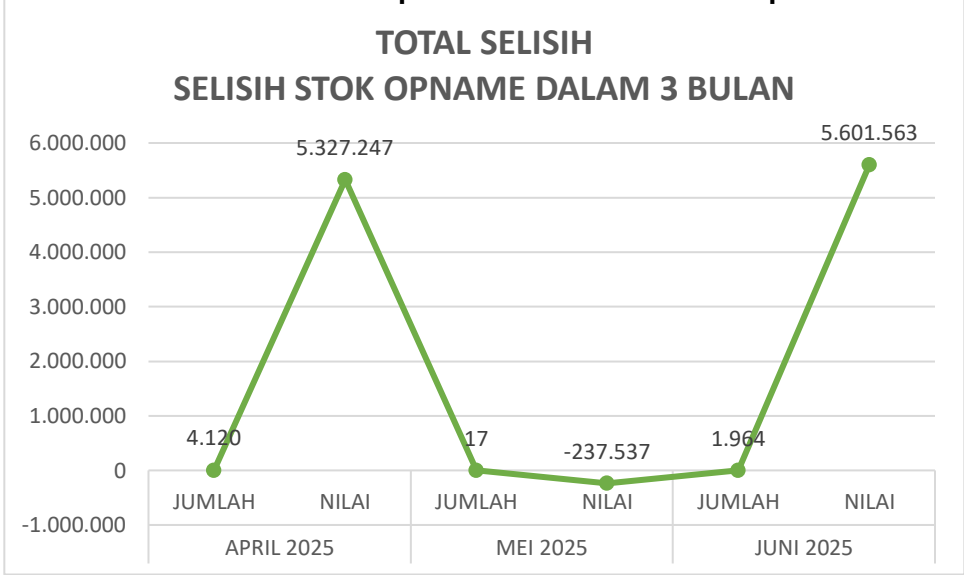
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi April - Juni 2025

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN					
		APRIL 2025		MEI 2025		JUNI 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	965.498	1.728.454.181	925.158	1.698.286.012	1.026.778	1.713.691.456
	SISTEM	965.498	1.728.454.181	925.120	1.697.960.945	1.026.751	1.713.581.456
	SELISIH	0	0	38	+325.067	27	+110.000
DEPO FARMASI	FISIK	225.599	642.691.694	242.327	721.442.047	296.141	744.906.778
	SISTEM	221.475	635.531.901	242.338	721.932.977	294.212	739.557.458
	SELISIH	4.126	7.159.787	-11	-490.932	1.929	+5.349.316
IKO	FISIK	1.670	81.173.371	2.301	91.020.298	2.5 04	95.918.212
	SISTEM	1.686	83.005.912	2.311	91.091.969	2.4 96	95.775.965
	SELISIH	-6	-1.832.540	-10	-71.672	8	+142.248
TOTAL SELISIH		4.120	+5.327.247	17	-237.537	1.964	+5.601.563

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi April - Juni 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil stok opname pada Bulan Juni 2025 belum mendekati target (+5.601.563), analisisnya sebagai berikut :		
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
GUDANG FARMASI		
Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname belum mencapai target, yaitu sebesar +Rp 110.000.		
Analisa :		
1.	F00395 Isoniazid tab 300 mg – holipharma rak hibah, terdapat selisih lebih 26 tab, dikarenakan ketidaktelitian pada saat perhitungan SO.	1. Meningkatkan ketelitian petugas dalam melakukan perhitungan SO. 2. Validasi ulang oleh apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi setelah di lakukan verifikasi oleh PT.
2.	F02628 Manset tensi dewasa 2 selang – abn rak alkes, terdapat selisih lebih 1 pcs karena kesalahan input SO, tidak ada konfirmasi dan perhitungan ulang dari PT. Hasil selisih diketahui saat laporan SO di terima oleh RS. Petugas : Evan	Membuat berita acara penyesuaian Hasil Stok Opname Periode Bulan Juni Tahun 2025 agar nilai persediaan selisih antara stok fisik dan stok SIMRS

		sesuai dan jumlah di sistem sesuai fisik.
3.	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
DEPO FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +Rp 5.349.316, hal ini disebabkan karena :		
1.	Kartu stok sebagian sudah berjalan	Supervisi secara berkala
2.	Kesalahan dalam perhitungan buffer stok tidak terhitung saat stok opname bulan Juni 2025 : F00280 Erdosteine caps 300 mg - ogb novell = +147 F00429 Lansoprazole caps 30 mg - hexpharm jaya = +324 F00709 Simvastatin tab 20 mg - hexpharm jaya = +155	1. Perbaikan penataan ulang buffer stok sesuai rak di ruang buffer stok (sesuai alfabetis dan penggolongan obat). Penambahan lemari buffer stok di ruang buffer agar buffer tidak di tumpuk di dalam kardus
3.	Ketidaksesuaian dalam proses INPUT (tidak menulis perubahan jumlah di resep) dan SIAP menyebabkan kesalahan dalam jumlah obat yang disiapkan, yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan double check dengan penerima obat : F00190 Cetirizine hcl tab 10 mg - hexpharm jaya = +51 F00836 Vitamin b6 tab 10 mg - trifa = +59 F00332 Gabapentin tab 300 mg - hexpharm jaya = +60 F04514 Cairan inf NS 0.9% 500 ml – satoria = +33 F04697 Cairan inf RL 500 ml – satoria = +46	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala 3. Monitoring dan evaluasi oleh kabin Jangmed terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. □ jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki
4.	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS, seperti : F01991 Sput 3 cc – gidcare = +29 F01992 Sput 5 cc – gidcare = -5 F00413 Ketorolac inj 30 mg 1 ml - hexpharm jaya = +11 F00563 Omeprazole caps 20 mg - hexpharm jaya = -1 F04639 Ondansetron inj 4 mg/2 ml - hexpharm jaya = +1 F00996 Blood transfusi set – Otsuka = +3	1. Penegakan kembali kepada perawat IGD terkait kewajiban penulisan resep yang sesuai □ kolaborasi dengan Karu IGD. 2. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan □ supervise oleh kains farmasi. 3. Perbaikan alur resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan di share di Grup dan meminta bukti inputan.
5.	Ketidaksesuaian antara inputan resep dan barang yang diberikan disebabkan perbedaan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran yang digunakan, seperti: c. F00090 Borraginol- s supp – takeda = -10 d. F00089 Borraginol- n supp – takeda = +10	1. Memperbaiki sistem pengeluaran barang dari gudang ketika ada nama barang sama namun beda pabrik dengan memastikan stok depo

		dihabiskan terlebih dahulu sebelum dinonaktifkan. 2. Sosialisasi kepada perawat perbaikan fitur pencarian dalam SIMRS untuk meningkatkan akurasi pemilihan barang. 3. Memperbaiki sistem penyiapan barang bertanggungjawab atas input penjualan.
6.	Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS oleh perawat IRNA sementara pasien sudah KRS).	1. Dilakukan pemahaman kembali proses return sesuai alur dan dilakukan supervisi berkala oleh Karu IRNA dan PJ Shift ruangan untuk mengontrol terkait proses return ke farmasi sesuai dengan alur yang sudah di sepakati 2. Melakukan double crosscheck oleh petugas farmasi saat akan melakukan return di supervisi setiap hari oleh kains farmasi 3. Melakukan audit dan evaluasi berkala oleh Kabid keperawatan dan Kabid penunjang terkait obat-obatan yang belum tereturn sesuai dengan alur
7.	F00581 Osflex inj 25 mg/25 ml – novell rak kulkas terdapat selisih lebih 12 vial. Hasil telusur ditemukan: • Stok awal OSFLEX INJ 25 MG/25 ML - NOVELL 147 vial yang ada di depo farmasi. • Pada pukul 14.00 3 vial sudah diambil oleh poli (praktek dr. Farid, Sp.S). • PJ rak (Wisnu) hitung stok sebanyak 144 vial di depo + 3 vial di poli = 147 vial. • Poli mengembalikan stok osflex 3 vial yang tidak terpakai pada pukul 19.00 diterima oleh Aulia (PJ input) kemudian ditambahkan kertas kerja 3 vial total 150 vial (tanpa hitung ulang). • PJ input stok 150 vial sehingga muncul selisih lebih 3 vial. • Keuangan PT konfirmasi hitung ulang sebanyak 159 vial (petugas salah menambahkan stok FS 10 vial yang seharusnya oxytocin inj tapi ditulis di kolom kertas kerja osflex sehingga menimbulkan selisih lebih). • Pada hari minggu PJ rak melakukan telusur dan dilakukan perhitungan ulang sebanyak 147 vial (tidak ada mutasi). Petugas : Aulia	Membuat berita acara penyesuaian Hasil Stok Opname Periode Bulan Juni Tahun 2025 agar nilai persediaan selisih antara stok fisik dan stok SIMRS sesuai dan jumlah di sistem sesuai fisik.
8.	F02985 Vaseline album – Brataco selisih lebih 602 gram karena termasuk barang untuk racikan salep sesuai peresepan dokter namun farmasi menyiapkan	Dilakukan pemahaman kembali proses penyiapan racikan salep vaselin album sesuai alur (ditimbang pada timbangan digital sesuai peresepan dokter)

	tidak di timbang pada timbangan digital sehingga terjadi selisih lebih (menyesuaikan ukuran pot salep).	dan dilakukan supervisi berkala oleh Kains Farmasi.
9.	F03261 Koni E caps 400 - konimex rak obat oral paten pada system 90 kapsul, namun pada fisik jumlah 0. Sedangkan SO pada bulan mei 2025 sediaan tetap 90 kaps dan tidak ada mutasi keluar. Petugas : Pipin, Rika, Lolita, Noviati.	Hasil ditelusur ditemukan petugas salah input ED pada SO mei 2025 seharusnya ED 04-2025 sehingga dilakukan pemusnahan obat. Tidak ada mutasi karena tidak ada DPJP yang meresepkan (SE obat near ED sudah di edarkan).
10.	Ketidaksesuaian release barang dari Gudang farmasi sehingga terjadi selisih kurang di depo farmasi, seperti : F00779 Ursodeoxycholic acid caps 250 mg - ogb dexa = -127 F00735 Tekasol ointment cr 10 g – sdm = +5	1. Double check dilakukan oleh petugas Depo yang meminta dengan melihat kertas kerja obat dan BMHP yang telah di release oleh Gudang farmasi. Penggunaan scan barcode atau RFID □ follow up ke programmer terkait dengan program scan barcode
11.	Terdapat selisih minus dikarenakan petugas tidak menambahkan di lembar kerja. Resep masuk pukul 18.46 dan resep tidak bisa diinput pukul 18.46 karena resep sudah di lock (petugas menyiapkan obat namun di lembar kerja tidak ditambahkan), kemudian resep disimpan pukul 22.40 setelah SO, seperti : F00609 Phenytoin sodium kaps 100 mg – ikapharmindo = -90 F00290 Eterlox tab 500 mg – novell = -60 Petugas : Adelia	Meningkatkan ketelitian petugas saat perhitungan SO dan validasi ulang oleh pj input setelah verifikasi SO.
12.	Stok paket dan box emergency tidak terhitung pada SO bulan April 2025, seperti : F00668 Repacor inj 40 mg - dexa medica = +6 F00328 Furosemide inj 20 mg / 2 ml - ogb dexa = +48 F00030 Aminophylline inj 24 mg/ml – phapros = +15 Petugas: Asharul, Achmad Nur	Dilakukan pemahaman kembali pelaksanaan SO bahwa semua stok paket, FS, dan box emergency di tulis terpisah stoknya di lembar kerja tanpa akumulasi jumlah stok paket, FS, box emergency dengan jumlah stok yang ada di depo.

FLOORSTOK IKO

Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar **+Rp 142.248**, hal ini disebabkan karena :

1.

Ditemukan 8 item barang IKO yang selisih lebih masing-masing satu. Setelah di cek di monitoring stok terdapat anomali selisih dimana monitoring stok (sis akhir) dengan stok sistem SO tidak sama, seperti :

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Jml. Fisik	Jml. SIMRS		
					Monitoring Stok	Stok Mutasi	Laporan SO
1	F00666	REGIVELL SPINAL INJ 05% - NOVELL	AMP	19	19	19	18
2	F01980	SPINOCAIN NO 27 - B BRAUN	PCS	24	24	24	23
3	F00277	EPHEDRINE HCL INJ 1 MG / 1 ML - MAHAKAM	VIAL	21	21	20	20
4	F04608	TOXFEN INJ - MAHAKAM	AMP	10	10	10	9
5	F01433	HANDSCOON STERIL 7.5 - SAVEGLOVE	PSG	48	48	47	47
6	F00632	PRIMPERAN INJ - SOHO	VIAL	9	9	9	8
7	F01993	SPUIT 5 CC - TERUMO	PCS	88	88	88	87
8	F01439	HANSAPLAST JUMBO BEIERSDORF	PCS	19	19	19	18

Koordinasi dengan progamer PT untuk telusur. Hasil tindak lanjut progamer memperbaiki sistem stok mutasi.

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (April - Juni2025)

NO	KODE	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA BELI	TANGGAL EXPIRED	NO BATCH	JUMLAH FISIK BAIK (BULAN)			TOTAL HARGA	LAPORAN PENJUALAN 1 TAHUN TERAKHIR
							APRIL	MEI	JUNI		
1	F00542	Ntg inj 1 mg/ml - ferron	Vial	65.000	30/07/2025	BN4832412A	16	16	16	1.040.000	31

2	F00030	Aminophylline inj 24 mg/ml - phapros	Amp	4.000	30/08/2025	66307030-1	29	11	7	28.000	256
3	F00307	Ferriprox tab 500 mg - apotex inc	Tab	35.100	30/08/2025	ry1625	194	94	94	3.299.400	0
4	F00603	Perossal 2x6 - dipa pharmala b	Pcs	231.000	30/08/2025	22HA14780	10	12	12	2.772.000	87
5	F00726	Susuk kb II (levonorgestrel 75 mg)	Pcs	-	31/08/2025	0100017	15	15	15	0	0
6	F00228	Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml - mersi	Btl	2.773	30/09/2025	A21797	64	53	43	119.239	268
7	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/09/2025	76122032	14	13	10	2.800.000	21
8	F01680	Nelaton cath no 12 - rusch	Pcs	16.500	30/09/2025	KMA2030441	1	1	1	16.500	1
9	F00607	Phenobarbital tab 30 mg - kimia farma	Tab	200	30/09/2025	I31729N	10	10	10	2.000	90
10	F04623	Tobramycin eye drop 5 ml - ferron	Btl	15.856	30/09/2025	4630910	40	20	43	681.808	48
11	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	Pcs	222.000	30/10/2025	KMF20I2362	4	4	5	1.110.000	5
12	F00586	Oxoferin sol 30 ml - pharos	Btl	80.500	30/10/2025	B3K953C	7	7	7	563.500	10
13	F01390	Foley cath no 20 - rusch	Pcs	20.570	30/11/2025	P20L04	24	24	24	493.680	17
14	F00313	Flamar ed 5 ml - sanbe	Flash	40.550	15/12/2025	DM3521	81	75	61	2.473.550	62
Total										15.399.677	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Juni - Desember 2025)

Analisis	Tindak Lanjut
Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Juni - Desember 2025 karena obat dan alkes slow moving: 1. Ntg inj 1 mg/ml - ferron, indikasi untuk mengontrol hipertensi dengan cepat selama pembedahan jantung, menurunkan tekanan darah dan menjaga hipotensi yang terkontrol selama pembedahan, mengontrol iskemia miokard selama dan setelah pembedahan, Gagal jantung kongestif yang tidak responsif karena infark miokard akut, Angina tidak stabil yang sulit disembuhkan dengan beta blocker dan nitrat sublingual. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/06/2024 dari distributor sejumlah 10 amp. 2. Aminophylline inj 24 mg/ml – phapros, untuk mengatasi serangan asma bronkial. Pembelian terakhir tanggal 27/11/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 30 ampul. Penggunaan obat slow moving tapi termasuk obat emergency. 3. Ferriprox tab 500 mg - apotex inc untuk terapi kelebihan Fe (zat besi) pada pasien talasemia mayor. Faktur pembelian terakhir tanggal 21/02/2021 dari distributor sejumlah 300 tablet. Penggunaan obat death moving karena obat tidak bisa di klaim obat kronis di FKRTL. 4. Perossal 2x6 - dipa pharmlab merupakan material sintetik pengganti tulang yang resorbable, digunakan untuk pengisian atau rekonstruksi tulang pada tulang yang rusak. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/01/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 5. Susuk kb II (levonorgestrel 75 mg) diberikan untuk kontrasepsi. Penggunaan KB slow moving. Penerimaan hibah dari BKKBN dengan ed < 1 tahun pada tanggal 31/07/2024 sejumlah 16 pcs. 6. Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml – mersi untuk infeksi saluran nafas, kulit, saluran kemih dan kelain, gastrointestinal, infeksi THT. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/12/2024 dari distributor sejumlah 30 botol. 7. Dj stent 6 fr close end – medika dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs. 8. Phenobarbital tab 30 mg - kimia farma, digunakan untuk mengobati atau mencegah kejang. Peresepan terakhir tanggal 01/04/2023 penggunaan obat jadi death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 16/02/2024 dari distributor sejumlah 100 tab. 9. Tobramycin eye drop 5 ml – ferron, digunakan untuk mengatasi iritasi mata akibat infeksi bakteri. Faktur pembelian terakhir tanggal 18/02/2025 dari distributor sejumlah 40 botol, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 10. Foley cath silicon no 8 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/03/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. 11. Oxoferin sol 30 ml – pharos digunakan untuk luka terinfeksi, penyembuhan luka yang lambat sesudah traumatik atau sesudah operasi, ulkus decubitus, ulkus kaki kronis pada insufisiensi vena, ulkus dan luka akibat aliran darah erteri,	1. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 2. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 4. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. 5. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS, untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk diresepkan.

ulkus diabetic, ganggren, luka bakar. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/02/2024 dari distributor sejumlah 3 botol. 12. Suction cath no. 8 digunakan untuk pembersih jalan nafas pada saluran sistem pernafasan, dengan cara penyedotan untuk mengeluarkan cairan berlebih khususnya pada daerah oropharyngeal dan nasopharyngeal. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/03/2023 dari distributor sejumlah 10 pcs. 13. Foley cath no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/09/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 14. Flamar ed 5 ml – sanbe Mengatasi nyeri, bengkak, kemerahan, dan silau yang timbul setelah operasi mata, seperti operasi katarak atau lasik. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/02/2024 dari distributor sejumlah 72 flash.	
--	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah TTK/ apoteker	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

														terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	
3	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
5	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan pember	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi	Meninjau ulang kemampu

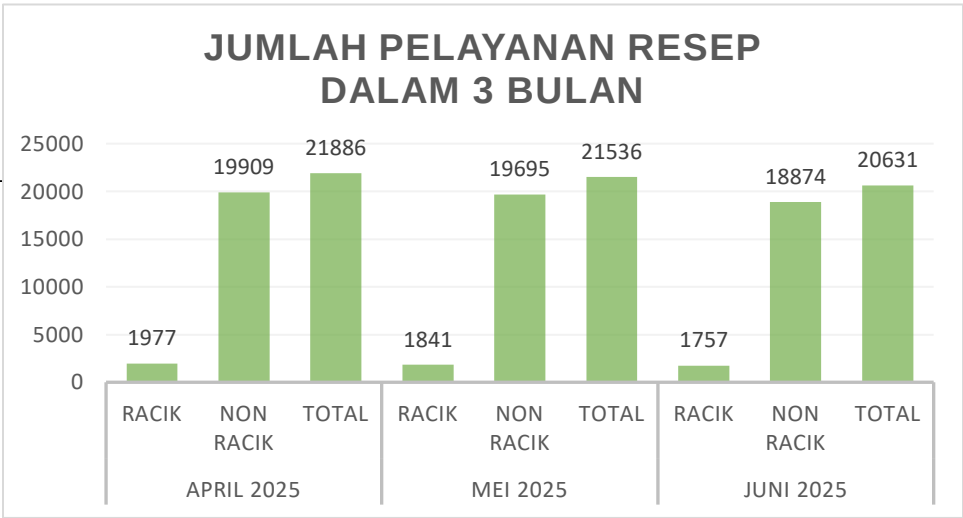
					ian obat pada pasien									pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	an dan kompeten si petugas
7	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebih an/ kekura ngan penyer ahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkin an besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampu an dan kompeten si petugas
8	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebih an/ kekura ngan penyer ahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkin an besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampu an dan kompeten si petugas

9	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Juni 2025

UNIT	JUMLAH RESEP					
	APRIL 2025		MEI 2025		JUNI 2025	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
IRNA	207	9245	164	9011	146	8274
IRJA	1676	7533	1590	7611	1512	7322
IKO	0	1058	0	1045	0	996
IGD	94	2073	87	2028	99	2282
TOTAL	1977	19909	1841	19695	1757	18874
JUMLAH RESEP OBAT	21.886		21.536		20.631	

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan April - Juni 2025



Analisis :

Secara keseluruhan total resep pada Bulan Juni 2025 mengalami penurunan namun tidak signifikan, hal ini sebanding dengan penurunan kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan. Penurunan yang tidak signifikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1. Jumlah pasien baru tidak banyak.
- 2. Target PRB rawat jalan juga tetap berjalan, dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil dan retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien.
- 3. Penurunan resep rawat jalan tidak signifikan dikarenakan pasien dr Heriyatmo, Sp.PD tetap dikunjungi iterisasi meskipun dokter sedang off selama sebulan.
- 4. Tidak ada promo Poli Sakura dan subsidi PRIMANTARA pada Bulan Mei 2025.
- 5. Terdapat batasan inacbgs sehingga tidak semua obat dapat dicover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi. Evaluasi pelayanan ODD.
- 3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriksi yang ditentukan.
- 4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.

5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan April - Juni 2025

NO	KEGIATAN	STANDARD	PENCAPAIAN			KETERANGAN
			APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	
1.	Pengkajian Resep	100%	98.83%	98.86%	98.61%	Jumlah pengkajian resep, yaitu Januari 2025 = 22.046 Februari 2025 = 20.361 Maret 2025 = 20.922 April 2025 = 21.886 Mei 2025 = 21.536 Juni 2025 = 20.631 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep, yaitu Januari 2025 = 128 Februari 2025 = 168 Maret 2025 = 180 April 2025 = 255 Mei 2025 = 246 Juni 2025 = 287
2.	Dispensing sediaan steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di Ruang Pencampuran Obat Steril (LAF).
3.	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4.	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ditemukan pelaporan efek samping obat pada Bulan April 2025.
5.	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep obat yang ditandatangani oleh penerima obat.
6.	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di Lembar Edukasi (pasien rawat inap) dan tanda-tangan penerima obat di resep (pasien rawat jalan).

7.	Pemantaua n Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8.	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar. Dilakukan pada hari Kamis, 27-03-2025 dengan dr Adhya Aji, Sp.PD.
9.	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh Apoteker di RM.
10.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape.
11.	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	30	42	59	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur, sudah tidak ada subsidi pengantaran obat gratis.

3.2.1.10 **Tabel Analisa dan Tindaklanjuti Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Juni 2025**

KINERJA	ANALISA	TINDAKLANJUT
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan Juni 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Mei 2025 sebanyak 98.86% dan bulan Juni 2025 sebanyak 98.61%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : 1. Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. 2. Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. 3. Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh Apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh Apoteker.	1. Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS. 2. Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). 3. Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

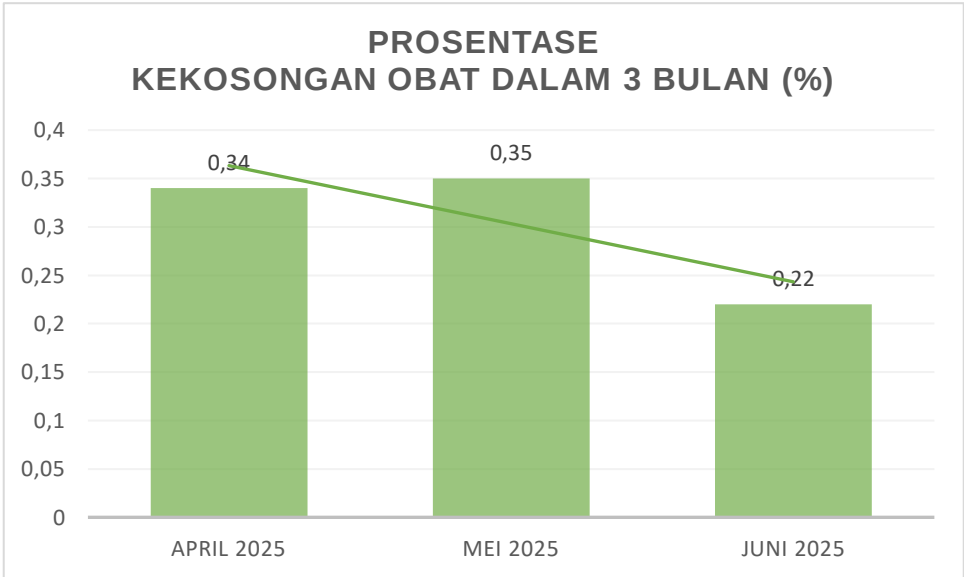
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Juni 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. - Menganalisa laporan ESO. - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di Nurse Station atau di Poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan Juni 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Mei 2025 sebanyak 42 dan bulan Juni 2025 sebanyak 59. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam dan keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama.	- Admin primantara tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

3.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada April - Juni 2025

NO	TANGGAL	NAMA OBAT	GOLONGAN OBAT	DISTRIBUTOR	TINDAK LANJUT
APRIL 2025					
1.	1/4/2025-31/4/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/4/2025-	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra	Soroquin tab 200 mg

	31/4/2025			Sembada	
3.	1/4/2025-31/4/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4.	1/4/2025-31/4/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
Total prosentase April 2025 = 0.34%					
MEI 2025					
1.	1/5/2025-31/5/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/5/2025-31/5/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3.	1/5/2025-31/5/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4.	1/5/2025-15/5/2025	Ketoprofen tab 100 mg	Analgesik	PT. Antar Mitra Sembada	Tanpa saran substitusi
Total Prosentase Mei 2025 = 0.35%					
JUNI 2025					
1.	1/5/2025-31/5/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/5/2025-31/5/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3.	1/5/2025-31/5/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4.	1/5/2025-15/5/2025	Santagesik inj 1 gr	Analgesik	PT. Bina San Prima	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juni 2025 = 0.22%					

3.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada April - Juni 2025



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- 4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- 5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

3.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Mei 2025

NO	KEGIATAN	NAMA OBAT/ BMHP/ ALAT KESEHATAN	JUMLAH	ALASAN	KETERANGAN
1.	Pemusnahan	Koni-e Kapsul	90 kapsul	Obat expired date 04/2025, no batch APR23A01	Pemusnahan obat dilakukan tanggal 02 Juni 2025. Tempat dilakukan pemusnahan : Spoelhook laboratorium. Dilengkapi berita acara pemusnahan obat yang diketahui oleh Kabid Penunjang dan Direktur RS.
2.	BMHP/Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	IV Canulla no. 24 - Hospitech	Semua yang terpakai	Pada nylon jarum bocor. No. Batch : 3208324G	Form keluhan alat kesehatan substandard dari ruang 3C dilaporkan tanggal 16/05/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. Tindak lanjut dari Hospitech diganti dengan no batch yang baru.
3.	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Juni 2025

NO	MONITORING DAN EVALUASI	HASIL	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.
2.	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/ hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP

		c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ																																			
3.	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari.																																		
4.	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 2 pada Bulan April Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : <table><tr><th>No</th><th>Temuan obat near ED < 6 bulan</th><th>Pergantian obat near ED</th></tr><tr><td>1.</td><td>Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25, Infus Manitol 8/25, Valisanbe inj 12/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26, Infus Manitol 1/26, Valisanbe inj 7/26.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Trolley emergency IGD: Aminophillylin inj 8/25, Inzana tab 9/25, Dexametason inj 12/25, Dopamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Furosemid inj 9/26, Infus D5% 8/25, Valisanbe inj 10/26.</td><td>Aminophillylin inj 2/26, Inzana tab 1/27, Dexametason inj 6/26, Dopamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 8/26, Valisanbe inj 10/26.</td></tr><tr><td>6.</td><td>Box emergency infant Ponek IGD: Aminophyllin inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Diazepam Rectal 8/25, Dobutamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Suction cath no. 8 10/25.</td><td>Aminophyllin inj 9/28, Dexamethason inj 6/26), Diazepam Rectal 8/26, Dobutamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Suction cath no. 8 12/28.</td></tr><tr><td>7.</td><td>Box HPP – Eklamsi IGD: Eklamsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP SET : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28</td><td>Eklamsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP set : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28</td></tr><tr><td>8.</td><td>Kit emergency IGD 1: Lidocain inj 9/25, Spuit</td><td>Lidocain inj 12/28,</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut :</td></tr><tr><td>a.</td><td>Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari.</td></tr><tr><td>b.</td><td>Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka.</td></tr><tr><td>c.</td><td>Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.</td></tr></table>	No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED	1.	Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.	2.	Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.	3.	Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.	4.	Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25, Infus Manitol 8/25, Valisanbe inj 12/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26, Infus Manitol 1/26, Valisanbe inj 7/26.	5.	Trolley emergency IGD: Aminophillylin inj 8/25, Inzana tab 9/25, Dexametason inj 12/25, Dopamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Furosemid inj 9/26, Infus D5% 8/25, Valisanbe inj 10/26.	Aminophillylin inj 2/26, Inzana tab 1/27, Dexametason inj 6/26, Dopamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 8/26, Valisanbe inj 10/26.	6.	Box emergency infant Ponek IGD: Aminophyllin inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Diazepam Rectal 8/25, Dobutamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Suction cath no. 8 10/25.	Aminophyllin inj 9/28, Dexamethason inj 6/26), Diazepam Rectal 8/26, Dobutamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Suction cath no. 8 12/28.	7.	Box HPP – Eklamsi IGD: Eklamsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP SET : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28	Eklamsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP set : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28	8.	Kit emergency IGD 1: Lidocain inj 9/25, Spuit	Lidocain inj 12/28,		Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut :	a.	Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari.	b.	Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka.	c.	Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.
No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED																																			
1.	Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.																																			
2.	Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.																																			
3.	Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.																																			
4.	Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25, Infus Manitol 8/25, Valisanbe inj 12/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26, Infus Manitol 1/26, Valisanbe inj 7/26.																																			
5.	Trolley emergency IGD: Aminophillylin inj 8/25, Inzana tab 9/25, Dexametason inj 12/25, Dopamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Furosemid inj 9/26, Infus D5% 8/25, Valisanbe inj 10/26.	Aminophillylin inj 2/26, Inzana tab 1/27, Dexametason inj 6/26, Dopamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 8/26, Valisanbe inj 10/26.																																			
6.	Box emergency infant Ponek IGD: Aminophyllin inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Diazepam Rectal 8/25, Dobutamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Suction cath no. 8 10/25.	Aminophyllin inj 9/28, Dexamethason inj 6/26), Diazepam Rectal 8/26, Dobutamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Suction cath no. 8 12/28.																																			
7.	Box HPP – Eklamsi IGD: Eklamsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP SET : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28	Eklamsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP set : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28																																			
8.	Kit emergency IGD 1: Lidocain inj 9/25, Spuit	Lidocain inj 12/28,																																			
	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut :																																				
a.	Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari.																																				
b.	Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka.																																				
c.	Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.																																				

		3 cc 12/25.	Sput 3 cc 6/29.
9.	Kit emergency IGD 2:		
	Tidak ada obat near ED		-
10.	Box emergency ambulance:		
	Aminophillyne 8/25, Dobutamin inj 8/25, Dopamin inj 8/25, Infus D5% 8/26, Na-Phenytoin inj 1/28, Sput 10 cc 9/29.	Aminophillyne 2/26, Dobutamin inj 12/26, Dopamin inj 12/26, Infus D5% 8/26, Na-Phenytoin inj 1/28, Sput 10 cc 9/29.	
11.	Trolley emergency IKO:		
	Infus D5% 1/26, Infus Gelafusal 8/25, Mannitol 1/26, IV 20 7/26, Amiodaron 2/26, Dopamin 10/25, Valisanbe 8/25, Inzana 11/25, Clopidogrel 3/26, Aminophillin 8/25, Dexametasone 3/26.	Infus D5% 6/26, Infus Gelafusal 4/27, Mannitol 4/26, IV 20 9/29, Amiodaron 1/27, Dopamin 12/26, Valisanbe 10/26, Inzana 02/27, Clopidogrel 12/26, Aminophillin 02/26, Dexametasone 2/27.	
12.	Box emergency infant IKO:		
	Infus Gelafusal 10/25, Infus D10% 12/25, IV 24 11/25, Aminofilin 8/25, Dopamine 10/25, Sput 1cc Terumo 8/25, Sput 3cc Terumo 11/25, Sput 5cc Terumo 3/26, Sput 10cc Terumo 9/25	Infus gelafusal 4/27, Infus D10% 12/26, IV cannul no. 24 6/28, Aminophillin 2/26, Dexamethasone 2/27, Dopamine 12/26, Sput 1 cc Terumo 5/29, Sput 3 cc Terumo 9/29, Sput 5 cc Terumo 8/29, Sput 10 cc Terumo 9/29	
13.	Box HPP-Eklampsi IKO:		
	Tidak ada obat near ED		-
14.	Box emergency 2C:		
	Mannitol 1/26, Clopidogrel 2/26, Aminophillin 8/25, Phenytoin 1/26, Sput 1 cc-Terumo 8/25	Mannitol 6/26, Clopidogrel 6/26, Aminophilli 2/26, Phenytoin 1/28, Sput 1 cc 6/26	
15.	Box emergency ICU:		
	Mannitol 1/26, Aminophillin 8/25	Mannitol 6/26, Aminophillin 2/26	
16.	Box emergency ICU ventilator:		
	Tidak ada obat near ED		-
17.	Box emergency HCU:		
	Aminophillin 8/25, Valisanbe injeksi 12/25, Phenytoin 1/26	Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 11/26, Phenytoin 1/28	
18.	Box emergency 3C anak:		
	Aminophillin 8/25, Aspilet 11/25, Clopidogrel 01/26, Dobutamin 1/26, Dopamin 2/26, Mannitol 1/26, Na. Phenytoin 07/26, Furosemide 6/26, Valisanbe injeksi 1/26, Dexametasone 6/26	Aminophillin 2/26, Aspilet 02/27, Clopidogrel 12/26, Dobutamin 01/26, Dopamin 09/26, Mannitol 01/26, Na. Phenytoin 01/28, Furosemide 11/26, Valisanbe Injeksi 10/26, Dexametasone 02/27	
19.	Box emergency PICU Ventilator:		
	Amiodarone 5/26, Dopamin 2/26, Dexamethasone 2/26	Amiodarone 1/27, Dopamin 12/26, Dexamethasone 2/27	
20.	Box emergency PICU:		
	Asam tranexamat 6/26, Amiodarone 5/26, Furosemide 5/26, Dexamethasone 6/26, Valisanbe 7/26, Infus D10 5/26	Asam tranexamat 12/26, Amiodarone 1/27, Furosemide 11/26, Dexamethasone 2/27, Valisanbe 10/26, Infus D10 12/26	
21.	Box emergency 2A:		
	Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 1/26, Aspilet 6/26, Clopidogrel 6/26	Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 1/26, Aspilet 6/26, Clopidogrel 12/26	
22.	Box emergency 3A:		
	Aminophillin 8/25, Amiodaron 6/26, Aspilet 11/25,	Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Inzana 2/27,	

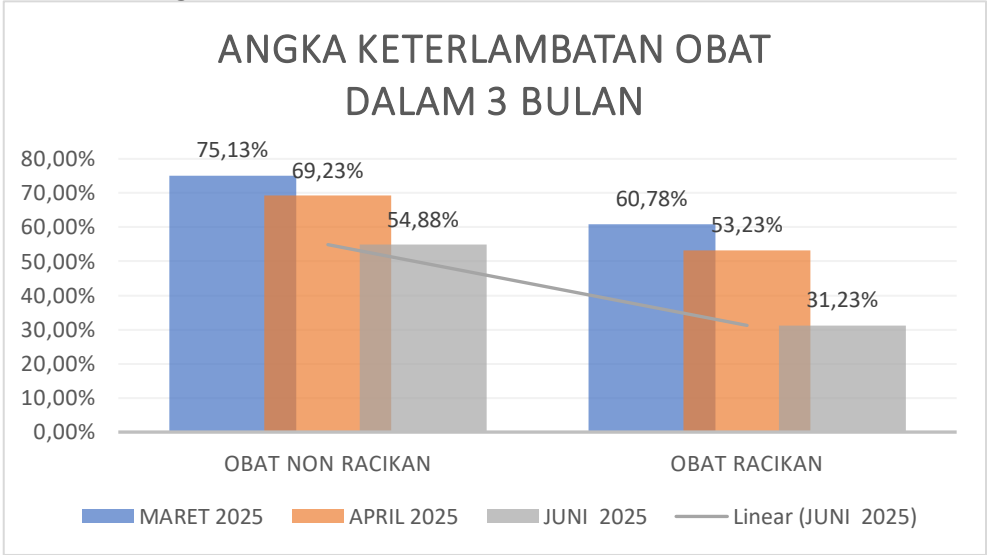
		<table><tr><td></td><td>Dexametasone 6/26, Mannitol 1/26, Valisanbe 10/25, Furosemide 6/26, Dopamine 2/26</td><td>Dexametasone 2/27, Mannitol 6/26, Valisanbe 10/26, Furosemide 12/26, Dopamine 12/26</td></tr><tr><td>23.</td><td colspan="2">Box emergency 4A:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 11/25, Amiodaron 6 /25, Aspilet 1/26</td><td>Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Aspilet 2/27</td></tr><tr><td>24.</td><td colspan="2">Box emergency infant Maternitas:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 8/25, Dexametasone 10/25, Diazepam 9/25 Dopamin 9/25, Sduit 1cc 12/25, Suction Catheter 8 12/25</td><td>Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Diazepam 8/26 Dopamin 01/28 Sduit 1cc 02/28 Suction Catheter 8 05/29</td></tr><tr><td>25.</td><td colspan="2">Trolley emergency Maternitas:</td></tr><tr><td></td><td>Infus D5 9/25, Sduit 5 cc terumo 12/25, Sduit 1 cc terumo 8/25, Aminophillin 8/25, Amiodaron 8/25, Miniaspi 11/25, Dexametasone 10/25, Dopamin 9/25, Na. Phenytoin 7/25, Valisanbe injeksi 12/25, Infus RL 8/25, Iv canule18 10/25, NS 0,9 % 6/25, Misoprostol 11/25</td><td>Infus D5 11/26, Sduit 5 cc terumo 09/29, Sduit 1 cc terumo 12/29, Aminophillin 02/26, Amiodaron 8/26, Miniaspi 07/26, Dexametasone 02/27, Dopamin 02/27, Na. Phenytoin 01/28, Valisanbe injeksi 11/26, Infus RL 8/26, Iv canule18 03/26, NS 0,9 % 1/27, Misoprostol 08/26</td></tr><tr><td>26.</td><td colspan="2">Box emergency infant Perinatologi:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 8/25, Dexmetasone 6/25, Diazepam rectal 9/25, Dobutamin 7/25, Dopamin 9/25, Infus Gelafusal 6/25, Natrium Phenytoin 8/25, Suction Catheter 10/25</td><td>Aminophillin 02/26, Dexmetasone 2/27, Diazepam rectal 9/27, Dobutamin 12/26, Dopamin 09/26, Infus Gelafusal 2/26, Natrium Phenytoin 7/26, Suction Catheter 2/28</td></tr><tr><td>27.</td><td colspan="2">Box emergency 5C:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 8/25 Dexametasone 6/26 Furosemide 6/26 Valisanbe 12/25</td><td>Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Furosemide 11/26 Valisanbe 10/26</td></tr><tr><td>28.</td><td colspan="2">Box emergency 6A:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26</td><td>Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27</td></tr><tr><td>29.</td><td colspan="2">Box emergency 7A:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26</td><td>Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27</td></tr><tr><td>30.</td><td colspan="2">Box emergency 8A:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 8/25 Amiodaron 6/26 Aspilet 11/25 Dexametasone 6/26 Mannitol 1/26 Valisanbe 10/25 Furosemide 6/26 Dopamine 2/26</td><td>Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Inzana 2/27 Dexametasone 2/27 Mannitol 6/26 Valisanbe 10/26 Furosemide 12/26 Dopamine 12/26</td></tr><tr><td>31.</td><td colspan="2">Box emergency Radiologi:</td></tr><tr><td></td><td>Aminophillin 8/25</td><td>Aminophillin 2/26</td></tr></table>		Dexametasone 6/26, Mannitol 1/26, Valisanbe 10/25, Furosemide 6/26, Dopamine 2/26	Dexametasone 2/27, Mannitol 6/26, Valisanbe 10/26, Furosemide 12/26, Dopamine 12/26	23.	Box emergency 4A:			Aminophillin 11/25, Amiodaron 6 /25, Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Aspilet 2/27	24.	Box emergency infant Maternitas:			Aminophillin 8/25, Dexametasone 10/25, Diazepam 9/25 Dopamin 9/25, Sduit 1cc 12/25, Suction Catheter 8 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Diazepam 8/26 Dopamin 01/28 Sduit 1cc 02/28 Suction Catheter 8 05/29	25.	Trolley emergency Maternitas:			Infus D5 9/25, Sduit 5 cc terumo 12/25, Sduit 1 cc terumo 8/25, Aminophillin 8/25, Amiodaron 8/25, Miniaspi 11/25, Dexametasone 10/25, Dopamin 9/25, Na. Phenytoin 7/25, Valisanbe injeksi 12/25, Infus RL 8/25, Iv canule18 10/25, NS 0,9 % 6/25, Misoprostol 11/25	Infus D5 11/26, Sduit 5 cc terumo 09/29, Sduit 1 cc terumo 12/29, Aminophillin 02/26, Amiodaron 8/26, Miniaspi 07/26, Dexametasone 02/27, Dopamin 02/27, Na. Phenytoin 01/28, Valisanbe injeksi 11/26, Infus RL 8/26, Iv canule18 03/26, NS 0,9 % 1/27, Misoprostol 08/26	26.	Box emergency infant Perinatologi:			Aminophillin 8/25, Dexmetasone 6/25, Diazepam rectal 9/25, Dobutamin 7/25, Dopamin 9/25, Infus Gelafusal 6/25, Natrium Phenytoin 8/25, Suction Catheter 10/25	Aminophillin 02/26, Dexmetasone 2/27, Diazepam rectal 9/27, Dobutamin 12/26, Dopamin 09/26, Infus Gelafusal 2/26, Natrium Phenytoin 7/26, Suction Catheter 2/28	27.	Box emergency 5C:			Aminophillin 8/25 Dexametasone 6/26 Furosemide 6/26 Valisanbe 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Furosemide 11/26 Valisanbe 10/26	28.	Box emergency 6A:			Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27	29.	Box emergency 7A:			Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27	30.	Box emergency 8A:			Aminophillin 8/25 Amiodaron 6/26 Aspilet 11/25 Dexametasone 6/26 Mannitol 1/26 Valisanbe 10/25 Furosemide 6/26 Dopamine 2/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Inzana 2/27 Dexametasone 2/27 Mannitol 6/26 Valisanbe 10/26 Furosemide 12/26 Dopamine 12/26	31.	Box emergency Radiologi:			Aminophillin 8/25	Aminophillin 2/26	
	Dexametasone 6/26, Mannitol 1/26, Valisanbe 10/25, Furosemide 6/26, Dopamine 2/26	Dexametasone 2/27, Mannitol 6/26, Valisanbe 10/26, Furosemide 12/26, Dopamine 12/26																																																										
23.	Box emergency 4A:																																																											
	Aminophillin 11/25, Amiodaron 6 /25, Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Aspilet 2/27																																																										
24.	Box emergency infant Maternitas:																																																											
	Aminophillin 8/25, Dexametasone 10/25, Diazepam 9/25 Dopamin 9/25, Sduit 1cc 12/25, Suction Catheter 8 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Diazepam 8/26 Dopamin 01/28 Sduit 1cc 02/28 Suction Catheter 8 05/29																																																										
25.	Trolley emergency Maternitas:																																																											
	Infus D5 9/25, Sduit 5 cc terumo 12/25, Sduit 1 cc terumo 8/25, Aminophillin 8/25, Amiodaron 8/25, Miniaspi 11/25, Dexametasone 10/25, Dopamin 9/25, Na. Phenytoin 7/25, Valisanbe injeksi 12/25, Infus RL 8/25, Iv canule18 10/25, NS 0,9 % 6/25, Misoprostol 11/25	Infus D5 11/26, Sduit 5 cc terumo 09/29, Sduit 1 cc terumo 12/29, Aminophillin 02/26, Amiodaron 8/26, Miniaspi 07/26, Dexametasone 02/27, Dopamin 02/27, Na. Phenytoin 01/28, Valisanbe injeksi 11/26, Infus RL 8/26, Iv canule18 03/26, NS 0,9 % 1/27, Misoprostol 08/26																																																										
26.	Box emergency infant Perinatologi:																																																											
	Aminophillin 8/25, Dexmetasone 6/25, Diazepam rectal 9/25, Dobutamin 7/25, Dopamin 9/25, Infus Gelafusal 6/25, Natrium Phenytoin 8/25, Suction Catheter 10/25	Aminophillin 02/26, Dexmetasone 2/27, Diazepam rectal 9/27, Dobutamin 12/26, Dopamin 09/26, Infus Gelafusal 2/26, Natrium Phenytoin 7/26, Suction Catheter 2/28																																																										
27.	Box emergency 5C:																																																											
	Aminophillin 8/25 Dexametasone 6/26 Furosemide 6/26 Valisanbe 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Furosemide 11/26 Valisanbe 10/26																																																										
28.	Box emergency 6A:																																																											
	Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27																																																										
29.	Box emergency 7A:																																																											
	Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27																																																										
30.	Box emergency 8A:																																																											
	Aminophillin 8/25 Amiodaron 6/26 Aspilet 11/25 Dexametasone 6/26 Mannitol 1/26 Valisanbe 10/25 Furosemide 6/26 Dopamine 2/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Inzana 2/27 Dexametasone 2/27 Mannitol 6/26 Valisanbe 10/26 Furosemide 12/26 Dopamine 12/26																																																										
31.	Box emergency Radiologi:																																																											
	Aminophillin 8/25	Aminophillin 2/26																																																										
5.	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.	1. Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok 2. Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.																																																									
6.	Penvimpanan bahan	Penvimpanan bahan berbahaya dan beracun di	Monitoring dan evaluasi																																																									

	berbahaya dan beracun (B3)	ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3).
7.	Penyimpanan produk steril di unit	Ditemukan perawat anestesi IKO melakukan sharing dose KTM inj dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam.
8.	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	Rawat inap : Double check obat dan bmhp resep ODD (One Daily Dose) dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi ke ruangan rawat inap. Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep dan daftar pemberian obat (DPO) antara farmasi dan perawat/ bidan. Perawat/ bidan penerima obat melakukan double check secara independen dengan PJ Shift/ kepala ruang menggunakan daftar pemberian obat (DPO) sebelum obat diserahkan/ disuntikkan ke pasien secara UDD (Unit Dose Dispensing). Rawat Jalan : Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep antara petugas verifikasi dan petugas penyerah sebelum obat diserahkan ke pasien.	Supervisi secara berkala terkait pelaksanaan double check obat high alert di rawat inap dan rawat jalan

3.2.1.15 Tabel Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Juni 2025

INDIKATOR	BULAN		
	MARET 2025	APRIL 2025	JUNI 2025
Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit	75.13%	69.23%	54.88%
Penyiapan Obat Racikan > 60 menit	60.78%	53.23%	31.23%

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Juni 2025



Analisis :
Waktu tunggu obat rawat jalan pada Bulan Juni Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juni 2025. Namun prosentasi tersebut masih jauh dari target (0%) dikarenakan libur tanggal merah dan poli tutup sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari aktif, kunjungan pasien yang tidak dibatasi sehingga terjadi penumpukan resep di jam-jam tertentu

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
- 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
- 3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
- 4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh Apoteker.
- 5. Terdapat perubahan jadwal penyiapan obat rawat onap, dimana penyiapan dilakukan pada malam hari saat tidak ada pelayanan rawat jalan.

1.2.1 Laboratorium

1.2.1.11Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar April - Juni 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
Dilakukan di Rumah Sakit				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4899	4911	4587
	Hematologi	2731	2714	2507
	Serologi dan Molekuler	592	602	556
	Urine	231	253	180
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	8	5	8
TOTAL		8461	8485	7838
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	16
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
TOTAL		0	0	16
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	34	40	53
	Narkoba	26	45	33
	Covid-19	1	0	3
TOTAL		61	85	89
Dilakukan di Luar Rumah Sakit (Dirujuk)				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	3	0	1
	Hematologi	4	1	6
	Serologi dan Molekuler	4	8	15
	Urine	0	0	0
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	0	0	0
TOTAL		11	9	22
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	11	15	9
	Pemeriksaan Histopatologi	84	99	57
TOTAL		95	114	66
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	0	10	5
	PCR	0	0	0
	Tumor Marker	0	2	0
	Cholinesterase	0	0	0
TOTAL		0	12	5

1.2.1.12 Grafik Pemeriksaan Didalam dan Diluar Rumah Sakit Bulan April - Juni 2025



Analisis :

1. Permintaan pemeriksaan laboratorium pada Bulan Juni 2025 mengalami penurunan, yaitu sebesar 7838 pemeriksaan. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah kunjungan laboratorium, salah satunya adalah kunjungan pasien rawat inap.
2. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :
 - a) Patologi Anatomi = 275 sampel
 - b) Patologi Klinik = 42 sampel
 - c) Lain-lain = 17 sampel
3. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada dalam 3 bulan terakhir mencapai 275 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang (PA) untuk kebutuhan klaim.
4. Hasil pemeriksaan PA masih mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena adanya tindakan potong ulang dari hasil yang mengarah atau curiga keganasan dan 3 tanggal merah hari besar pada Bulan Juni 2025.
5. Masih ditemukan pemeriksaan patologi klinik yang dirujuk pada Bulan Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar 22 pemeriksaan, yaitu antara lain pemeriksaan ANA Test, Serum Iron, TIBC, HB Elektroforesis, Alkali Fosfatase, Hbs Ag (ELISA), VDRL.
Rumah Sakit tidak melakukan pengadaan alat dan reagen karena permintaan hanya sedikit.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
2. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
3. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
4. Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
5. Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
6. Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.
7. Mengajukan review tarif pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Keuangan PT.

1.2.1.13 Pelaporan Nilai Kritis April - Juni 2025

NO	BULAN	JUMLAH NILAI KRITIS	PROSENTASE YANG DILAPORKAN	PROSENTASE YANG TIDAK DILAPORKAN
1.	April 2025	206	100%	0%
2.	Mei 2025	193	100%	0%
3.	Juni 2025	173	100%	0%

1.2.1.14 Grafik Pelaporan Nilai Kritis April - Juni 2025



Analisis :

- 1. Pelaporan nilai kritis pada Bulan Juni 2025 sudah mencapai 100%.
- 2. Petugas sudah disiplin dalam melakukan dokumentasi pelaporan nilai kritis.
- 3. Tidak ada complain yang masuk karena keterlambatan pelaporan nilai kritis ke unit.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Supervisi berkala dilakukan oleh Karu dan Kabid Penunjang Medis
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan dan Kabid Pelayanan Medis terkait pelaporan complain DPJP terhadap keterlambatan pelaporan nilai kritis.
- 3. Kolaborasi dengan SDM terkait kedisiplinan petugas dalam melakukan pekerjaan.
- 4. Pertahankan kinerja yang sudah baik.

4.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan April - Juni 2025

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
Bulan April 2025					
1.	Abd Rohman	229923	18/04/2025	ICU	Sampel Vena BGA
2.	Aqilla Putri	160607	19/04/2025	IRNA 3C	Sampel Clotting
3.	Rochmad	102166	29/04/2025	IRNA 5C	Sampel Clotting
Bulan Mei 2025					
1.	Andara	224145	01/05/2025	IGD	Sampel Clotting
Bulan Juni 2025					
Tidak ditemukan sampel rusak					

Analisis :

Tidak ditemukan sampel rusak ketika diterima oleh petugas laboratorium pada Bulan Juni 2025. Hal ini bisa disebabkan sudah ada perbaikan petugas saat melakukan sampling darah, paham dengan kebutuhan dan prosedur penyimpanan sampai dengan pengiriman sampel ke laboratorium, sampel yang tidak segera dikirim ke Laboratorium diambil oleh Analis Kesehatan

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan Evaluasi.
- 2. Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
- 3. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
- 4. Supervisi ED reagen.

4.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan April - Juni 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18
Mei 2025	20	27	42	9	98	4	-	-	-	4
Juni 2025	15	29	27	8	79	2	1	-	-	3

4.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Maret - Mei 2025

NO	NAMA PASIEN	JUMLAH PASIEN DAN PERMINTAAN LABU DARAH INCOMPATIBLE				TOTAL PERMINTAAN LABU DARAH
		A	AB	O	B	
Bulan April 2025						
Tidak ada						
Bulan Mei 2025						
Tidak ada						
Bulan Juni 2025						
1.	Siti Rahajuningsih				√	2 Labu

Analisis :

- 1. Permintaan labu darah Pada Bulan Juni 2025 mengalami penurunan sebanyak 79 labu darah, hal ini disebabkan kasus dengan diagnosis kebutuhan labu darah menurun, dan semua permintaan terpakai, tidak ada return dari unit.
- 2. Masih ditemukan return labu darah ke PMI sebanyak 3 kantong darah, mengalami penurunan.
- 3. Ditemukan hasil incompatible 1 pasien sebanyak 2 labu pada crossmatch pada Bulan Juni 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengurangi stok maksimum labu darah dengan permintaan jarang.
- 2. Mengirimkan analis untuk magang di PMI selama 2 minggu secara bergantian, biaya free.
- 3. Melakukan penertiban penulisan kartu stok labu darah secara real time, pelaksanaan SO dilakukan setiap akhir bulan.
- 4. Mempertahankan ketelitian dalam melakukan crossmatch.
- 5. Sampel darah dikirim ke UTD terdekat, karena UTD yang bisa mengeluarkan surat keterangan hasil crossmatch incompatible ke DPJP.

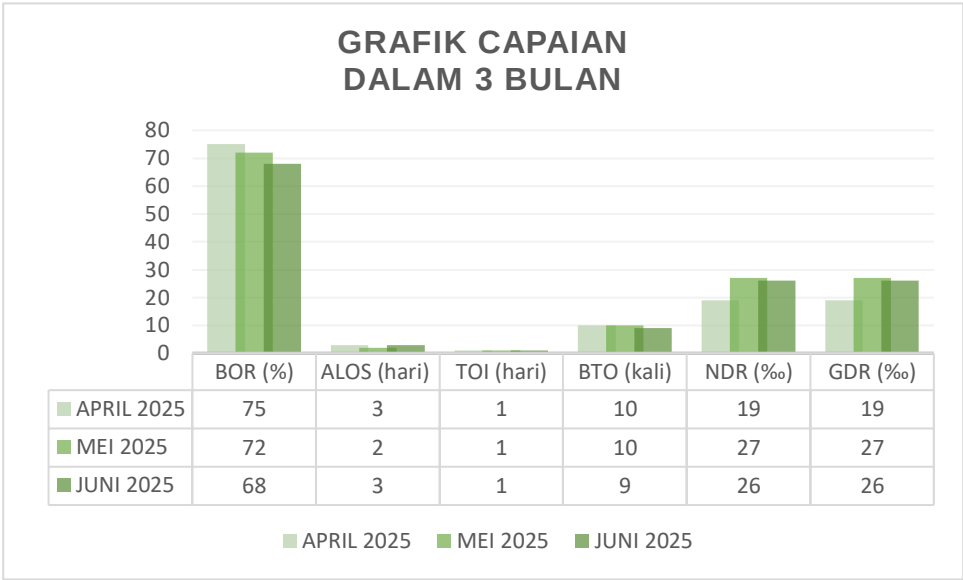
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan April - Juni 2025

INDIKATOR	RUMUS	DATA	STANDAR DEPKES	BULAN	UNIT												TOTAL
					2C	3A	3C	4Ab	5C	6A	7A	8A	MTS	NICU	HCU	ICU	
BOR (Bed Occupancy Rate) “Prosesntase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu”	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60-80 %	April 2025	65	59	69	97	58	79	77	75	67	33	25	19	75%
				Mei 2025	65	77	68	80	56	74	76	72	61	25	26	22	72%
				Juni 2025	63	75	73	71	57	64	77	70	60	50	25	33	68%
ALOS (Average Length of Stay) “Rata-rata lama rawat seorang pasien”	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	Jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6-9 hari	April 2025	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	3hari
				Mei 2025	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2hari
				Juni 2025	4	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3 hari
TOI (Turn Over Interval) “Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati”	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1-3 hari	April 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	5	1hari
				Mei 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	5	2	4	1hari
				Juni 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	4	1 hari
BTO (Bed Turn Over) “Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode”	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien, Jumlah TT	4-5 kali (dalam hitungan bulan)	April 2025	9	10	9	12	8	9	10	9	10	5	10	5	10kali
				Mei 2025	7	9	10	11	8	10	9	9	6	5	11	6	10kali
				Juni 2025	8	9	10	11	7	8	10	8	9	5	9	6	9 kali

NDR (Net Death Rate) “Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ Mati } >48\text{jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\text{‰}$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25 ‰	April 2025	14	0	0	0	42	19	17	19	0	0	158	209	19‰
				Mei 2025	0	13	0	0	9	34	36	55	0	200	143	255	27‰
				Juni 2025													
					0	0	0	8	9	20	9	32	0	0	59	404	26‰
GDR (Gross Death Rate) “Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\text{‰}$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	April 2025	14	0	0	0	42	19	17	19	0	0	158	209	19‰
				Mei 2025	0	13	0	0	9	34	36	55	0	200	143	255	27‰
				Juni 2025													
					0	0	0	8	9	20	9	32	0	0	59	404	26‰

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan April - Juni 2025 2025



Analisis :

Indikator	Nilai Mei 2025	Standar Ideal	Evaluasi Singkat
BOR	68%	60%-85%	Masih dalam standar, batas rendah
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	9 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Update Tren Tahun 2025

Indikator	Februari	Maret	April	Mei	Catatan
BOR	81%	75%	72%	68%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

Masalah :

a. BOR (Bed Occupancy Rate)

Data : April (75%), Mei 72%), Juni (68%)

Analisis :

- Terjadi tren penurunan okupansi tempat tidur selama tiga bulan berturut-turut.
- Penurunan BOR bisa mengindikasikan :
 1. Penurunan jumlah kunjungan/rawat inap pasien.
 2. Perpindahan pasien ke fasyankes lain.
 3. Adanya persepsi Masyarakat terhadap kualitas layanan yang menurun.

b. LOS (Length of Stay)

Data : stabil di 3 hari

Analisis :

- Waktu rata-rata perawatan pasien tidak berubah.
- LOS yang stabil menunjukkan efisiensi pengelolaan klinis dan administrasi relative terjaga.
- Namun, bila dikaitkan dengan BOR yang menurun, LOS stabil tidak cukup menahan BOR agar tetap tinggi.

c. **TOI (Turn Over Interval)**

Data : stabil di 1 hari

Analisis :

- Menunjukkan bahwa waktu tunggu tempat tidur kosong sebelum digunakan kembali cukup singkat, yang berarti pengelolaan tempat tidur cukup efisien.
- Namun, karena BOR menurun, ada kemungkinan kekosongan tempat tidur karena rendahnya jumlah pasien masuk, bukan karena efisiensi rotasi.

d. **BTO (Bed Turn Over)**

Data : April (10 kali), Mei (10 kali), Juni (9 kali)

Analisis :

- Ada sedikit penurunan frekuensi penggunaan tempat tidur.
- Hal ini mendukung Kesimpulan bahwa jumlah pasien yang dirawat mulai menurun.

Rencana Tindak Lanjut :

1. **Evaluasi Pelayanan**

- a) Lakukan survey kepuasan pasien dan identifikasi factor-faktor penurunan kunjungan.
- b) Periksa apakah ada perubahan kebijakan BPJS, tarif, atau pelayanan yang mempengaruhi pasien.

2. **Peningkatan Promosi Pelayanan**

Tingkatkan promosi layanan unggulan rumah sakit untuk menarik pasien baru, termasuk promosi online dan kerja sama dengan faskes primer (puskesmas/klinik).

3. **Koordinasi dengan Tim Medis dan Manajemen**

- a) Adakan rapat untuk meninjau performa masing-masing bangsal.
- b) Evaluasi efektivitas system rujukan dan komunikasi antar unit.

4. **Pemantauan Lanjutan**

- a) Tetapkan indikator peringatan dini jika BOR terus menurun (<65%).
- b) Tinjau kemungkinan **revisi kapasitas tempat tidur** jika tren rendah terus berlanjut agar efisiensi tetap terjaga.

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Bulan Juni 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	386
2.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	272
3.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	271
4.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	248
5.	E11.4	With neurological complications	240
6.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	223
7.	K04.1	Necrosis of pulp	157
8.	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	155
9.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	152
10.	F41.2	Mixed anxiety and depressive disorder	146

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Juni 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever (TF)	284
2.	P24.9	Neonatus Cukup Bulan	99
	A90	Dengue Fever	40
3.	I63.9	Cva Infark	33
4.	E14.9	Dm Hyperglikemia	31
5.	J18.9	Pneumonia	29
6.	M72.6	Necrotizing Fascitis	14
7.	D64.9	Anemia	13

8.	D24	Tumor Mammae	12
9.	J44.0	Copd / Chronic Obstructive Pulmonary Disease	11

Analisis :

1. Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah Decomp Cordis/Heart Disease sebesar 386 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 284 kasus.
2. Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

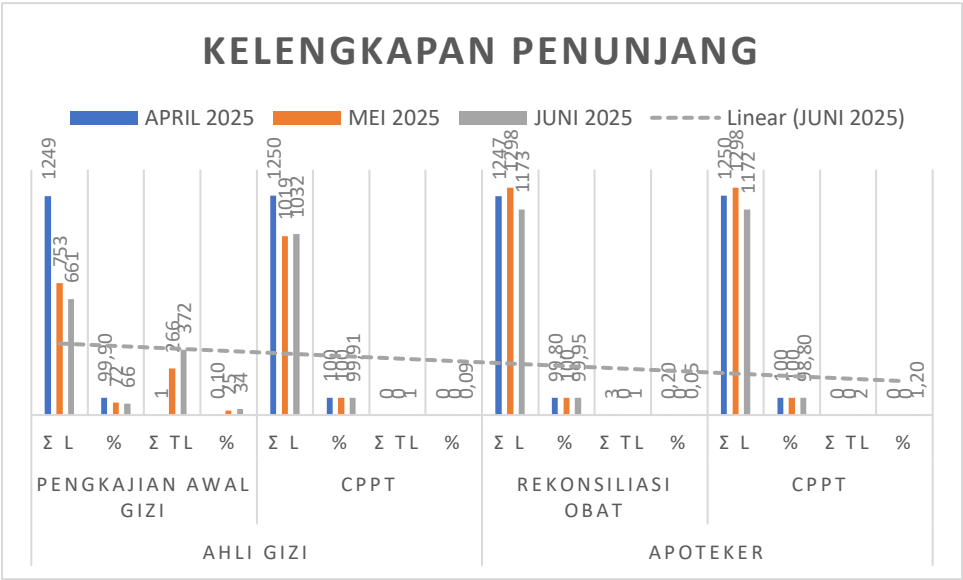
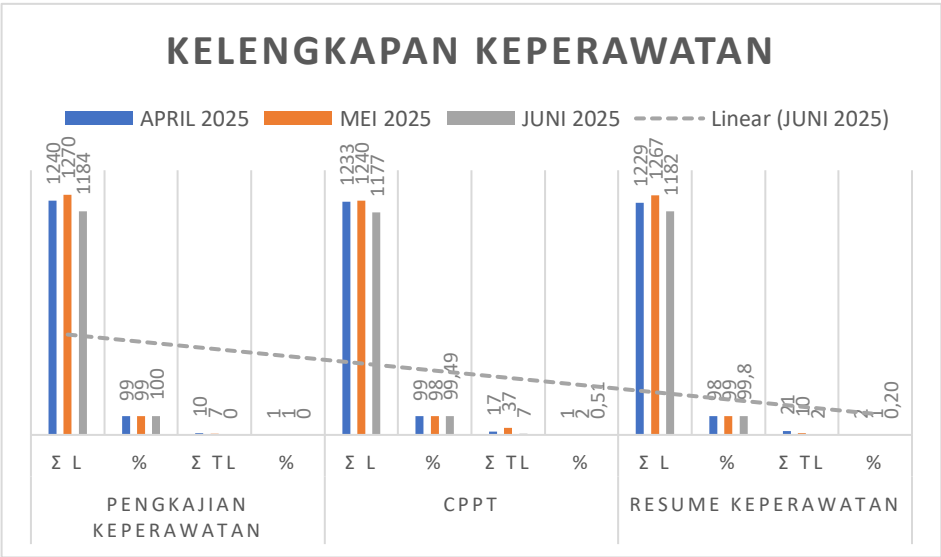
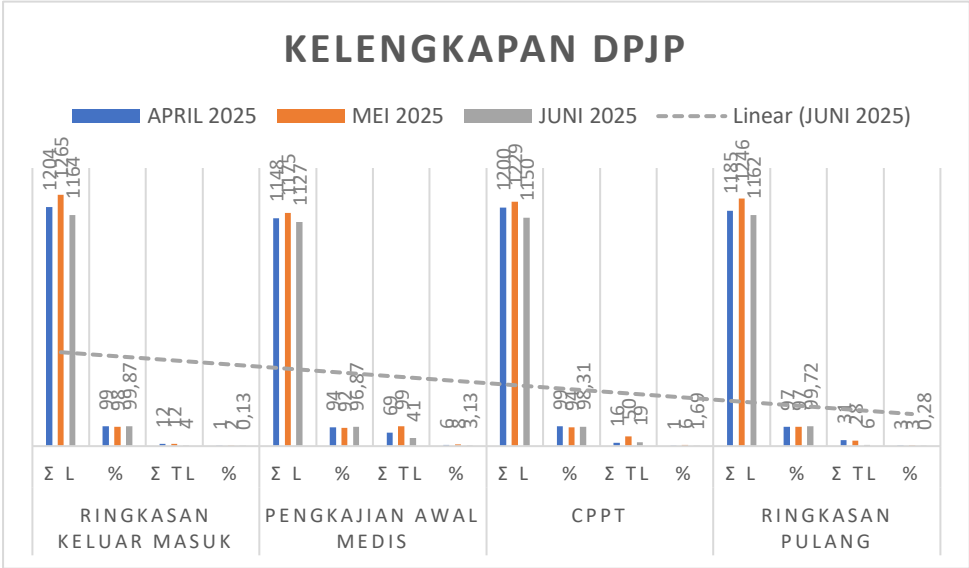
3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap April - Juni 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28

KELENGKAPAN PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Maret - Mei 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi mengalami peningkatan pada dokumen pengkajian awal medis gizi, dari 25% menjadi 34% yaitu sebanyak 372 dokumen tidak lengkap.
- 2. Pengkajian keperawatan 100% lengkap pada Bulan Juni 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Juni 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

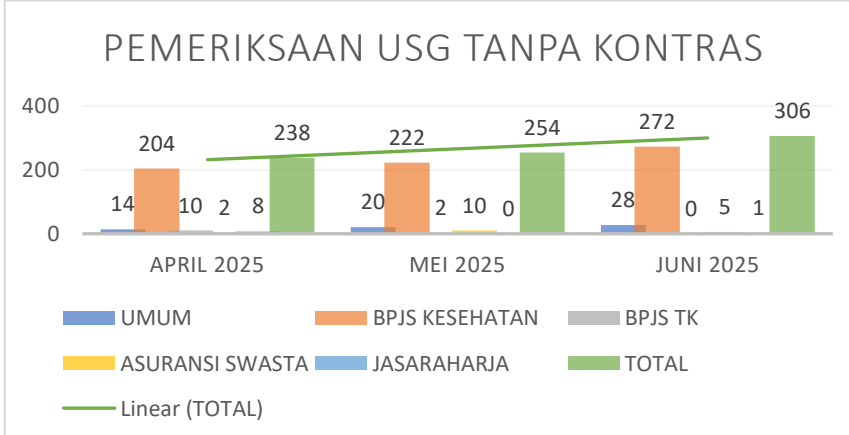
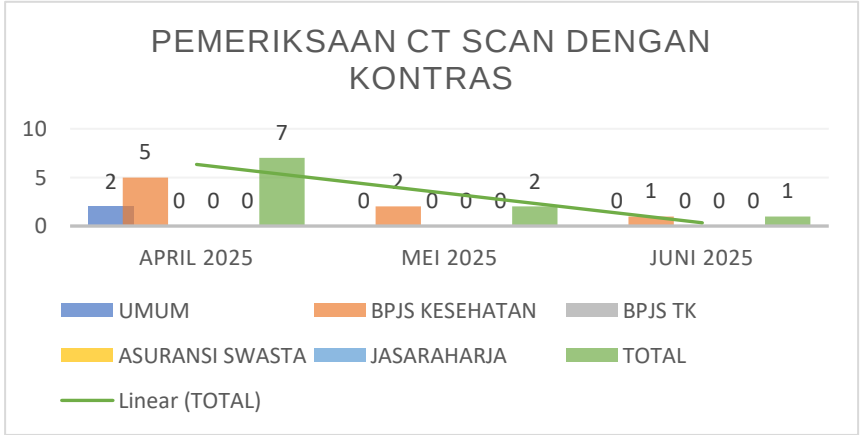
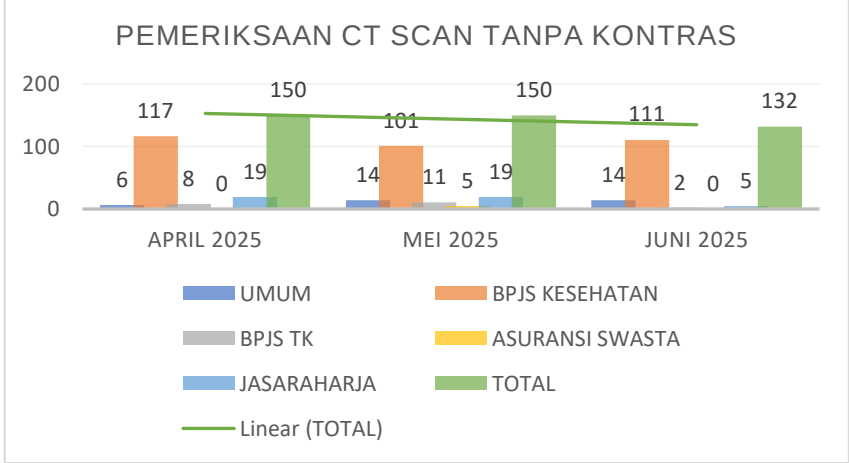
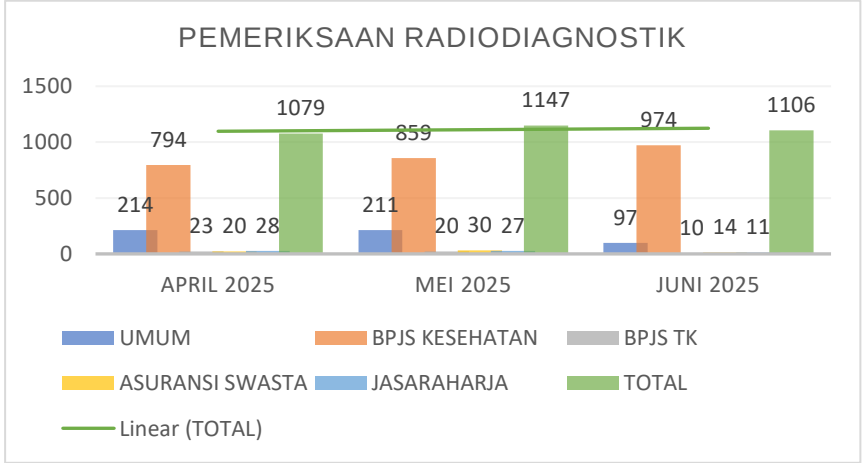
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

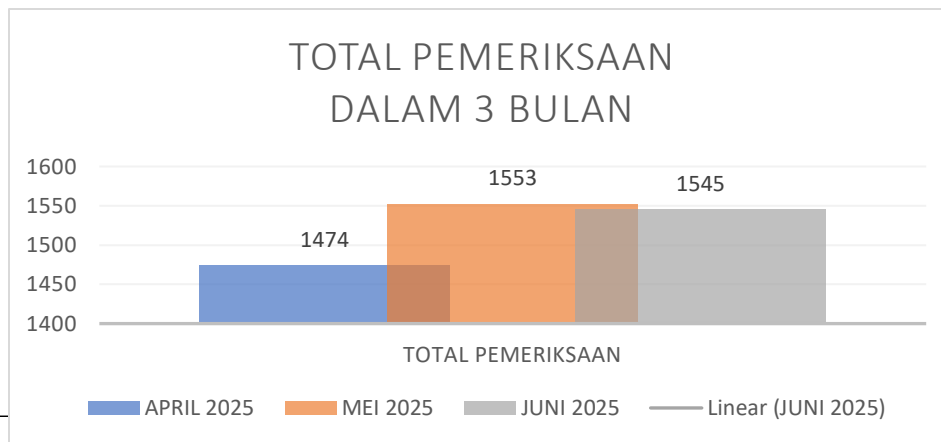
6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi April - Juni 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	214	211	97
		BPJS KESEHATAN	794	859	974
		BPJS TK	23	20	10
		ASURANSI SWASTA	20	30	14
		JASARAHARJA	28	27	11
	TOTAL		1079	1147	1106
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	6	14	14
		BPJS KESEHATAN	117	101	111
		BPJS TK	8	11	2
		ASURANSI SWASTA	0	5	0
		JASARAHARJA	19	19	5
	TOTAL		150	150	132
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	2	0	0
		BPJS KESEHATAN	5	2	1
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		7	2	1
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	14	20	28
		BPJS KESEHATAN	204	222	272
		BPJS TK	10	2	0
		ASURANSI SWASTA	2	10	5
		JASARAHARJA	8	0	1
	TOTAL		238	254	306
TOTAL KESELURUHAN			1474	1553	1545

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi April - Juni 2025





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Juni 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.

Pada Bulan Juni 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :

- a. Radiodiagnostik : 1106
- b. USG Tanpa Kontras : 306
- c. CT Scan Tanpa Kontras : 132

2. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Juni 2025 adalah sebanyak 1545 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - a. Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - b. Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
3. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan April – Juni 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
2.		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
2.		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Mei 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Sumroti (231733)	Cardiomegali	Cardiomegaly dan Pneumonia	2
2.		Roeskandar	Lung Tumor	Lung Tumor dan Pneumonia	
1.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Rizka Anada	Normal	Fracture Scapulla	1
Bulan Juni 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Kiki Nur Ika Sari (232011)	Normal	Tetap Normal	1

Analisis :

Pada Bulan Juni Tahun 2025 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25-180	3	10-1440
2.	Ro Vertebrae	-	-	4	10-1440
3.	Ro Abdomen	4	25-60	10	10-1440
4.	Ro Extremitas	-	-	2	10-1440
5.	Ro Skull	-	-	2	10-1440
6.	USG Abdomen	8	5	15	10

7.	CT Scan Non Kontras	5	30-1440	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	30-1440	-	-
9.	Radiologi CITO	-	-	-	-

Analisa :

1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).
2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
4. Tidak terdapat pemeriksaan CITO dan kasus kritis selama Bulan April 2025.
5. Semua pemeriksaan CT Scan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.
7. Pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dr Agung, Sp.Rad, diatas target standar RS yakni 420-1440 menit dikarenakan hasil jadi diatas pukul 00.00 WIB dan DPJP meminta dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada April – Juni 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan Juni tidak ada komplain DPJP dan Dokter Umum karena keterlambatan hasil pembacaan radiologi.

Hal ini disebabkan, selain waktu tunggu cito tidak melebihi standar, bisa disebabkan ketidakpahaman petugas pelayanan dalam melaporkan complain sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

6.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

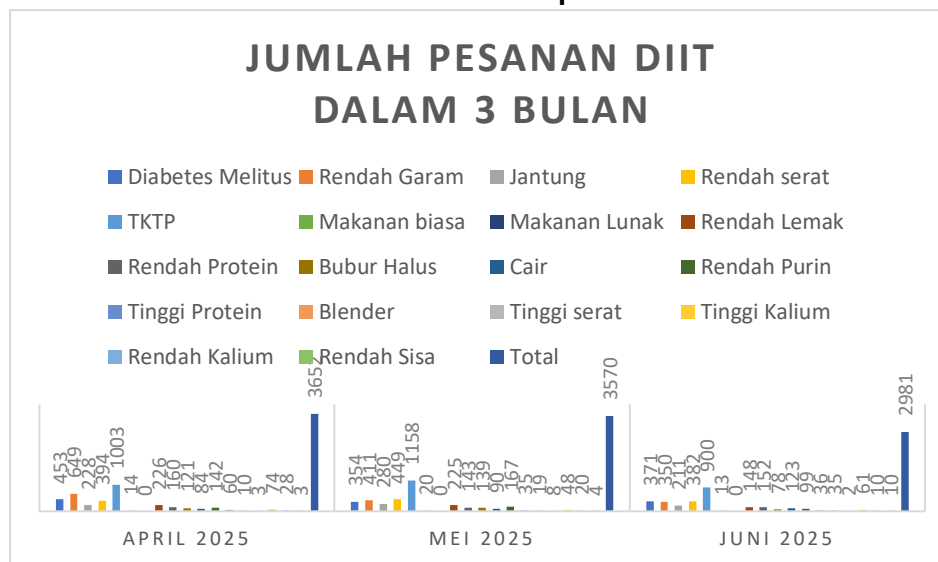
No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

2.4.5 Gizi**2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit April - Juni 2025**

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	
1.	Diabetes Melitus	453	354	371	104
2.	Rendah Garam	649	411	350	85
3.	Jantung	228	280	211	75
4.	Rendah serat	394	449	382	85
5.	TKTP	1003	1158	900	77

6.	Makanan biasa	14	20	13	65
7.	Makanan Lunak	0	0	0	0
8.	Rendah Lemak	226	225	148	65
9.	Rendah Protein	160	143	152	106
10.	Bubur Halus	121	139	78	56
11.	Cair	84	90	123	136
12.	Rendah Purin	142	167	99	59
13.	Tinggi Protein	60	35	36	102
14.	Blender	10	19	35	184
15.	Tinggi serat	3	8	2	25
16.	Tinggi Kalium	74	48	61	127
17.	Rendah Kalium	28	20	10	50
18.	Rendah Sisa	3	4	10	250
TOTAL		3652	3570	2981	81

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit April - Juni 2025



Analisis :

1. Jumlah pemberian diit pasien rawat inap pada Bulan Juni mengalami penurunan, hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak selama Bulan Juni 2025 adalah TKTP sebanyak 900, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Thypoid Fever dengan kebutuhan diit TKTP.
3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai

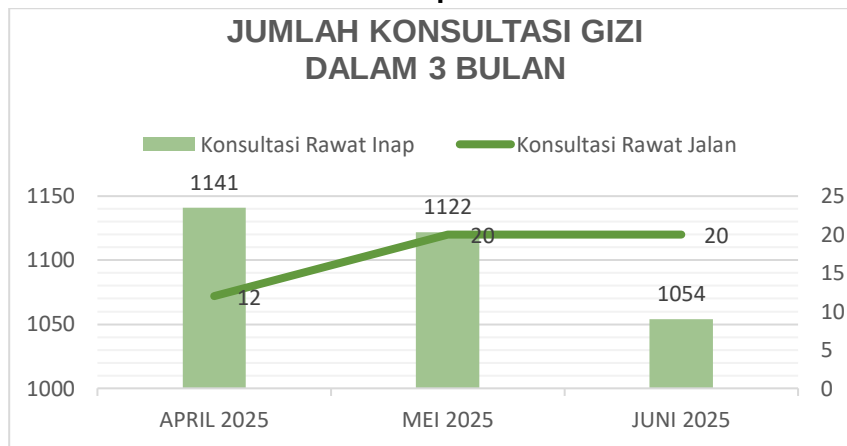
reward.

4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.
6. Perbaikan pencatatan food waste dipisahkan setiap menu makanan untuk mengetahui menu makanan mana yang tidak diminati.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi April - Juni 2025

NO	INDIKASI	JUMLAH PASIEN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1141	1122	1054
2.	Konsultasi Rawat Jalan	12	20	20

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Bulan Juni Tahun 2025



Analisis :

1. Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan Juni 2025 menurun mengikuti jumlah pasien yang rawat inap.
2. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan Juni 2025 kondisi stabil.
3. Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
2. Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
3. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Giz

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Juni 2025

NO	JENIS KOMPLAIN	NAMA PASIEN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT	TOTAL
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari 2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Mei 2025					
1.	Keluhan pasien dan OB yang belum mendapatkan makanan	An Abimanyu Putra Herlambang (C3C-8, IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Ayah pasien menyampaikan bahwa jika pasien belum selesai makan maka jangan mengambil makanan pasien terlebih dahulu.	1. Jam pengambilan makan adalah 1 jam setelah pembagian makan. 2. Pasien mengalami penurunan nafsu makan sehingga mengkonsumsi makanan dalam waktu lebih lama.	1. Koordinasi dengan tim penyaji untuk memberikan edukasi terkait jam pengambilan alat makan yaitu 1 jam setelah pembagian makan. 2. Koordinasi dengan CS pantry untuk cara edukasi yang benar sebelum mengambil alat makan pasien.	1
Bulan Juni 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan	Ny Nadiyah Firliani Komplain melalui google review	c. Pasien sakit mengalami penurunan	Koordinasi dengan seluruh petugas	1

	mengenai menu makanan.	“makanannya kurang enak”	nafsu makan dan penurunan citarasa d. Antara satu petugas pengolahan dan pengolahan lain memiliki selera rasa yang berbeda sehingga ketika memberi rasa pada makanan disesuaikan dengan selera petugas masing-masing	pengolahan dalam pembuatan standar resep masakan agar masakan yang dihasilkan sama antara satu petugas dengan petugas lain	
--	------------------------	--------------------------	---	--	--

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) bulan April - Juni 2025

NO	MENU	RINCIAN MENU	TOTAL SISA MAKANAN (KG)			KETERANGAN
			APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	184,4	174,7	120,7	68,8% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH menurun 36% dibandingkan bulan Mei
		Nasi Tim	282,7	245,1	178	
		Total	467,1	419,8	298,7	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Menu yang terdapat sisa: 1. Setup pisang 2. Kacang hijau 3. Bubur sagu 4. Tahu fantasi
		Setup Pisang	0,6	0,8	0,7	
		Kacang Hijau	0,3	0,7	0,7	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	1	1,1	1,2	
		Kue Lumpur	0	0	0,5	
		Puding	0,2	0	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0,4	0	
		Sagu Mutiara	0	0	0	
		Total	1,1	3	3,1	
1.	Menu 1					Menu 9 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 15,5
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,5	2,6	2,5	

		Rolade Ayam	3,1	2,2	Kg.
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,8	0,2	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	2,2	2,1	
		Ayam Kecap	3,3	2,1	
		Tahu Bumbu Tomat	2,1	0,8	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,6	0,2	
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	3,1	0,8	
		Tempe Goreng	2,1	0,5	
	Tambahan VIP	Perkedel	0,4	0	
	Total		21,2	11,5	5,3
2.	Menu 2				
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4,4	5,4	2,5
		Tahu Rempah (Remet)	3,5	3,1	
		Abon	0,7	0,8	
	Tambahan VIP	Telur Rebus	1	0,2	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	2,8	3,9	2
		Ayam Wijen	3,3	4	
		Bakwan Jagung	1,6	2,2	
	Tambahan VIP	Telur Gulung	0,5	0,2	
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	2,5	5,4	2,7
		Tempe Goreng	2,8	2,5	
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0,3	0,2	
	Total		23,4	27,8	7,2
3.	Menu 3				
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,7	3,7	2,3
		Tahu Krispy	2,2	2	
		Abon	0,4	0,3	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,1	0,3	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	3,1	1,9	4,1
		Rolade Ayam	2,7	2,1	
		Tahu Goreng	1,5	0,9	
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,4	0,3	
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	3,1	2,1	4,5
		Ayam Bombay	4,9	2,8	

		Tempe Orek	2,3	1,5	
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,2	0,6	
		Total	24,6	18,5	10,9
4.	Menu 4				
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	5,2	3,5	3,2
		Tahu Nugget	3,6	1,8	
		Abon	0	0,2	
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0	0,5	
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	5,3	3,1	5,3
		Ayam Kecap	3,6	2,4	
		Jamur Krispy	1,6	1,3	
	Tambahan VIP	Tahu Bacem	0,7	0,3	
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	3,3	2,6	5,6
		Telur Rebus	2,3	1,7	
		Tempe Goreng	2,3	1,5	
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,5	0	
		Total	28,4	18,9	14,1
5.	Menu 5				
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	3,2	3,4	2
		Opor Tahu	2,3	2,2	
		Oper Telur	2,5	1	
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,7	0,5	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	6,6	3,4	4,1
		Ayam Bombay	5,7	4,5	
		Bakwan Jagung	4,1	2,7	
	Tambahan VIP	Tahu Krispy	0,1	0,1	
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	3,5	1	3,9
		Tempe Goreng	3,4	0,7	
		Telur Dadar	0,2	0,2	
		Total	32,3	19,7	10
6.	Menu 6				
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,0	2,2	2,8
		Orak Arik (Wortel, Kubis, Daun Bawang, Telur)	2,1	2,1	
		Tempe Goreng	3,6	1,9	
	Tambahan VIP	Ayam Goreng	1,7	0,8	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung,	3,5	3,1	2,1

		Wortel, Oyong, Kemangi)			
		Ayam Laos	4,7	4,5	
		Tahu Bumbu Tomat	2,3	1,6	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,1	0,6	
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	3,4	2	4,2
		Tahu Krispy	2,1	1,5	
	Tambahan VIP	Perkedel	0,4	0,7	
	Total		26,9	21	9,1
7.	Menu 7				
	Pagi	Cah Sawi (Sawi Putih, Wortel Serut, Ayam Dadu)	3	2,8	3,3
		Telur Ceplok Bumbu Kuning	2,4	5,7	
		Abon	1	0,3	
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,1	0,5	
	Siang	Sup (Wortel Dadu, Jamur Es, Polong, Bakso)	4	1,8	2,4
		Perkedel	2,3	1,1	
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0,6	0	
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	3,7	1,8	3,4
		Tempe Goreng	2,3	1	
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,5	0,2	
	Total		23,4	17	9,1
8.	Menu 8				
	Pagi	Sayur Bobor (Manisah, Sawi Hijau)	5,4	2,2	2,2
		Tahu Nugget	3,1	2,3	
		Abon	1,2	0,6	
	Tambahan VIP	Ayam Fillet Tepung	0	0,5	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Jagung, Manisah)	3,4	1,6	2
		Ayam Bakar	3,1	2	
		Tahu Goreng	1,4	1	
	Tambahan VIP	Nugget Ayam	0	0	
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	3,6	1,5	2
		Botok Tahu	2,6	2,1	
		Abon	0,8	0,2	
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2	0	
	Total		24,8	14	6,2

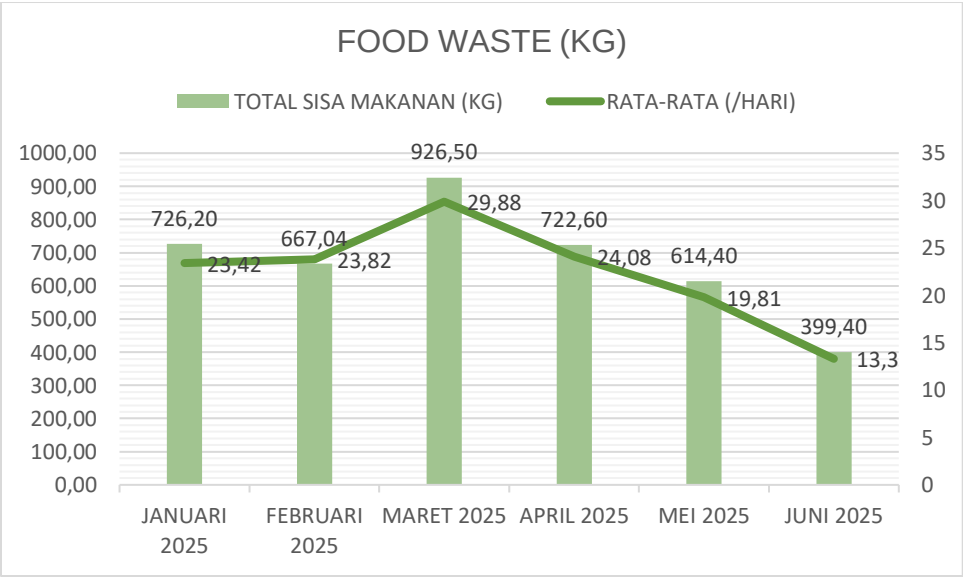
9.	Menu 9				
	Pagi	Tumis (Bakso, Wortel, Buncis)	4	2,2	6,2
		Tahu Rempah	1,5	1,2	
		Abon	0,4	0,1	
	Tambahan VIP	Telur Dadar	1	0,7	4,5
	Siang	Sup (Bihun, Wortel, Pokcoy)	3,4	2,7	
		Ayam Kemangi	4,8	2,4	
		Tahu Krispi	1,9	1,5	
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0,4	0,4	
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	3,4	2,3	4,8
		Telur Rebus	1,8	1,6	
		Tempe Goreng	1,4	1,1	
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0	0,1	
	Total		24	16,3	15,5
10.	Menu 10				
	Pagi	Sup (Wortel, Bakso, Sawi Putih)	6,3	1,8	2
		Telur Ceplok	2,8	1,6	
		Abon	0,7	0,7	
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,5	0,3	3,1
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Wortel, Jagung, Manisah)	3,8	3,1	
		Ayam Wijen	3,8	4,2	
		Tahu Goreng	1,7	1,4	
	Tambahan VIP	Telur Orak Arik	0,3	0	
	Sore	Capjay (Wortel, Kembang Kol, Sawi, Bakso, Ayam Dadu)	3,5	2	5,1
		Tempe Goreng	2	1	
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0	0,3	
	Total		25,4	16,4	10,2
11.	Menu 11				
	Pagi	Sapo Tahu (Tahu, Wortel, Kembang Kol, Bakso)	0	0	0
		Tempe Goreng	0	0	0
		Abon	0	0	0
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0	0	0
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	0	0	0
		Ayam Bakar	0	0	0

		Bakwan Jagung	0	0	0	
	Tambahan VIP	Tahu Goreng	0	0	0	
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	0	0	0	
		Tahu Rempah	0	0	0	
		Abon	0	0	0	
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0	0	0	
	Total		0	7,5	0	
	Total Food Waste Menu		254.4	191,6	97,6	
	Total Keseluruhan		722.6	614,4	399,4	

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste pada Bulan Juni 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)	Rata-Rata/Hari
1.	Januari 2025	726.2	23,42
2.	Februari 2025	667.04	23,82
3.	Maret 2025	926.5	29,88
4.	April 2025	722.6	24,08
5.	Mei 2025	614,4	19,81
6.	Juni 2025	399,4	13,3

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Juni Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada penurunan sisa makanan pada Bulan Juni 2025, yaitu sebanyak 399.4kg, setelah dilakukan tindaklanjut mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian dan memperbaiki dalam segi rasa dan penampilan.
3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat sebanyak 298,7 kg (mengalami penurunan, rata-rata 13,3 kg/hari), hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
4. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
5. Dari total sisa makanan pada Bulan Juni 2025 sebanyak 298,7 kg, 68% berasal dari karbohidrat (nasi dan nasi tim).
6. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
2. Melakukan plating secara menarik.
3. Mengadakan cooking class.
4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

Salinan Gizi Monitoring Suhu & Kelembapan

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help Accessibility

65% Arial 11

At: D2

BILAN TEMPAT		JUNE 2024 (INSTALASI GIZI)																											
Ruang		TANGGAL																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	Batas suhu min (°C)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
2	Batas suhu maks (°C)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
3	Nilai Suhu Kantor Gizi (°C)	26.1	24.8	25.6	25.2	25.9	25.6	25.6	25.9	25.2	25.6	26.1	25.6	26.1	25.9	25	24.9	25.7	24.6	24.9	25.9	25.6	25.7	25.6	25.9	24.8			
4	Nilai Suhu R. Penerimaan (°C)	25.3	26.4	26.4	27.3	26.9	26.3	25.8	25.6	26.2	25.9	25.5	27.7	25.3	28.3	28.5	25.9	25.3	26.4	25.8	28.3	25.3	26.3	26.4	28.4	28.5			
5	Nilai Suhu R. Gudang Kung (°C)	25.6	24.2	24.2	28.2	26	25.5	24.6	24.7	24.4	26.8	28.3	25.6	28.8	26.8	28.6	24.2	24.2	24.6	26.9	28.6	28.8	24.2	26.6	26.7	26.3	26.4		
6	Nilai Suhu R. Gudang Kung (°C)	26.5	25.7	25.7	26.9	28.3	26.4	25.4	25.6	25.5	25.4	27.7	26.5	26.5	26.8	25.4	26.5	25.7	25.7	25.4	26.3	28.5	26.7	25.5	25.6	25.4	25.5		
7	Nilai Suhu Pengolahan (°C)	25	26.7	25.5	25.9	23.8	25.7	26.4	26.5	26.7	25.7	25.7	25	25	28.5	25.7	25.7	26.7	28.3	26.4	27.2	25	25	26.7	27.3	26.4	25.5		
8	Nilai Suhu Penerimaan Alat Masak (°C)	25.4	26.5	26.3	25.6	27.7	25.6	24.2	24.3	25.3	25.6	28.1	25.4	26.5	26.4	25.6	25.8	25.9	25.6	25.3	25.7	25.9	25.3	25.4	25.5	25.8	25.4		
9	Nilai Suhu R. Pemrosesan (°C)	24	25.6	25.4	26.7	26.9	26.7	25.5	25.6	25.0	26.6	27.7	24	24.4	24.6	26.7	24	25.9	25.4	24.2	25.3	25.4	25.4	25.6	25.2	24.2	25.4		
10	Instalasi Suhu	ER	NU	SN	CM	AC	DW	SN	NU	TY	CM	AC	CM	ER	SN	NU	AC	SN	AC	CM	ER	DK	AC	SN	CM	NU	TY		
11	Supervisi Kuru	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

Contoh Pengisian JUN MASTER JULI 25

87

2.4.5.8 Lampiran Rekap Dara Kehilangan Alat Makan

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	RUANGAN	NAMA ALAT	BUKTI KUITANSI	DOKUMENTASI	KETERANGAN
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang

							pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran
Mei 2025							
1.	05/05/2025	Kasiati	D8A-12	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	12/05/2025	Adhibah Mahirah Azizah	C3C-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	28/05/2025	Ika Rodyana	D6A-8	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Juni 2025							

Analisis :

1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kehilangan alat makan pada Bulan Juni 2025.
2. Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

4.4.7 CSSD – Laundry

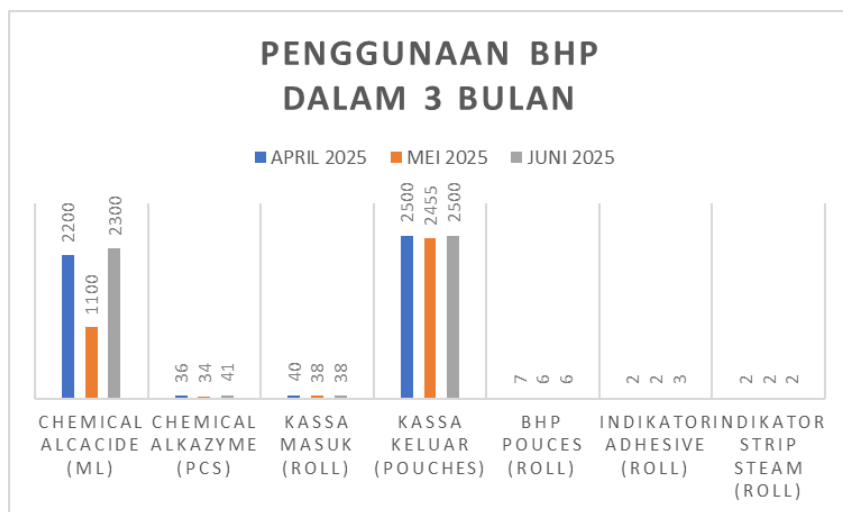
4.4.7.1 CSSD

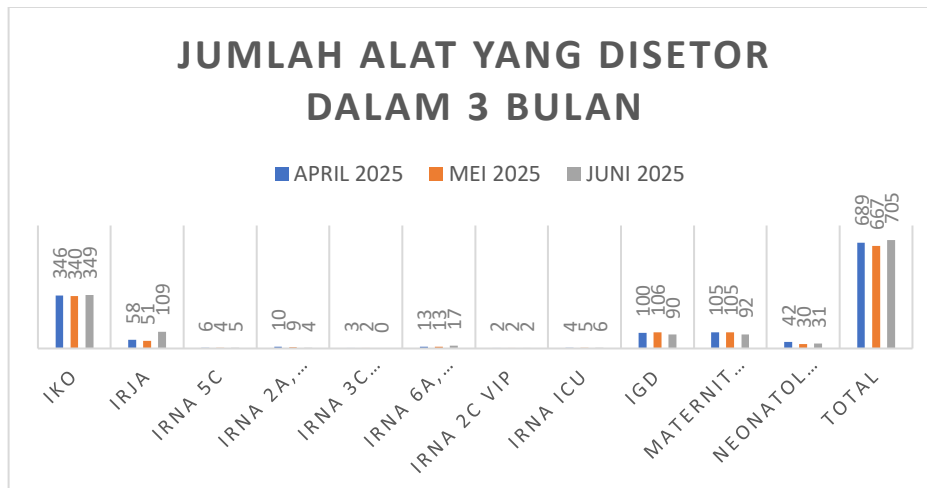
4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Juni 2025

NO	HAL	BULAN TAHUN 2025		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	2200	1100	2300
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	36	34	41
3.	Kassa Masuk (roll)	40	38	38
4.	Kassa Keluar (pouches)	2500	2455	2500
5.	BHP Pouces (roll)	7	6	6

6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	3
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
Alat Yang Disetor				
8.	IKO	346	340	349
9.	IRJA	58	51	109
10.	IRNA 5C	6	4	5
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	10	9	4
12.	IRNA 3C ANAK	3	2	0
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	13	13	17
14.	IRNA 2C VIP	2	2	2
15.	IRNA ICU	4	5	6
16.	IGD	100	106	90
17.	MATERNITAS	105	105	92
18.	NEONATOLOGI	42	30	31
Jumlah		689	667	705

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Juni 2025





Analisis :

1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, pengeluaran BHP dalam 3 bulan terakhir adalah stabil, ada penigkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan dan produktivitas CSSD membuat kassa steril meningkat (stok di CSSD untuk menghindari masa expired di Gudang Farmasi) dan ada permintaan Chemical Alkacyde untuk unit IKO.
2. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat pada Bulan Juni 2025 yaitu sejumlah 349 set, diikuti dari Unit Maternitas 92 set dan Unit IGD 90 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
3. Unit IRJA mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan khususnya pasien bedah umum, bedah orthopedi dan bedah plastic.
4. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.
5. Penggunaan BHP meningkat tidak sebanding dengan jumlah alat yang disetor, hal ini disebabkan karena alat yang disetor terbanyak dari IKO dan Maternitas, dimana alat-alat tersebut kemungkinan besar terdapat noda membandel.
6. Terjadi peningkatan pengeluaran alcacide secara drastis, hal ini disebabkan karena unit IKO ada permintaan alcacide 1 jirigen untuk precleaning alat saat malam hari.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan Juni Tahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breathing circuit	-

Analisis :

Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan **Juni** 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN			TOTAL 3 BULAN
	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	
Kejadian Instrument Kurang				
IKO	1	4	1	6
IGD	0	0	0	0
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	1	0	1
Kejadian Instrumen Hilang				
IKO	0	0	0	0
IGD	2	0	0	2
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	1	1

Analisis :

1. Ditemukan kejadian instrument kurang di IKO, sebanyak 1 kali. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan langsung dicek oleh petugas CSSD, setelah ditelusur ditemukan di unit.
2. Ditemukan kejadian instrument kurang di IRJA, sebanyak 1 kali, yaitu gunting ODC, sudah dilakukan penggantian.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan pencatatan saat ada penemuan.
2. Melaporkan temuan kepada Kabid Keperawatan untuk dilakukan pendisiplinan petugas.
3. Melakukan penggantian alat hilang oleh unit yang bersangkutan.

4.4.7.5 Tabel Rekap Data Permintaan Instrumen Cito Selama Bulan Juni 2025

UNIT	JUMLAH PERMINTAAN CITO			KETERANGAN
	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	
IKO	0	0	0	
IGD	0	0	0	
IRNA	0	0	0	
IRJA	0	0	0	

Analisis :

Tidak ada permintaan instrument cito selama 3 bulan terakhir, hal ini dipengaruhi ketertiban petugas dalam menyortir instrument kotor sehingga unit saat meminta alat selalu tersedia.

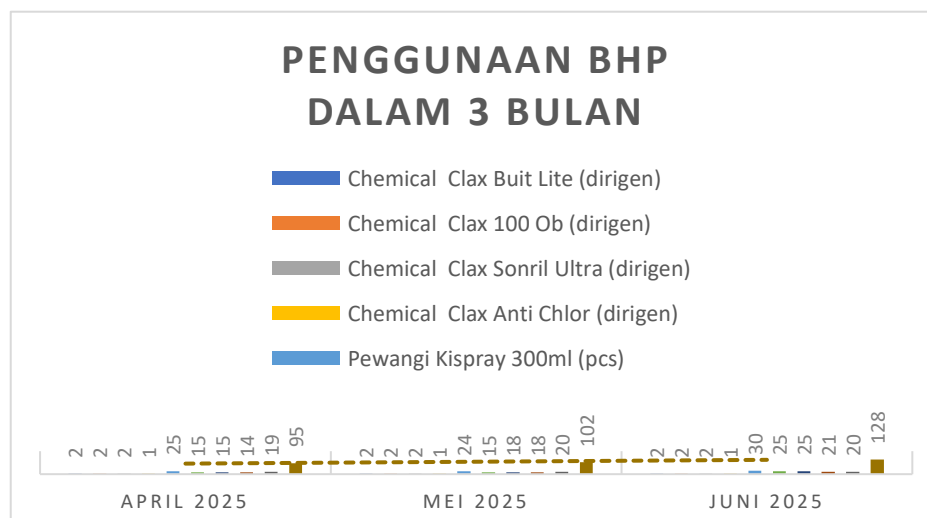
Rencana Tindak Lanjut : -

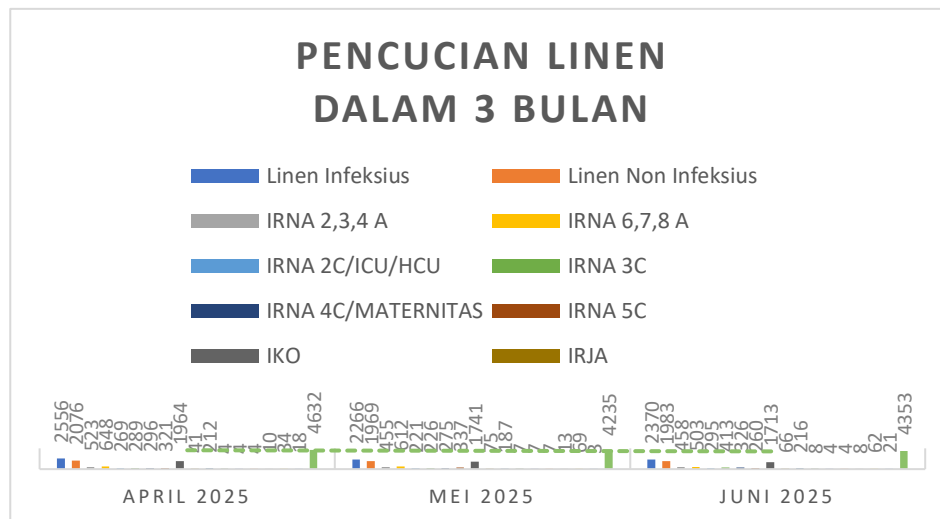
1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	HAL	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
BHP				
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	2	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	2	2	2
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	2	2	2
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	25	24	30
6.	Pemutih Bayclean (liter)	15	15	25
7.	Softener (liter)	15	18	25
8.	Liquid matic (liter)	14	18	21
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	19	20	20
TOTAL		95	102	128
LINEN (kg)				
1.	Linen Infeksious	2556	2266	2370
2.	Linen Non Infeksious	2076	1969	1983
3.	IRNA 2,3,4 A	523	455	458
4.	IRNA 6,7,8 A	648	612	503
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	269	221	295
6.	IRNA 3C	289	226	413
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	296	275	326
8.	IRNA 5C	321	337	260
9.	IKO	1964	1741	1713
10.	IRJA	41	75	66
11.	IGD	212	187	216
12.	LABORATORIUM	4	7	8
13.	RADIOLOGI	4	7	4
14.	DAPUR/GIZI	4	7	4
15.	CSSD	10	13	8
16.	Linen MS	34	69	62
17.	Umum	18	3	21
Total		4632	4235	4353

1.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Juni Tahun 2025





Analisis :

1. Data diatas adalah jumlah pencucian linen pada Bulan Juni 2025 sebanyak 4353kg, mengalami peningkatan tetapi tidak sebanding dengan penurunan kunjungan pasien rawat inap.
2. Jumlah linen infeksius sebesar 2370 kg, sebagian besar berasal dari IGD dan Maternitas. Linen infeksius berasal dari unit yang paling banyak tindakan.
3. Penggunaan BHP meningkat, sebanding dengan jumlah pencucian linen.
4. Terdapat peningkatan juga dikarenakan ada pencucian korden unit.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Juni 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	Sprei	220	205	160
2.	Sarung bantal	325	311	276
3.	Selimut	201	195	178
4.	Baju tim IKO	114	113	110
5.	Baju ganti pasien	41	40	37

6.	Skort	151	150	148
7.	Perlak	31	31	22
8.	Baju ganti laundry	15	15	14
9.	Duk lubang besar	21	21	20
10.	Duk pembungkus	59	56	56
11.	Duk kecil 1 meter	55	50	50
12.	Duk ortho	16	15	15
13.	Duk lubang kecil	17	17	17
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	20	20	20
16.	Skort IKO	61	61	61
17.	Waslap	64	64	59
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	140	131	129
20.	Baju Pasien	35	34	30

1.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Juni 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	Sprei	20	15	45
2.	Sarung bantal	25	14	35
3.	Selimut	8	6	17
4.	Duk Pembungkus	0	3	0
5.	Duk Lubang Kecil	0	0	0
6.	Celana Tim IKO	3	1	3
7.	Baju Tim IKO	3	1	3
8.	Baju Pasien	0	1	7
9.	Skort	4	1	2
10.	Perlak	4	0	9
11.	Baju Ganti Laundry	0	0	1
12.	Duk Kecil	3	5	0
13.	Waslap	2	0	5
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	2	9	2
16.	Kerudung	0	0	0
17.	Kantung L	2	4	0
18.	Meja Mayo	1	0	0
Pemusnahan (+)		Tanggal 27/01/2025	Dijadwalkan 6 bulan sekali	Dijadwalkan 6 bulan sekali

Analisis :

1. Petugas melakukan sortir setiap hari, linen tidak layak dijadikan satu dan diajukan untuk dilakukan pemusnahan, BA sudah dikirim ke PT sebagai lampiran untuk penambahan linen pengganti.
2. Linen spre, selimut dan sarban yang rusak disebabkan karena sudah tipis dan bernoda yang sulit dikembalikan seperti semula.

3. Duk pembungkus dan duk kecil juga sudah tipis, sementara untuk baju tim yang rusak karena bolong dan tidak bisa dilakukan permak lagi.
4. Kantung linen juga banyak yang rusak karena jahitannya robek.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Follow up Pengadaan PT
2. Jadwal pemusnahan linen selanjutnya pada Bulan Juli 2025
- 3.

1.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	Masker IKO	1	3	2
2.	Tissue	6	5	2
3.	Jarum	1	0	1
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	0	1	0
7.	Benda lainnya	0	1 (selang oksigen)	1 (selang oksigen)

Analisis :

1. Masih ditemukan benda asing tercampur dengan linen, karena pemilahan seharusnya dilakukan di Unit sebelum linen dimasukkan kedalam tong linen kotor.
2. Ketidaksiplinan paling banyak dari Unit IKO.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4.7.5 Tabel Permintaan Linen Cito/Tidak Sesuai Jadwal Pada Bulan Juni 2025

UNIT	Tanggal	Jenis Linan	Jumlah	Alasan
-	-	-	-	-

Analisis :

Tidak ada permintaan linen cito dari unit, hal ini dikarenakan laundry memiliki jadwal permintaan linen sehari 2 kali, dan laundry standby 24 jam.

Rencana Tindak Lanjut :

4.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.5.7 SDM

3.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	43	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		11	2	7	0
		SMK		4	3	1	0
		SMA		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0

		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	1
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	24	11	5	6	2
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	9	9	9	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	16	1	4	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		2	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		0	1	0	0
		SMA		2	2	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0

36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	42	14	7	7	0
		SMA		23	19	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			454	442	277	162	4

Keterangan :
Pada bulan Juni 2025 terdapat 3 perawat resign

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Mochammad Fahad, S.Kep., Ns	Perawat	16 Juni 2025	Pencabutan SIP karena staf resign
2	Rosi Slamet Saputri, S.Kep., Ns	Perawat	16 Juni 2025	Pencabutan SIP karena staf resign
3	Putra Kukuh Catur Ari, S.Kep., Ns	Perawat	16 Juni 2025	Pencabutan SIP karena staf resign
4	Linanda Devi Setya Pramita, S.Kep., Ns	Perawat	1 Juni 2025	SIP Mati
5	Apt. Ica Anindya Pangestika, S.Farm	Apoteker	1 Juni 2025	Pencabutan SIP karena staf resign
6	Linanda Devi Setya Pramita, S.Kep., Ns	Perawat	16 Juni 2025	Pengaktifan SIP

Keterangan :
Pada bulan Juni terdapat 1 case penonaktifan karyawan dikarenakan SIP mati dan diaktifkan pada 16 Juni 2025. Terdapat 5 pencabutan SIP karena staf resign.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Open recruitment setelah hari raya
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	9 April 2025	Orientasi Khusus	dr. Gusti Gandha Pandya	Profesi Kedokteran	Dokter Umum	09 April 2025	Orientasi khusus s/d 09 Juli 2025
2	01 Juni 2025	Orientasi Khusus	dr. Amanda Firmandani	Profesi kedokteran	Dokter Umum	01 Juni 2025	Orientasi khusus s/d 31 Juli 2025
3	01 Juni 2025	Orientasi Khusus	Nabila Rizki Amalia, S.Tr.Kes	D4 Analis Kesehatan	Analis Kesehatan	01 Juni 2025	Orientasi khusus s/d 31 Juli 2025

Keterangan :
Pada bulan Juni 2025 terdapat 3 staf yang menjalani orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK
1	Diklat Sosialisasi Penggunaan APAR 2025	Internal	311	83	9-10 Juni 2025	V	
2	Komunikasi Efektif Teori	Internal	287	107	21 Junj 2025	V	
3	Pelatihan KB RS	Internal unit tertentu	15	19	28 Juni 2025	V	
4	Diklat Drill Emergency	Internal unit tertentu	36	11	24 Juni 2025	V	

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

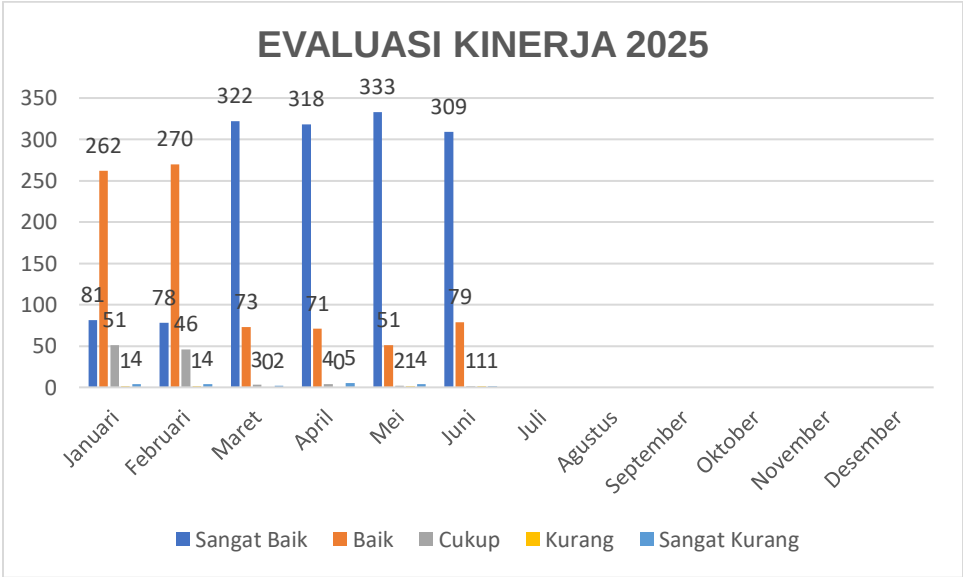
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit KAbid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	Kabid Keperawatan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Keperawatan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	2	22	18	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	3	2	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	17	0	15	2	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	25	0	21	4	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	11	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									penilaian kinerja umum.
17	IPSRs	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	27	0	23	4	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	15	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	15	0	13	2	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	9	0	7	2	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	24	0	21	3	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	9	0	8	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	10	0	9	1	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	9	0	9	0	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	18	0	16	2	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	45	1	32	12	1		Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	1	0	0	1	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
 Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Juni 2025.

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



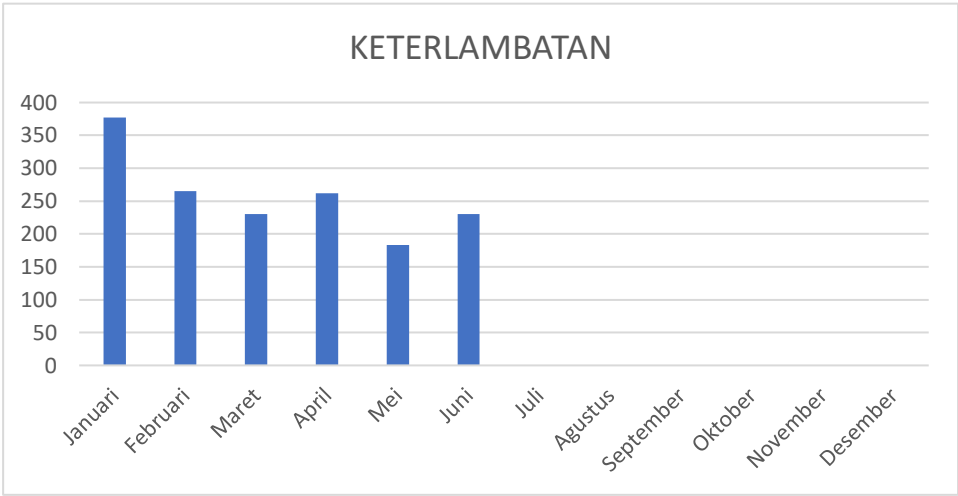
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333	309						
Baik	262	270	73	71	51	79						
Cukup	51	46	3	4	2	1						
Kurang	1	1	0	0	1	1						
Sangat Kurang	4	4	2	5	4	1						
TOTAL	399	399	400	398	391	391						

Analisa :
 Secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

Rencana Tindaklanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183	230						



Analisa :
Secara umum terdapat kenaikann keterlambatan karyawan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	1
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	1
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0

19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Kuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	1
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	3

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan karir telah dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%	100%	100%						

Analisa:
 Telah terlaksana supervisi dengan komite lain.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	-	-	-

Analisis : Pada bulan Juni 2025 tidak terdapat rotasi staf.

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61	66.6	92.3	76,92	89,74	69.2%						

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%
Juni	276	165	59.78%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26
Juni	15

Analisa :
Pada bulan ini, capaian maintenance alat berdasarkan ruangan 69.2% dan jumlah alat 59,78%. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis diluar RSPHM serta beberapa kondisi alat servis yang membutuhkan waktu lebih lama.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61
APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI	7	16	2	25
JULI				

AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :

Pada awal januari digunakan metode baru pencatatan kinerja terutama terkait system pencatatan dan target perbulan. Sudah dilakukan pencatatan metode baru, hasil evaluasi lebih baik dari tahun 2024.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D,E dan LVMDP dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

JUNI 2025							
TANGGAL	STOK LIQUID	SEBELUM PENGISIAN	PENGUNAAN	SATUAN	KETERANGAN	PENGIRIMAN	SATUAN
01/06/2025	2675	2437	238	MMHG			MMHG
02/06/2025	2437	2209	228	MMHG			MMHG
03/06/2025	2209	1951	258	MMHG			MMHG
04/06/2025	1951	1657	294	MMHG			MMHG
05/06/2025	1657	1400	257	MMHG			MMHG
06/06/2025	1400	911	489	MMHG			MMHG
07/06/2025	911	2995	0	MMHG	sesudah pengisian	2084	MMHG
08/06/2025	2995	2776	219	MMHG			MMHG
09/06/2025	2776	2576	200	MMHG			MMHG
10/06/2025	2576	2264	312	MMHG			MMHG
11/06/2025	2264	1980	284	MMHG			MMHG
12/06/2025	1980	1720	260	MMHG			MMHG
13/06/2025	1720	1480	240	MMHG			MMHG
14/06/2025	1480	953	527	MMHG			MMHG
15/06/2025	953	3345	0	MMHG	sesudah pengisian	2392	MMHG
16/06/2025	3345	3132	213	MMHG			MMHG
17/06/2025	3132	2869	263	MMHG			MMHG
18/06/2025	2869	2607	262	MMHG			MMHG
19/06/2025	2607	2365	242	MMHG			MMHG
20/06/2025	2365	2172	193	MMHG			MMHG
21/06/2025	2172	1941	231	MMHG			MMHG
22/06/2025	1941	1382	559	MMHG			MMHG
23/06/2025	1382	3236	0	MMHG	sesudah pengisian	1854	MMHG
24/06/2025	3226	3040	186	MMHG			MMHG
25/06/2025	3040	2732	308	MMHG			MMHG
26/06/2025	2732	2500	232	MMHG			MMHG
27/06/2025	2500	2251	249	MMHG			MMHG
28/06/2025	2251	2024	227	MMHG			MMHG
29/06/2025	2024	1500	524	MMHG			MMHG
30/06/2025	1500	3468	0	MMHG	sesudah pengisian	1968	MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			7495	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						8298	MMHG

Rata-rata penggunaan oksigen per hari			517,4814815	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3319,2	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

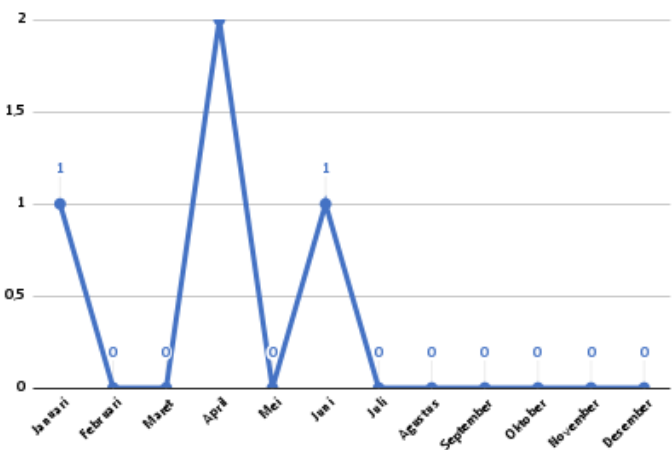
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0	1					

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



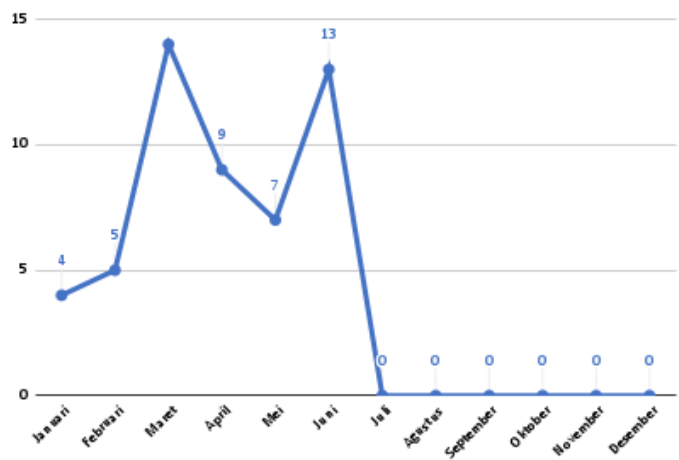
Analisa :
Pada bulan Juni terdapat 1 kehilangan barang

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7	13					

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
03 – 06 – 2025	Telah ditemukan kartu bpjs milik pasien di cso	Sudah di ambil pemilik
05 – 06 – 2025	Ditemukan kunci motor karyawan tertancap di motor	Sudah di ambil pemilik
10 – 06 – 2025	Hp milik pengunjung hilang di area ruang tunggu farmasi yang tidak terpantau kamera	Berkoordinasi dengan team IT perihal pemasangan cctv di area ruang tunggu farmasi
13 – 06 – 2025	Telah terjadi kehilangan uang milik karyawan di loker depo farmasi telah dilakukan penelusuran nihil dan tidak terpantau cctv	Berkoordinasi dengan team IT perihal pemasangan cctv di area ruang tunggu farmasi
19 – 06 – 2025	Ditemukan kunci motor karyawan tertancap di motor , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
22 – 06 – 2025	Ditemukan topi anak di pendaftaran central , diamankan dilaci pendaftaran central	Sudah diambil pemilik
24 – 06 - 2025	Ditemukan kunci motor karyawan tertancap di motor , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
25 - 06 – 2025	Telah ditemukan hp dan hasil lab milik pasien di poli ipd	Sudah diambil pemilik
26 – 06 – 2025	Telah di temukan identitas pasien berupa ktp di poli jantung	Sudah diambil pemilik
27 – 06 – 2025	Telah di temukan identitas pasien berupa kk di warung	Sudah diambil pemilik
30 – 06 – 2025	Telah ditemukan hp milik pengunjung di depan kursi ruang tunggu iko , diamankan di laci cso	Sudah diambil pemilik
30 – 06 – 2025	Telah di temukan tablet hp milik pengunjung di poli anak	Sudah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

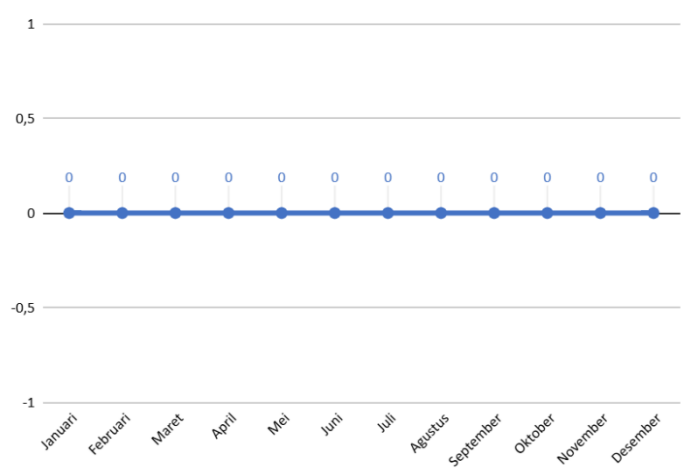
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0					

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :

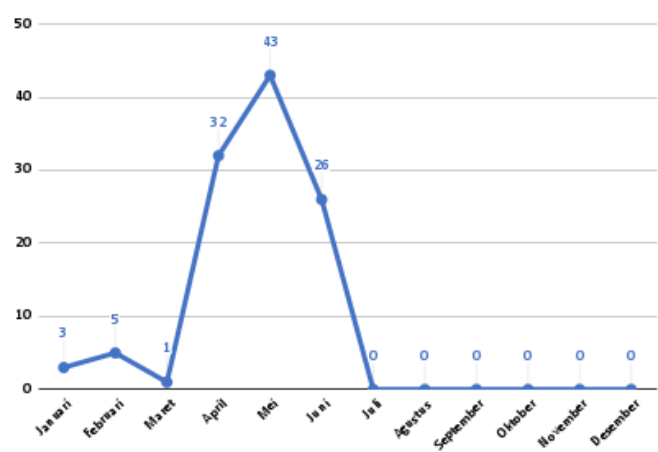
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	43	26						



Analisis :

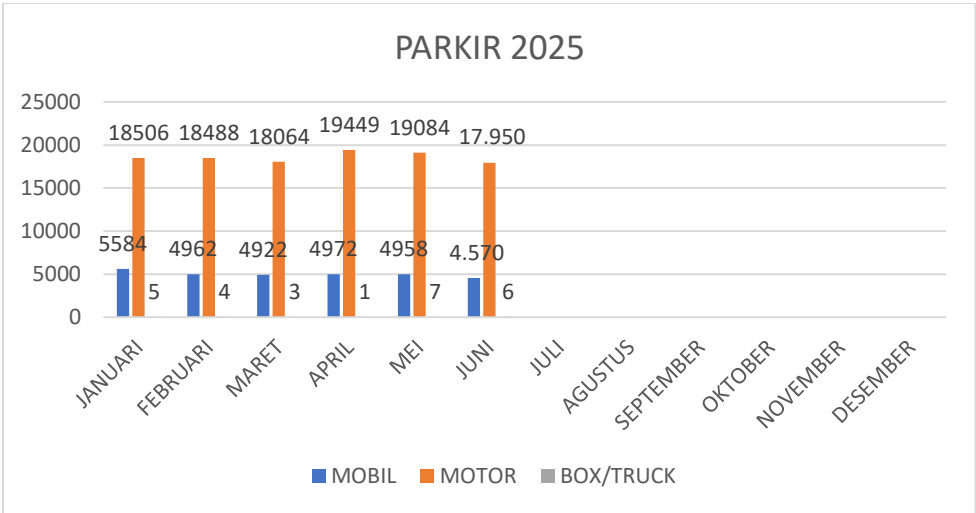
Security sudah mulai patuh dalam hal pelaporan dan rekap

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :

Progres parkir bulan ini menurun akibat jumlah hari aktif yang lebih sedikit serta fluktuatif kunjungan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah				Progres	Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru		
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	2 (review pihak kedua) 1 (progres evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
6	Juni 2025	2 IKS Baru	126	0	1	1	(2 Proses Review Pihak ke 2)	2
Analisis ;								

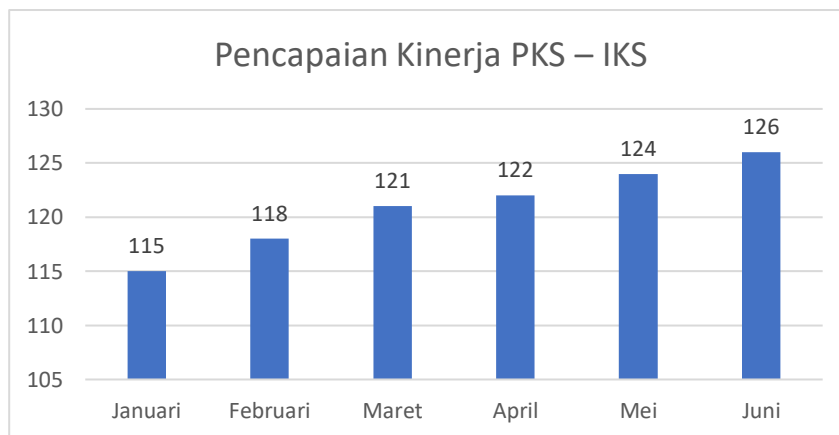
1. Pada bulan Juni 2025, PKS dengan instansi pemerintah masih dalam progress, Proses Review PKS dengan Pihak Perusahaan Baru.
2. Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Juni 2025

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April masih menunggu pihak sekda)	Proses pihak Dispenduk
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan
11	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
12	PT Pindad (Persero)	Review	Proses Pihak Kedua



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Juni 2025

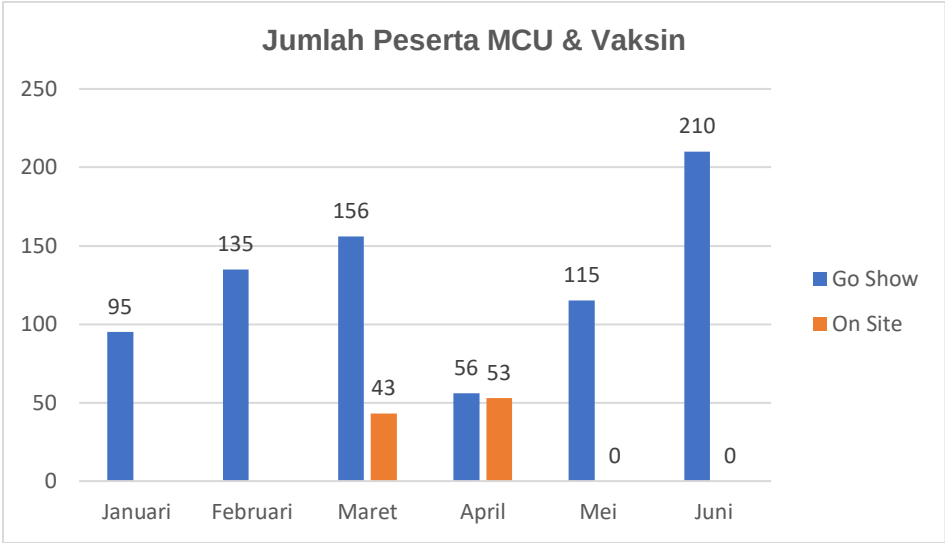
NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150	115	-
6	JUNI	150	210	-
7	JULI	150		
8	AGUSTUS	150		
9	SEPTEMBER	150		
10	OKTOBER	150		
11	NOVEMBER	150		
12	DESEMBER	150		

Analisis ;

Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Juni Meningkat 82,61% dari bulan Mei

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan Promosi melalui Social Media
2. Kunjungan ke Universitas, SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU Pelajar



3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
6	Juni	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 7 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 1 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2	2	2	17					

Analisa :

Kunjungan eksternal mulai dilakukan Kembali untuk sosialisasi kebijakan yang berhubungan dengan rujukan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

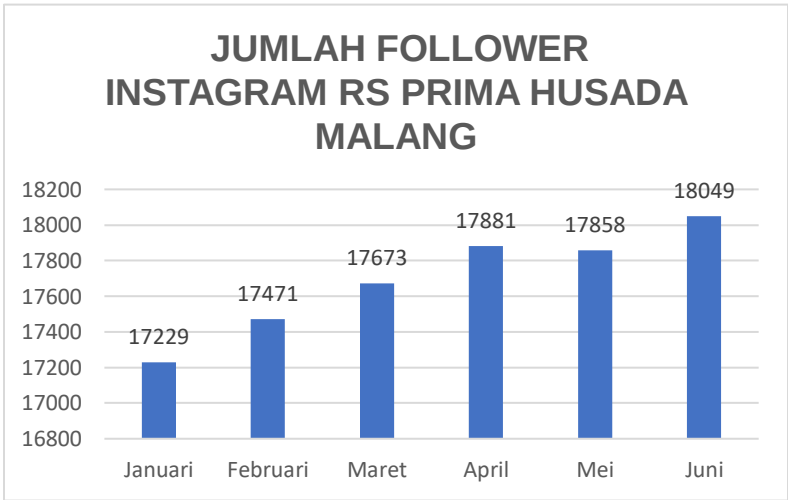
Monitoring dan evaluasi berkala.

4.5.5.2.4 Digital Marketing

4.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10	10	9						
REELS	5	5	11	5	1	1						
STORY	6	10	14	8	12	10						
TOTAL	14	22	34	28	23	20	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19	10	12						
FEED VIDEO	0	0	0	0	1	1						
REELS	3	4	5	7	1	1						
STORY	29	33	28	38	12	29						
TOTAL	38	48	49	64	24	43	0	0	0	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673	17.881	17850	18049						
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	374	286	0	0	0	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



Analisa :

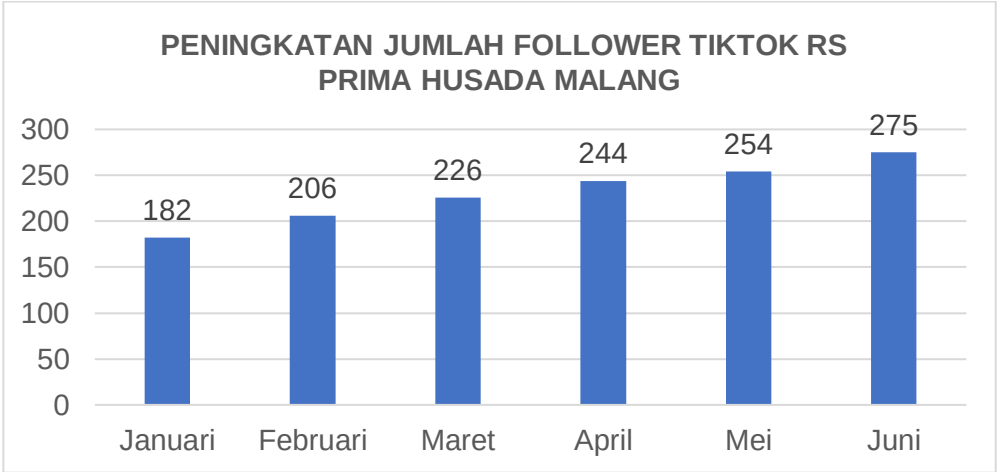
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.01% dari bulan Mei

- Rencana Tindal Lanjut :
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya

2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0	2	1						
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244	254	275						
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	10	21	0	0	0	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085	1187	1222						



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 0.082% dari bulan Mei

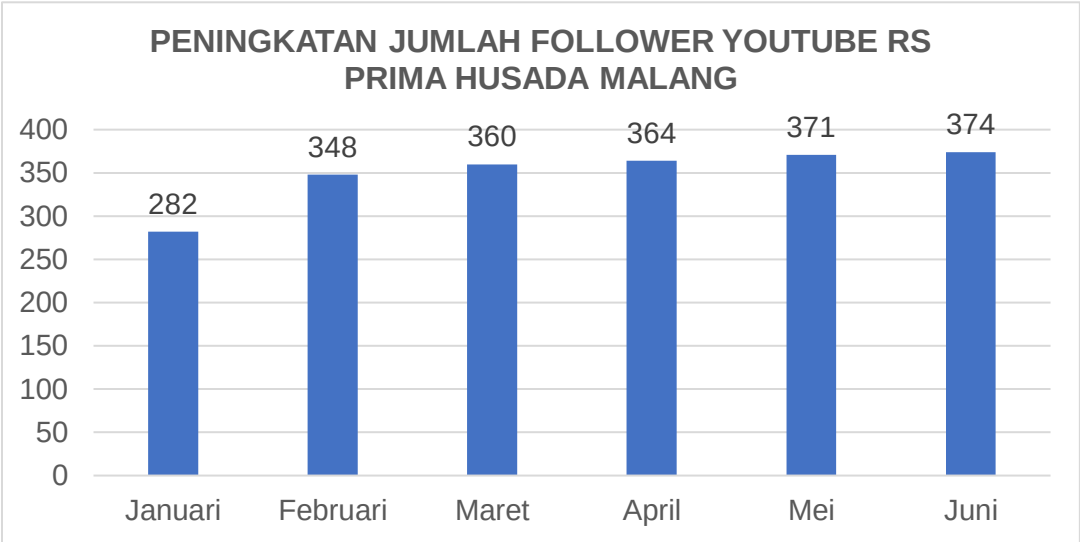
- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN	0	2	0	0	0	0						

BARU												
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364	371	374						
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	4	7	3	0	0	0	0	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

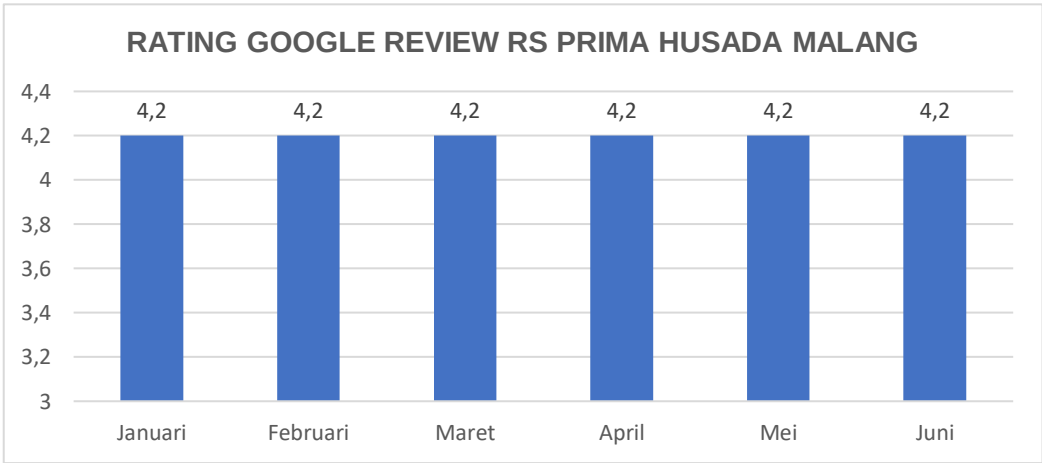


Analisa :
 Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1% dari bulan Mei

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2						



Analisa :

Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan Mei

Rencana Tindal Lanjut :

Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA BUNDA MALANG																
PERIODE 2025																
										Y	Z	AA	AB	AC		
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARA N (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUM PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE JUNI 2025 :																
1	Awaransi	232.513.549	140.041.269	5.462.756	87.003.504	191.602.604	74.133.159	3.864.929	113.604.516	200.614.019	170.157.753	15.449.251	959.449	3.958.973	16.449.374	200.614.019
2	Ponorsahan	205.838.888	42.352.734	0	162.886.094	87.305.678	3.328.000	-	83.377.678	AA	142.204.838	4.475.888	1.853.819	19.963.778	58.971.127	246.863.762
3	Mandiri Inkahealth	93.454.675	30.503.457	1.414.792	61.536.426	30.436.513	-	-	30.436.513	32.032.398	91.649.999	-	-	-	372.839	32.032.938
4	Jaya Rahajaya	74.460.342	73.540.024	0	320.918	111.897.234	30.300.023	-	0	21.597.271	22.518.169	21.597.272	-	-	928.917	22.518.169
5	BPJS KetersajaKerjan	738.891.091	662.907.320	4.325.044	71.658.367	423.146.577	-	-	423.146.577	434.804.944	445.741.892	46.792.957	375.199	1.831.469	814.524	434.804.944
									Total saldo	1.036.633.862	891.357.674	66.357.106	1.966.787	24.054.812	72.677.983	1.036.633.862

Keterangan : *Cut off* 30 Juni 2025 sebesar Rp 1.056.833.852

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinik kode I63 kurang sesuai, gunakan I69	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Pasien dengan diagnosa necrotizing fasitis dilakukan tindakan local excisi kode 86.3 kurang sesuai gunakan kode 86.2	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Diagnosa aki sesuai kriteria KDIGO, reseleksi N19	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Rujuk di hari yg sama diajukan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Indikasi rawat inap	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Bukti pendukung pel tidak lengkap, tidak ada hasil PA klain ajukan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Chf disertai edem paru menggunakan kode I50. 1	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Pasien post litrotripsi, pasien dengan aff stent dan urs gunakan kode 56.31	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
9	Pasien dengan diagnosa isk tidak di temukan eviden kultur, reseleksi kode R10. 4	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
10	Kunjungan rawat inap berulang potensi readmisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
11	Pemeriksaan gagal nafas sesuai dengan rekomendasi TKMKB	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
12	Rawat inap dengan approval tidak ada surat pernyataan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
13	Anemia bagian dari B90.9 tidak dikode terpisah	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

14	Hasil ro bronkovaskuler pattern normal tidak tampak infiltrat kode pneumonia di hapus	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Imr 3 bulan berulang terus menerus	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Tidak sesuai standart pel stroke fisioterapi 6 bulan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Tidak ada indikasi kegawatan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Tidak ada surat pernyataan bahwa pasien benar mendapatkan pelayanan di FKRTL	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

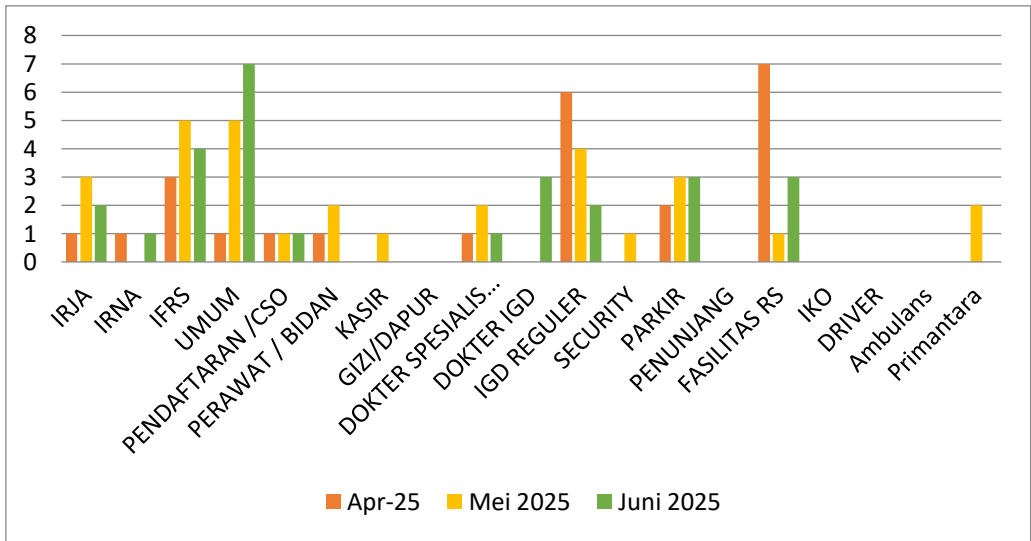
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Juni 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	IRJA	1	3	2
2.	IRNA	1	0	1
3.	IFRS	3	5	4
4.	UMUM	1	5	7
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	1	1
6.	PERAWAT / BIDAN	1	2	0
7.	KASIR	0	1	0
8.	GIZI/DAPUR	0	0	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	1	2	1
10.	DOKTER IGD	0	0	3
11.	IGD REGULER	6	4	2
12.	SECURITY	0	1	0
13.	PARKIR	2	3	3
14.	PENUNJANG	0	0	0
15	FASILITAS RS	7	1	3
16	IKO	0	0	0
17	DRIVER	0	0	0
18	Ambulans	0	0	0
19	Primantara	0	2	0
Total		24	30	27

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Juni 2025



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Juni 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal komplain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- 1. Jumlah complain Pada bulan Juni 2025 Meningkat dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan April 2025 sebanyak 24 pasien pada bulan Mei 2025 sebanyak 30 pasien Sedangkan pada bulan juni sebanyak 27 pasien
- 2. Komplain terbanyak pada bulan Juni 2025 yaitu dari bagian umum sebanyak 7 kasus, farmasi sebanyak 4 kasus, IGD sebanyak 2 kasus, IRJA sebanyak 2 kasus, parkir sebanyak 3 kasus, DPJP dan CSO sebanyak 1 kasus kasir, fasilitas RS sebanyak 3 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- 3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 5 kasus complain dengan rincian :
 - 1. Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
 - 2. Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu tersedia cenel TV yang banyak sehingga bisa menjadi hiburan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juni 2025

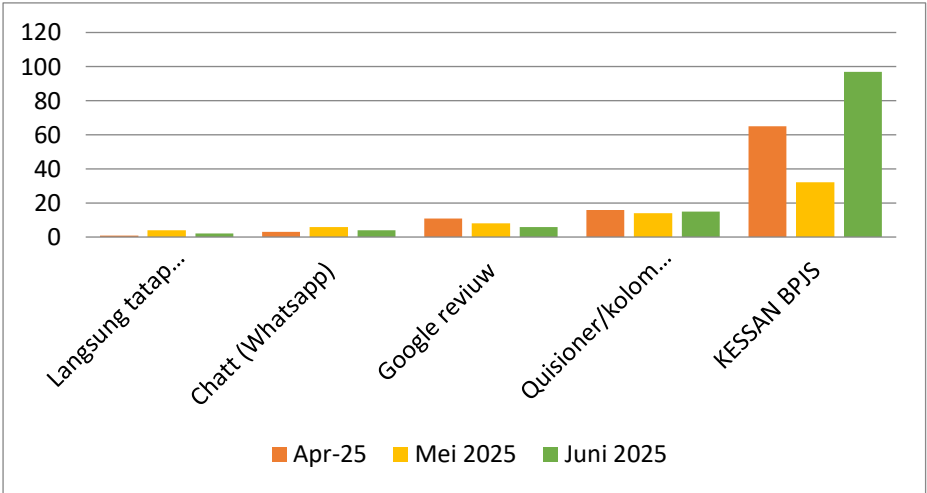
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	Langsung tatap muka	1	4	2
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	3	6	4
b	Google reviuw	11	8	6
3.	Quisioner/kolom kritik saran	16	14	15
4.	KESSAN BPJS	65	32	97

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	1	4	24	68

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juni 2025



Analisis :

Pada bulan Juni 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 15 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari WA/Chatt sebanyak 4 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Juni 2025

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 '	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 '	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	8	3	0
					70%	30%	
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	8	8	0
					50%	50%	
5.	KESSAN	100%	0	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Mei 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 50% dan dari google revium sebanyak 30% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen. Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 5 kasus complain dengan rincian :

- 1) Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
- 2) Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu tersedia cenel TV yang banyak sehingga bisa menjadi hiburan pasien.

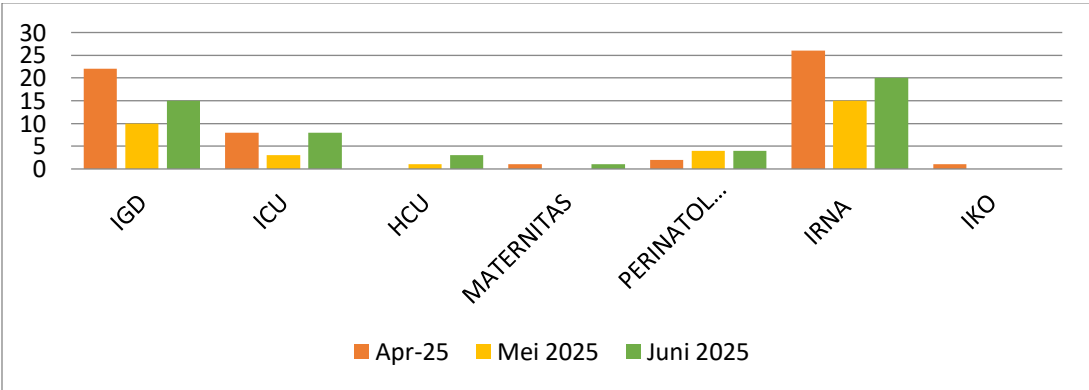
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Juni 2025

NO	UNIT PERUJUK	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	IGD	22	10	15
2.	ICU	8	3	8
3.	HCU	0	1	3
4.	MATERNITAS	1	0	1
5.	NEONATOLOGI	2	4	4
6	IRNA	26	15	20
7	IKO	1	0	0
Total		46	33	33

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Juni 2025



3.5.7.5.3 Tabel Rincian Pasien Rujuk Juni 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	AMANIE	IGD	Abdominal Pain susp gastritis ulceratif,	dr. Ardhani, Sp.PD	RS Karsa Husada	PRO ENDOSKOPI	3	TIDAK
2	TN. JAYADI	IRNA	CKD ON HD, ALO SYOK CARDIOGENIC, DILATED CARDIOMYOPATHI, PVC, EFFUSI PLEURA MASSIVE SINISTRA	dr. Aji, Sp. PD	RS Lavalette	Pro HD	3	TIDAK
3	TN. UNTUNG SUBAGIYO	UIGD		dr. Miryanti, Sp. JP	RSI AISYAH	PRO PERAWATAN INTENSIVE	1	TIDAK

4	TN. BUADI	ICU	susp Toxoplasma cerebri dd metastase, HIV, Edema Cerebri		RSUD Kanjuruhan	Pro penanganan perawatan HIV	2	TIDAK
5	NY. PAUWAN	IRNA	geriatric Syndrome, CKD St IV, CHF, Anemia	dr. Ardhani, Sp.PD	RSSA	Pro Geriatri Syndrome	4	YA
6	TN. SUDARTO	IRNA	TETANUS, SYOK CONDITION	dr. Aji, Sp. PD	RSSA	Pro PERAWATAN RUANG ISOLASI TETANUS	4	YA
7	Tn. Hantono	IRNA	1. Acute abdomen, Susp. ileus obstructive	dr Zaki, Sp.B	RSSA	Pro Laparatomy k/p stoma	2	TIDAK
8	Ny. Siti Mahmudah	IRNA	CKD, DM Tipe2	dr. Aji, Sp. PD	RSUD Lawang	Pro HD	5	TIDAK
9	TN HADI BIN AWAB	ICU	Syok Cardiogenik, ALO	dr Ira Sp JP	RS Lavalette	Pro perawatan lebih lanjut	6	Tidak
10	TN SUPII	IGD	Burn injury grade 2B 72%	dr Sigit Sp BP	RSSA	perawatan lebih lanjut	1	Tidak
11	TN. LEMBUR SOEMADIYO	ICU	Massive pericardial effusion, Syok cardiogenik, Efusi Pleura Dextra	dr Mira Sp JP	RSSA	Pro tapping (perikardiosintesis)	3	06/0
12	Ny. Haula	IRNA	Effusi Pleura, Hydropneumothorax (D)	dr. Andy, Sp. P	RSSA	Pertimbangan Pemasangan WSD	4	TIDAK
13	CHURI LAILIYATI SANGADAH	MTS	Post SC H5, VSD, HEMATURI, AKUT ABDOMEN	dr. Humaira, Sp. OG, dr. Ira, Sp. JP, dr. Edi, Sp. U	RSSA	Pro Laparotomi Cyto	4	TIDAK
14	Tn. Misadi	IGD	Retensio Urine ec susp. Blood clot dt Hematuria suspek Ca Buli, ACKD + Anemia		RSSA	Perawatan lebih lanjut kp HD	2	Tidak
15	Tn. Salim	IGD	stemi anterior killip onset > 12 jam	dr Yoga Sp JP	RST	Pro PCI	1	Tidak
16	Tn. Altrada Aryo Istiyanto	IRNA	DM, KAD	dr Ard hany Sp PD	RSSA	Pro Perawatan Sp PD-KEMD	5	Tidak
17	Ny. Gianti	IGD	Colic abdomen dd susp Ca Gall Blader dd Ca Hepar	dr Endra	RSSA	Pro perawatan hemato onkologi	2	Tidak
18	Ny. Siti Malichah	IRNA	Colic Abdomen dd Susp. Ca Gall blader dd Ca Hepar	dr. Yoga Sp.JP	RS Lavalette	Pro HD	2	TIDAK
19	By ny Any farihatun	NEO	BBLR, NEC,HMD	dr. Dicky Sp.A	RSSA	Pro Ventilator	3	TIDAK
20	Ny. Asniwati	IRNA	1. Sirosis Hepatis Cholelityasis Hipoalbumin	dr. Ardhani, Sp.PD	RSSA	pertimbangan endoskopi dan perawatan SpPD KGEH	4	TIDAK
21	TN SAIKHU	IRNA	SUSP TETANUS	dr. ZAKI, SP.B	RSSA	ISOLASI TETANUS	2	TIDAK
22	ny MIENTARSIH	ICU	Dyspnue ec Pneumonia D dd Pneumonia Aspirasi?	dr Andi, Sp.P	RSSA	pro TPN	3	TIDAK
23	TN. RUDI HARIYONO	IGD	STEMI	dr. yoga, sp. JP	RS UMM	pro PCI	1	TIDAK
24	NY. WIWIK SURYANI	ICU	ARDS, DM tp 2, UGIB variceal dt ruptur VE dd non Variceal dt PUB dd SRMD	dr Aji Sp PD	RSSA	Pro endoskopi dan pro tracheostomy	16	TIDAK
25	sdr. RIZKY AREMADIAZ	IRNA	Susp Pemphigus vulgaris	dr Vita Sp KK	RSSA	Pro endoskopi	1	Tidak
26	Ny.SITI KHOLIFAH	IGD	Struma, tumor mediastinum	dr Yoga SP JP	RSSA	Pro bedah Thorax	1	Tidak
27	An. DINDA ALENZA CANTIKA	IRNA	Pneumonia, Efusi Pleura	dr Dicky Sp A	RSSA	pro PICU	3	Tidak
28	An. M. Fath Abraar	IGD	Colic abdomen, nefrolitiasis bilateral multiple	dr Edi Sp U	RSSA	membutuhkan alat khusus	2	Tidak
29	NY. KALIMAH	ICU	STEMI Inferior	dr Ira SP JP	RSI Aisiyah	Pro PCI	2	Tidak
30	NY. SRI SUTARSI	IRNA	CKD ST III, Bacterial Infection, Ileus	dr. Ard hany, Sp. PD	RSSA	PRO Endoscopy dan Sp.PD KGEH	5	ya
31	Ny. FATHONAH	IGD	STEMI Inferior	dr. yoga, sp. JP	RST dr. Soepraoen	Pro PCI	1	TIDAK
32	WAGITRI	IRNA	CVA ICH Subcortex S Vol 25 cc post evakuasi ICH + HT	dr Fachriy Sp BS	RSSA	Pro Unit Stroke	12	YA
33	An. M. Reihan Alqatiri	IGD	Close Fracture Displaced Left Femoral Shaft Spiral	dr Kuntadi Sp OT	RSUD Kanjuruhan	Pro Flexible K-Nail	1	Tidak
34	Tn. Ja'far	IGD	COB	dr Ganda	RSUD Bangil	Pro Craniotomy	2	Tidak
35	Tn. Sunardi	ICU	Stemi Inferior, LV Failur	dr. Ira Sp. JP	RST	Pro PCI	1	TIDAK
36	By. Ny Indah Lailatus	NEO	BBLASR+ neonatal pnemonia+ apneu prematurity	dr. Ratih, Sp. A	RS lavalette	Pro NIPPV dan tatalaksana subspesialistik neonatologi	4	TIDAK
37	Ny. Widji Asrini	IRNA	cva emboli 2nd attack	dr. Dewi Sp.S	RS lavalette	Stroke unit	2	TIDAK
38	Ny. Satiah	ICU	Cardiogenic Syock, AF RVR	dr. Miryanti, Sp. JP	RSI Alsyah	Pro CVCU	4	TIDAK
39	A.n MUHAMMAD MAHER MALIKI HIDAYATULLOH	IRNA	Cervical Spasm, Trismus susp Tetanus Generalisata	dr. Dicky Sp.A	RST dr. Soepraoen	Pro picu+ head mri atau spine	2	TIDAK
40	Tn. Maskan Tono	IRNA	SUSP. IMA ANTERIOR, LO, COPD , HHD	dr. Elvi, SP.P., konsul dr. Yoga, Sp.Jp.,	RST dr. Soepraoen	Pro PCI	4	TIDAK

				konsul dr. Ardhi, SP.PD				
41	Ny. FIRMIASIH	IRNA	SAH ec RUPTUR ANEURISMA	dr Farid, Sp.N	RSSA	PRO DSA DAN COILLING / CLIPPING	1	TIDAK
42	Ny. kasimah	IGD	CF os femur (D)	dr.Arianto , Sp.Ot	RSSA	PRO Tindakan dengan alat khusus	2	TIDAK
43	By. Ny Lia Setyo Rimawati	NEO	NP-Spt	dr Ratih, Sp.A	RS lavalette	Pro NIPPV dan tatalaksana subspesialistik neonatologi	3	TIDAK
44	Ny Sutik	IGD	Susp CVA SAH	dr Farid, Sp.N	RS UMM	Pro pro DSA + coiling / clipping	1	TIDAK
45	Tn. SOLEH ROFII	IRNA	SUSP. PERITONITIS	dr Anton, Sp.B	RSSA	Pro IPD Infeksius dan Pro Bedah Digestive	3	TIDAK
46	NY INDRI	IGD	CHEST PAIN EC SUSP NSTACS	dr Mira, Sp.JP	RSI Aisyah	Pro PCI	1	TIDAK
47	Ghefano Haidar	IRNA	Susp meningoencephalitis	dr Dicky Sp A	RSSA	Pro dokter subspesialis	2	TIDAK

Analisis :

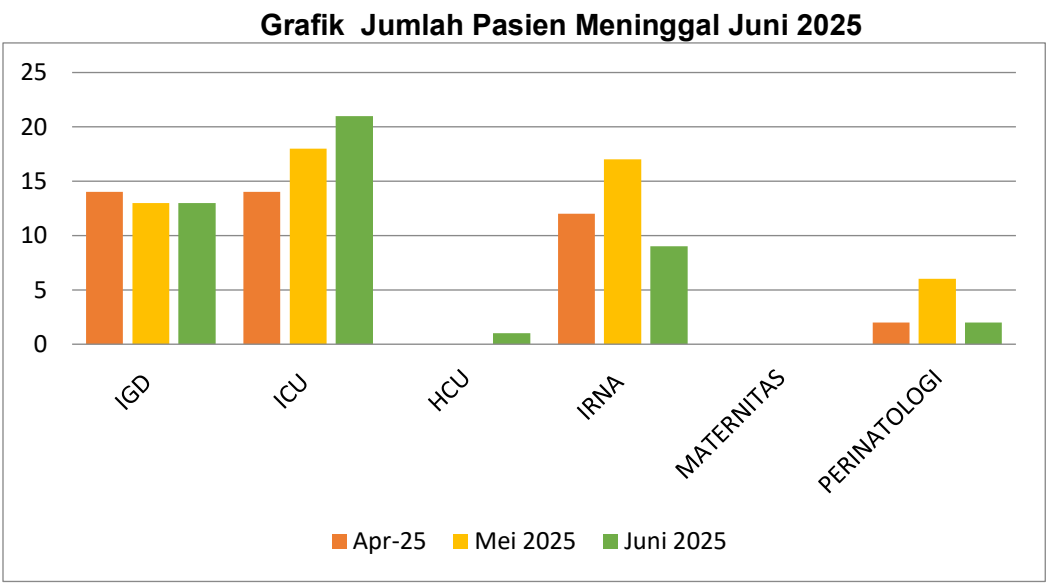
- Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Juni 2025.
 Pada bulan April 2025 sebanyak 60 pasien pada bulan Mei 2025 sebanyak 33 pasien Sedangkan pada bulan Juni 2025 sebanyak 47.
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - Pro Bedah digestif
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Membutuhkan alat khusus

Rencana Tindak Lanjut:

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Juni 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1.	IGD	14	13	13
2.	ICU	14	18	21
3	HCU	0	0	1
4.	IRNA	12	17	9
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	2	6	2
Total		22	54	47



Tabel Rincian Pasien Meninggal Juni 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Ny.Satini	IRNA	ARDS	dr. AJI Sp.PD konsul dr.Heru Sp.An
2	NY. JUMIATI	IGD	pneumothorax, Krisis hiperglikemi	dr. Ira SP.JP konsul dr. Aji SP.PD
3	NY.Nani Suhaeni	ICU	DM Hiperglikemi, ARDS, ANEMIA	dr.Aji.,Sp.PD konsul dr.Heru.,Sp.An
4	sdr imam agung	HCU	colic abdomen, syock condition,	dr.Aji.,Sp.PD
5	Tn. darmaji	IRNA	expose shunt infected shunt	dr Fachri Sp BS
6	tn Kosbianto	ICU	Anemia, ARDS	dr Aji Sp PD
7	TN EDI WICAKSONO	IGD	DOA	dr Yuniar
8	ny. karniti	IRNA	hipotensi, dm, pneumonia, syok condition	dr. Ardhany, Sp. PD
9	SDR. MOCH BIMAS SANDA	IGD	DOA	dr. Yuniar Ardy
10	Tn KAMISAN	ICU	Syok Condition, Colic abdomen, DM Tp 2, ARDS	dr Ardhany Sp PD
11	Ny HJ. Praptini	ICU	ARDS, ALO	dr Ira SP JP
12	Tn. Hari Rekso	ICU	Pneumonia, Respiratory Failure, Hipokalemi, Sepsis	dr Elvi Sp P
13	Tn. UFIK RAHMADANI	IGD	DOA	dr Yuniar
14	Tn. MAHMUDI RIYONOI	ICU	Post Op Laparotomy, peritonitis gaster, ARDS	dr Zaky Sp B
15	Tn. SUMARI	IGD	Susp Ilius Obstruktif	dr Anton Sp B
16	Tn.Marwanto	ICU	Lung TB Inaktif dd aktif, DM, gagal nafas	dr Andy Sp P
17	Ny Astutik	IRNA	DM Hiperglikemia pos HHS, Sepsis	dr Ardhi Sp PD
18	Tn. M KARIONO	IGD	DOA	dr Fira
19	Tn. SANALI	IGD	CARDIAC ARREST	dr Yeni
20	Elisabet Gandaimu	ICU	ARDS, DOC dr Uremic Encephalopatyy dd AKI	dr Aji, Sp.PD
21	Ny Su'ah	ICU	Post Op laparatomy	dr. Zaki sp B
22	Tn. SUBEJO H	IGD	DOA	dr Andira
23	Ny. DIAN EKO S	IGD	DOA	dr. Yuniar Ardy
24	TN. VARDIAN BUDI SANTOSO	IGD	DOA	dr Safira

25	Ny Nasirah	ICU	Syock Hipovolemik, ARDS	dr. Ardhany sp .PD
26	By Ny Atika	NEO	Imatur, BBLASR	dr Aida Sp OG
27	Ny. SUMIARI	IGD	DOC ec Susp CVA	dr Farid Sp S
28	Ny.Endang Supiati Ningsih	ICU	DM Hipoglikemia, DM Nefropahaty	dr Ardhi SP PD
29	Ny. Rumi	ICU	ARDS, Syok Septic, CKD	dr Ardhany Sp PD
30	Tn. Ngatoko	ICU	Pneumonia, Respiratory failure.	dr Elvi Sp P
31	TN. SUNARDI	IGD	DOC ec DSS	dr Ardhany Sp PD
32	Tn. Sali	ICU	ARDS, Syock septic, CKD	dr Mira Sp JP
33	Tn. Agus Jainul ulum	ICU	Struma uninodusa toxica dd limfadenetis	dr Ardhany Sp PD
34	Tn. Samsul Arifin	IRNA	CVA Thrombosis, DM 2, CHF	dr. Fahimma, Sp. N raber dr. Mira, Sp. JP konsul dr.Ardhany, Sp. PD
35	Ny. Tri Mulyani	IRNA	COR, ICH, SAH, Vuln app regio supraorbita	dr. Zaki sp B
36	Ny. SATI	ICU	RESPIRATORY FAILURE	dr. Ardhi Sp.PD
37	Tn. Mohammad Zaenul Abidin	IRNA	Susp. Tetanus Generalisata	dr Zaki, Sp.B
38	Tn. M. Kolim	ICU	CVA thrombosis, DM 2, RF	dr. Fahimah, Sp. N
39	Tn. Abdul Rochman	IRNA	NSTEMI, PVC, Hipokalemi, Dislipidemia, DM, UAP	dr. Ira, Sp. JP
40	Ny. RUPI'ATI	ICU	ARDS, EFUSI PLEURA DEX MASIF EC SUSP TU PARU	dr Elvi Sp P
41	Tn. SETIAWANTO	IRNA	DM Type 2, Anemia, Pneumonia, Syok Condition	dr Aji Sp PD
42	Ny.Siti Maimunah	ICU	Tumor Mammae Dextra Susp.Maligna, Efusi Pleura	dr Zaki Sp B
43	Ny. Chanifah	ICU	cva infark. .tb milier, Respiratory failure	dr. Farid Sp.N
44	Tn. ZAINAL AZMAN BIN OMAR BAKHI	IGD	CARDIAC ARREST	dr Safira
45	Tn Sakri	ICU	CVA ICH	dr Farid, Sp.N
46	By. Ny. Siti Rosita	NEO	IUFD	dr. Humaira, Sp. OG

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Juni 2025 sebanyak 46 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 21 pasien IRNA 9 pasien IGD : 13 pasien, HCU sebanyak 1 pasien dan Neonatologi sebanyak 2 pasien.
3. Pada bulan Juni 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 7 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Usia lanjut	-	-	-
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastrofik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-

7	Potensial komplain tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain - lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-
4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penangguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

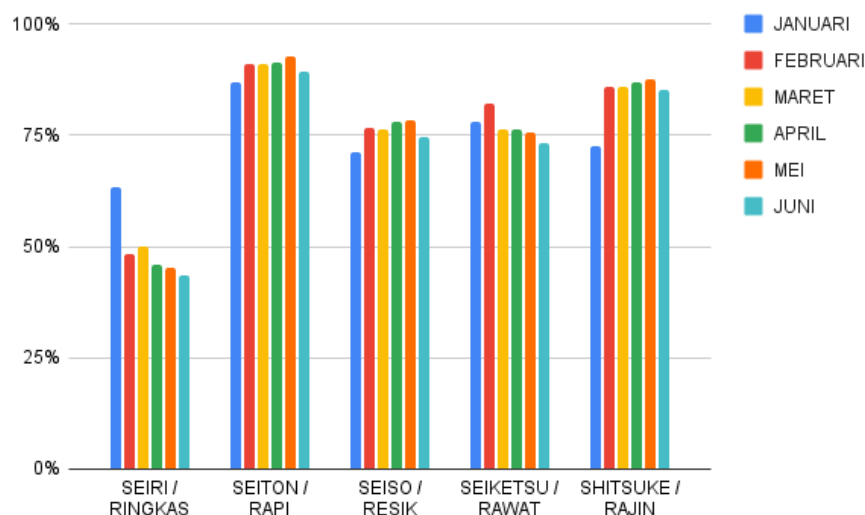
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%	44%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%	89%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%	75%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%	73%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%	85%



Analisa :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih dalam money karena memakai instrument supervise yang baru. Hasil masih fluktiatif dan dalam relative baik.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

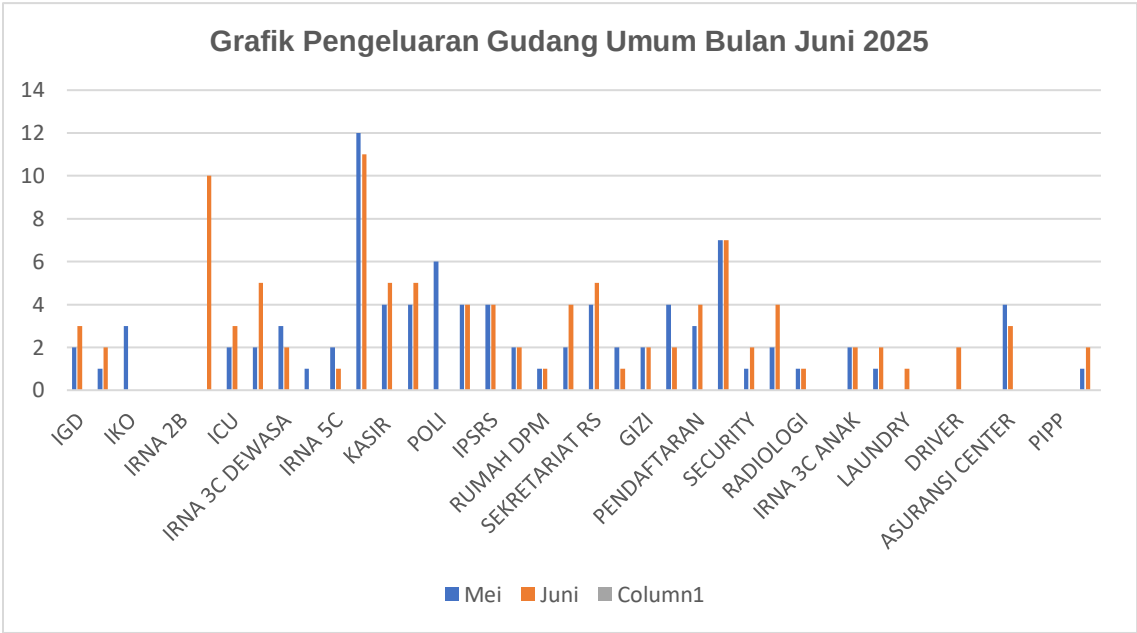
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		MEI	JUNI	
1	IGD	2	3	↑33,33%
2	MATERNITAS	1	2	↑50%
3	IKO	3	0	↓0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	0	10	↑100%
7	ICU	2	3	↑33,33%
8	IRNA 3A+4A	2	5	↑60%
9	IRNA 3C DEWASA	3	2	↓-50%
10	IRNA 4C	1	0	↓0%
11	IRNA 5C	2	1	↓-100%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	12	11	↓-90%
13	KASIR	4	5	↑20%
14	DAPUR	4	5	↑ 20%
15	POLI	6	0	↓0%
16	CLEANING SERVICE	4	4	↓0%
17	IPSRS	4	4	↑0%
18	GUDANG FARMASI	2	2	↓0%
19	RUMAH DPM	1	1	↓0%
20	SEKRETARIAT PT	2	4	↑50%
21	SEKRETARIAT RS	4	5	↑20%

22	CSSD	2	1	↓-100%
23	GIZI	2	2	↓0%
24	REKAM MEDIS	4	2	↓-100%
25	PENDAFTARAN	3	4	↑25%
26	DEPO FARMASI	7	7	↑0%
27	SECURITY	1	2	↑50%
28	LABORATORIUM	2	4	↑50%
29	RADIOLOGI	1	1	↓0%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	2	2	↑0%
32	NS NICU	1	2	↑50%
33	LAUNDRY	0	1	↑100%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	0	2	↑100%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	4	3	↓-33,33%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	1	2	↑50%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , Depo farmasi dan Irna 2C

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 - 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 - 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

3.5.10.1 Capaian Tata Laksana Keluhan

NO	JENIS KELUHAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
1	Keluhan terkait software	22	22	100%
2	Keluhan terkait hardware	111	111	100%

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.5.10.2 Rekapitulasi Kejadian Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1.	14/6/2025	Tidak Terencana	60 menit (16.00-17.00)	Down server BPJS	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs
4	20/6/2025	terencana	4 Jam (22.00-02.00)	Maintenance server bpjs	Edukasi sesuai ederan
3	24/6/2025	Tidak terencana	30 menit (06.30-07.00)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

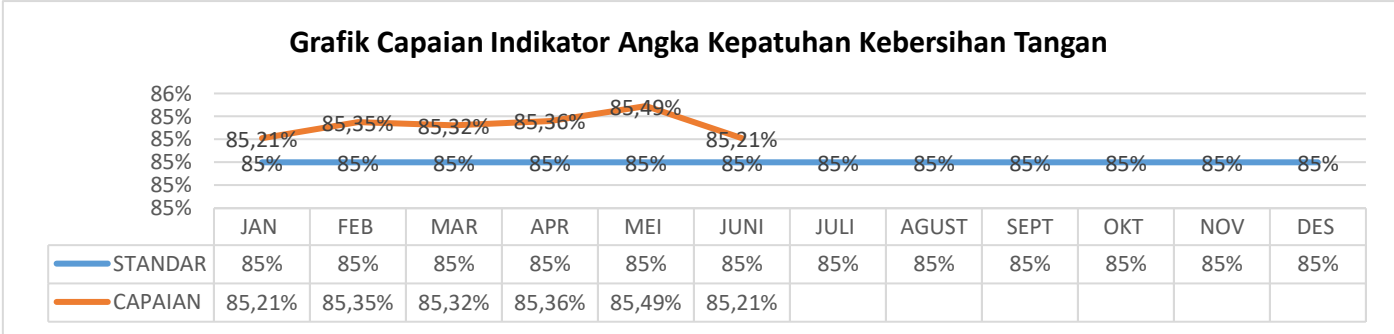
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%							85,29%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%							93,05%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%							99,74%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%							92,54%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%							75,68%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%							98,07%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%							99,16%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%							99,97%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%							99,86%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



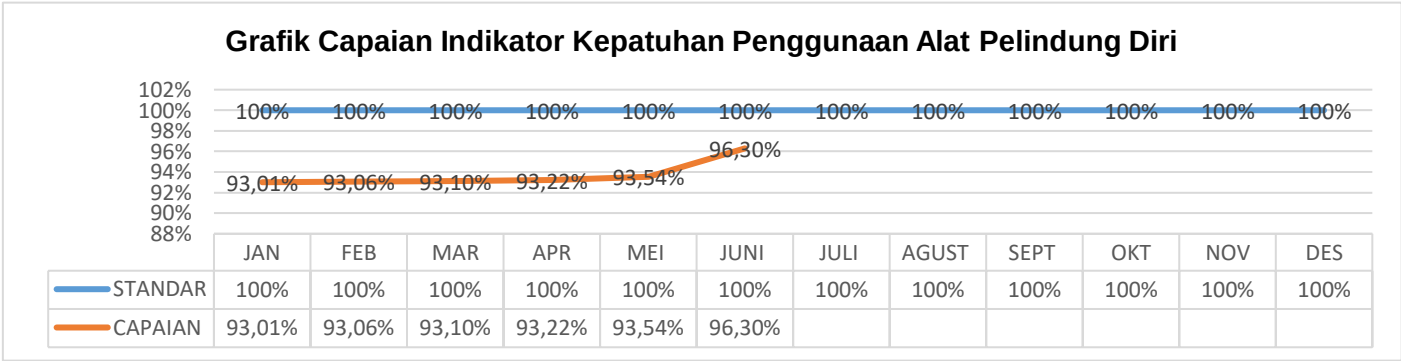
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capaian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49% dan capaian di bulan Juni adalah 85,21 dengan rata rata bulan Januari hingga Juni yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capaian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49% dan capaian di bulan Juni adalah 85,21 dengan rata rata bulan Januari hingga Juni yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter	Satu bulan

			2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	3. Karu 4. IPCLN/PCN	
--	--	--	--	-------------------------	--

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



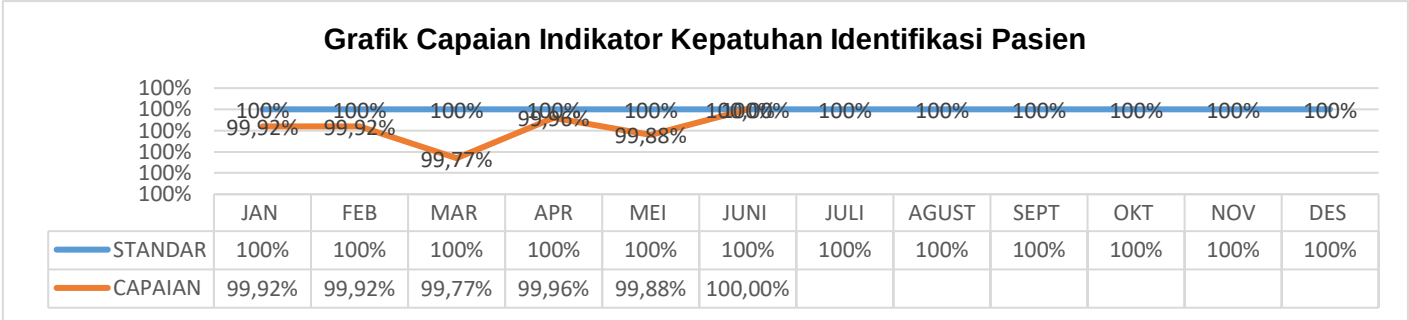
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan

	Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54% dan bulan Juni 96,3% dengan rata-rata 93,7%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

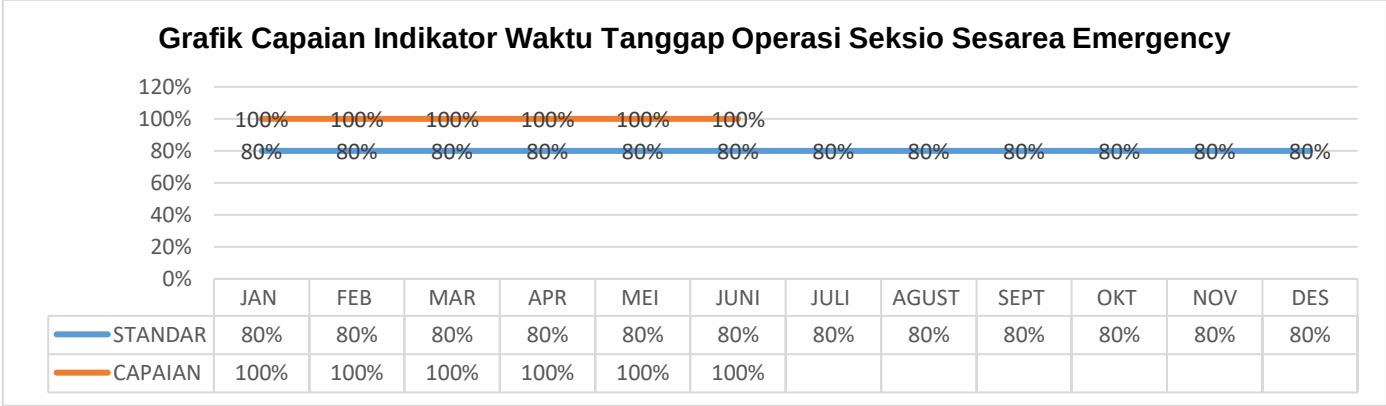
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juli tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96%, capaian di bulan Mei 99,88% dan capaian di bulan Juni adalah 100% dengan rata rata 99,85%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

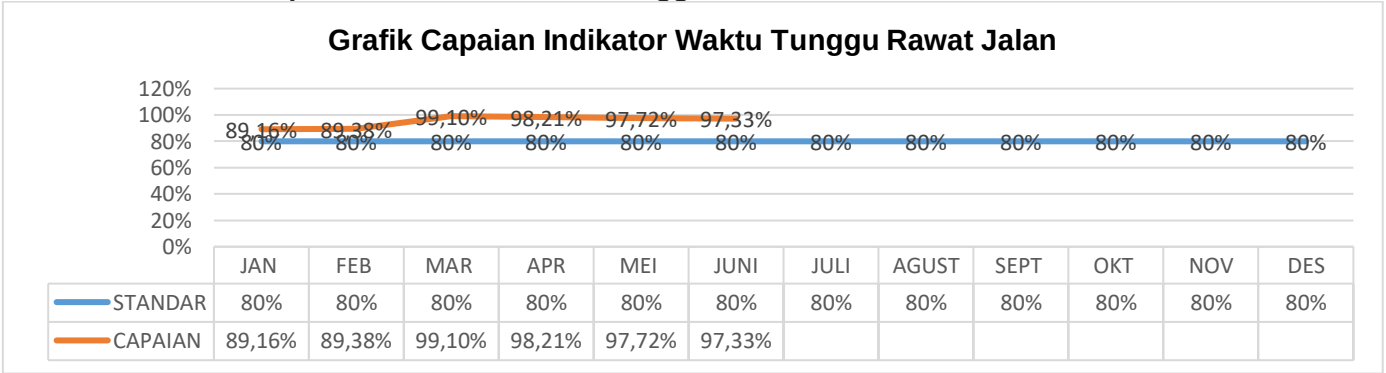
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

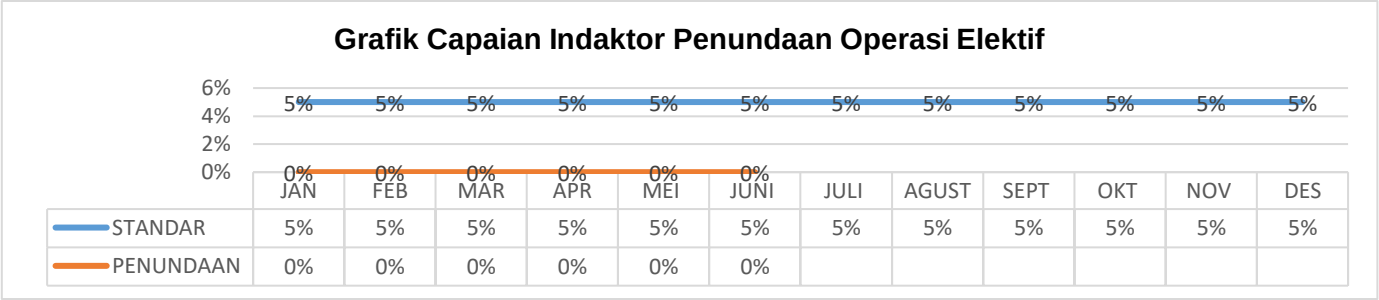
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71% dan capaian di bulan Juni adalah 97,33% dengan rata-rata 93,13%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

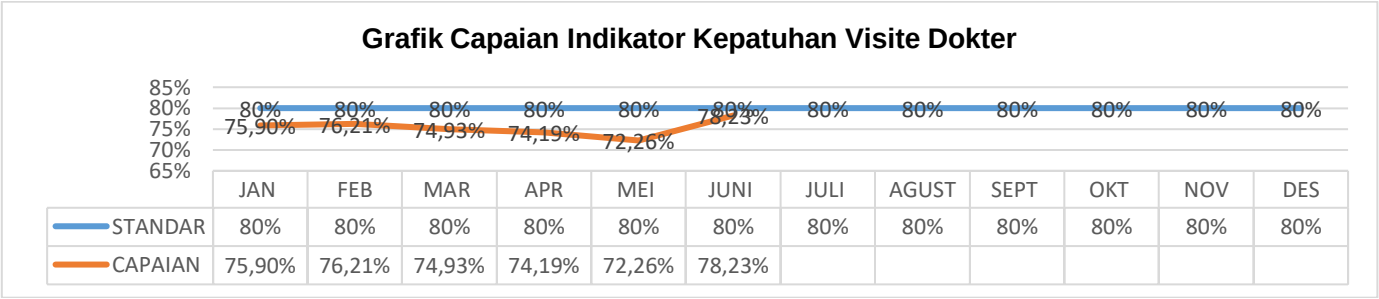


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Juni tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

2.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

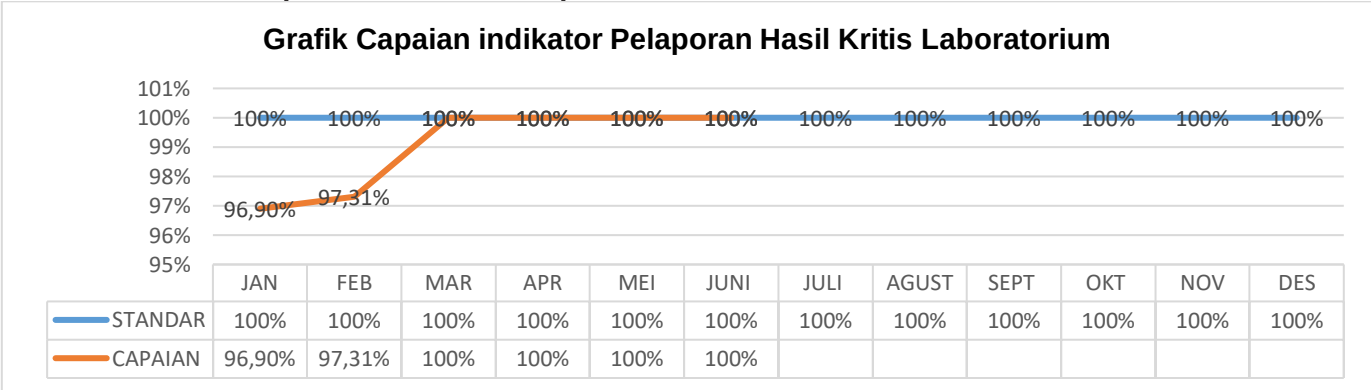


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Juni Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan february yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26% dan capaian di bulan Juni yaitu 78,23% dengan rata-rata 75,3%. Dari hasil supervisi didapatkan Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena sebagian besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Tahun

2.6.1.1.7.2 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

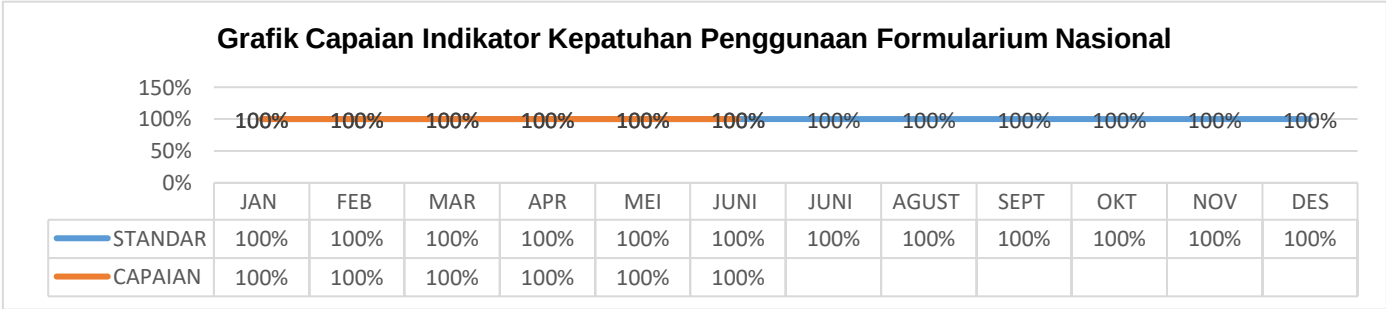


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga Mei. Capaian meningkat pada bulan Maret hinga Juni yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Juni yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

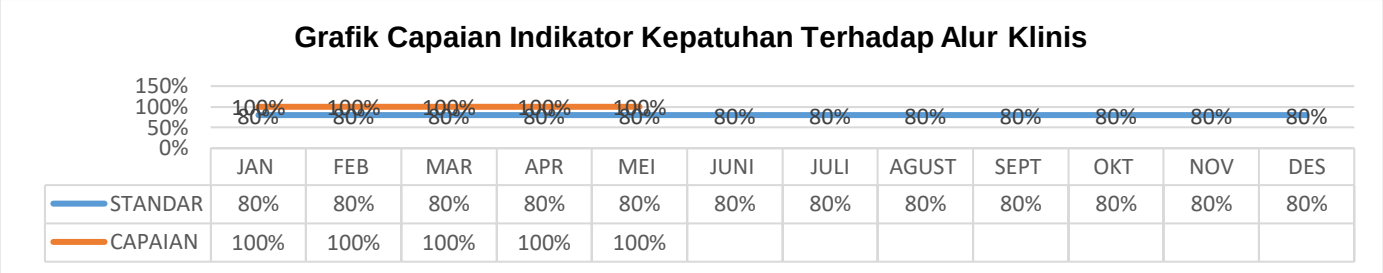
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

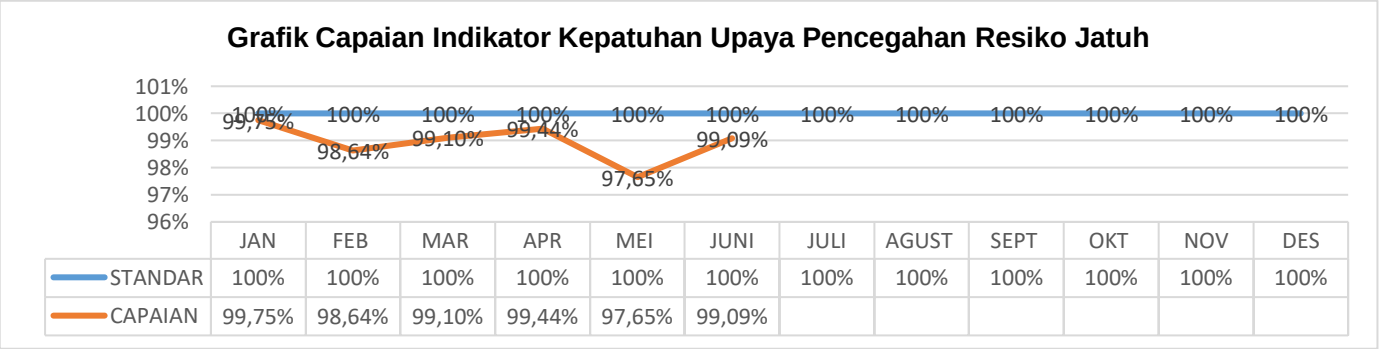
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

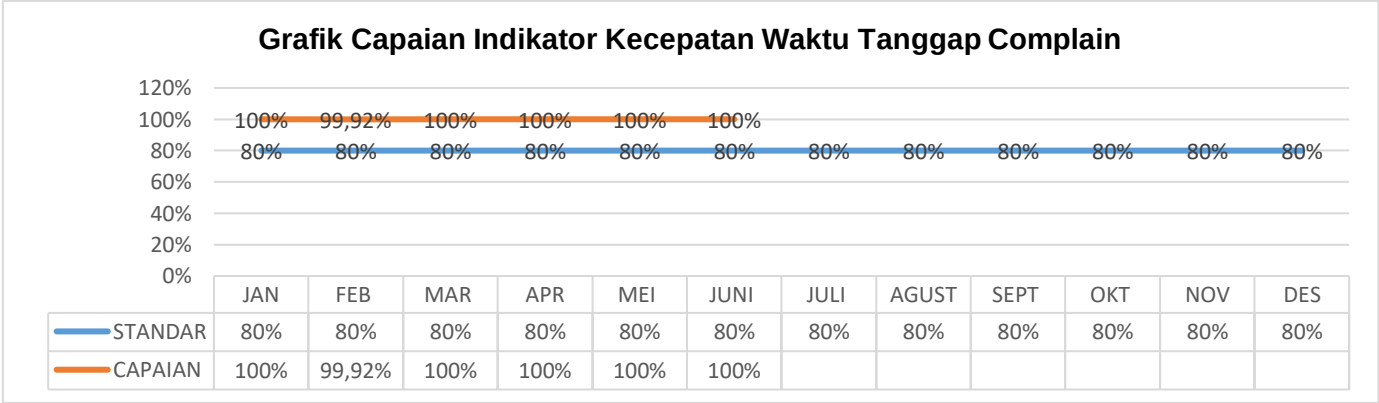


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Juni Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65% dan capaian di bulan Juni adalah 99,09% dengan rata-rata 98,95%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

3.6.1.1.7 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

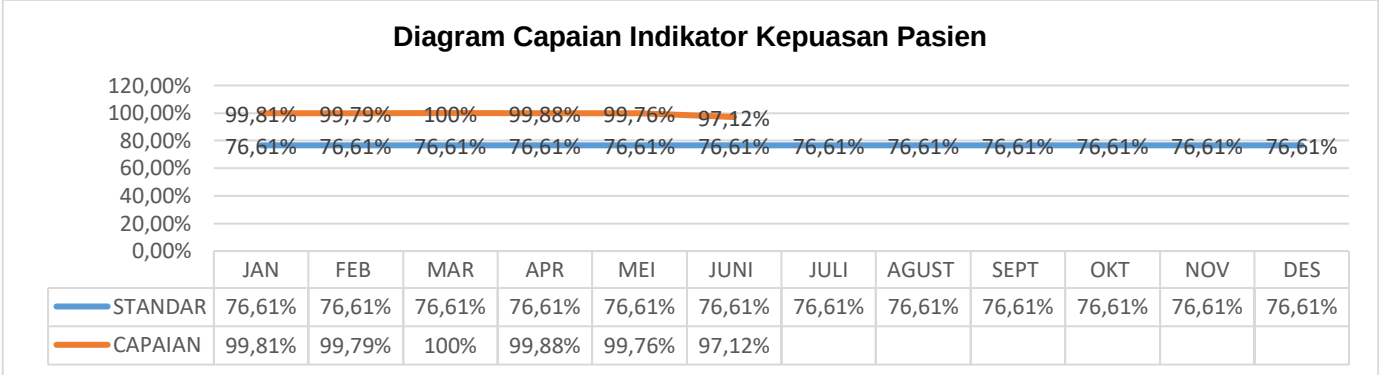
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga Juni tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,85%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99.39%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%							99,85%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%	99,93%							99,66%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%	100%							98,48%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	98,85%							98,37%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0	0							0%

6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspada / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%	97,63%							97,9%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%	99,31%							99,05%
11.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%	98,48%							98,48%
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%							85,32%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%	99,76%	97,12%							

2.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%	89,35%	86,4%							85.95%

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%	99,48%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%	96,03%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2	98,92%	98,45%							
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%	100%							
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%	5,43%							
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%	100%							
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0	0							
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1	0							

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-	-					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-	-					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-	-	-					

4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-				-	-					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-	-					
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-	-					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-	-					
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-	-					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-	-					
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-	-					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-	-					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-	-					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-	-	-					
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-	-					
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-	-					
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-	-					
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-					

20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-					
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-	-					
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-	-					

3.6.1.2.6.3 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%	96,32%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%	97,24%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%	94,58%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%	100%							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%	96,93%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%	100%							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%	100%							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-	4,52%	1,81%							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-	100%	100%							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%	100%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%	100%							

3.6.1.2.6.4 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%							

2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%	98,24%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%	97,32%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%	92,93%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%	100%							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%	100%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%	41,67%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%	100%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%	100%							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%	100%							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,32%							

18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%	2,3%							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%	59,7%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%	58,82%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizental)	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%	100%							

3.6.1.2.6.5 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%	98,79%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%	91,23%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%	80,95%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%	86,09%							

8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%	97,14%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%	100%							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	53,85%							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	75%							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	45,45%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%	70,83%							
-----	---	------	------	------	------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.6 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%	97,81%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%	97,8%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%	100%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%	1,53%							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%	100%							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.7 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%	98,92%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%	99,71%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%	97,96%							

5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%	68,75%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%	69,57%							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%	91,67%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%	100%							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%	100%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%	80,77%							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%	56,25%							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%	100%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	100%	100%							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	0%	-							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%							

	dibawa pulang														
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	100%	100%							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%							

3.6.1.2.6.8 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%	95,92%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%	98,88%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%	65,94%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,13%							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,66%							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%	0%							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	-							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.9 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%	98,27%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%	96,71%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%	88,42%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%	69,44%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%	100%							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%	100%							

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%	1,32%							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	100%							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6. 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%	99,02%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%	98,34%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	99,01%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%	66,67%							
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-							

7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%	1000%							
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.11 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%	99,51%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%	99,72%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%	94,32%							
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%	100%							
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-							
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	1,4%	-							
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	-							
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%	100%							
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%	100%							
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.12. HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%	98,22%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%	98,91%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%	97,3%							
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%	100%							
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-							
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0	-							
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-							
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.13 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S	100%	100%							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%	96,32%							
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%	97,44%							
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%	100%							

5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%	98,72%	97,33%							
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%	81,86%							
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48		15	17							
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.14 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%	43,75%							
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
8.	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%	0%							
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2	0							
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12	15							
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0	0							
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1	3							
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0	0							
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%							
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%							
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72	90							
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0	0							
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0							

3.6.1.2.6.15 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1	1							
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%	99,98%							
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%	99,84%							

4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%	87,3%							
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%	98,86%							
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,88%							
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	94,92%							
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,92%							
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							

20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-							
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (neonatus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							

6.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%	98,74%							
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%	98,73%							
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-							
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-	-							
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0							

3.6.1.2.6.17 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0							
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
4.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%							
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0	0	0							
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0							
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0							
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0							
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0							
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0							
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0	0							
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0							
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0							
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0	0							

16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0	0	0							
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%	21,05%	42,31%							
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%	98,22%							
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.18 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5	0							
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%							
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%	100%							
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005							
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0							
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.19 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%	100%							
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%	7,4%	6,22%							
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%	100%	100%							
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%							
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.20 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0							
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2	0							
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0							
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dam lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21&	99,42%	99,82%	98,92%							
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%	99,31%							

3.6.1.2.6.21 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1	0							
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0							
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%	55,10%							
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%	31,35%							
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3	1							
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1	0							
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0							
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1	0							
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0							
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0	0							
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42	32							

15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektivitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
16.	Kepatuhan penyimpanan obat-obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%	89,92%							
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%	100%							
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.22 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%	0,45%							
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.23 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%							
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰							
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 %	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰							
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 %	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰							
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%	0,61%							
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,32%							
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%	93,74%							
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%	93,74%							
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0							

3.6.1.2.6.24 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%							
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%							
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%	18,12%	16,32%							
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%	99,98%	100%							
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.25 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0	1							
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%	98,66%							
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%	2,03%							
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.26 Rekam Medis

No .	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%	50,36%	36,06%							
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%	0,23%							

3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8% %	98,04%	1,57%	7%	6,67%							
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	10,23%	2,05%							
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0							
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%	10,47%							
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%	96,2%							

3.6.1.2.6.27 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0	0							
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0							

3.6.1.2.6.28 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0	0							
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%	1,19							
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%	1,31							
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%	98,8%							
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0	0							

3.6.1.2.6.29 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%	78%							
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%	97%							

3.6.1.2.6.30 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4	2							
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4	3							

3.6.1.2.6.31 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%	35,4%							
2.	Kejadian komplain Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0	0	0							
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%	97,88%							
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%	99,02%							

3.6.1.2.6.32 KESEKRETARIATAN

	No	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%	47,62%							
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%	9,09%							
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%	20%							

3.6.1.2.6.33 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%	2,5%							
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0							
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1	0							
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%	100%							
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%	100%							

3.6.1.2.6.34 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1	1							
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1	1							
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%	100%	100%							

3.6.1.2.6.35 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%	86,73%							
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%	88,21%							
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%	81.44%							
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%	70,22%	76,22%							

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0							
2	Resptime penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	0	0	0							
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	100%	100%	100%							
3.	Kepatuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	1005	1005	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.38 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%	82,75%							

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%	100%							
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%	100%							
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14	21	13							
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	1							
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8	9							
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0	0							

1.6.2 Komite PPI

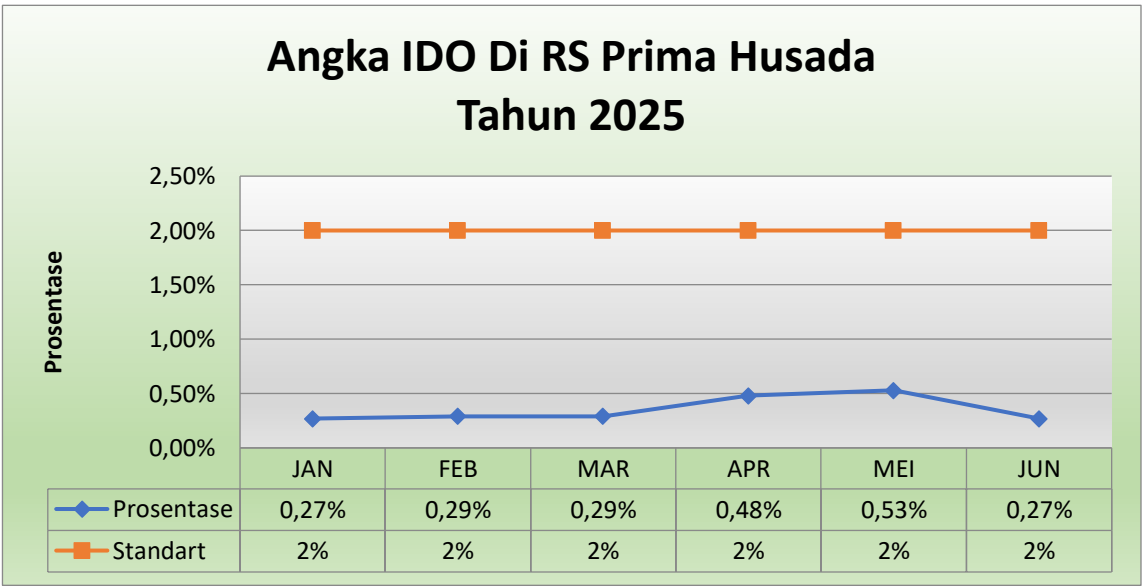
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	82	0%
Seksio Sesaria	1	67	1,49%
Apendiktomi	0	5	0%
Herniotomi	0	10	0%
Katarak	0	45	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	15	0%
Semua Operasi	1	375	0,27%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 1 orang pasien yang menjalani operasi SC. Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 19 tahun dengan kehamilan pertama. Dari hasil leukosit darah pasien didapatkan kondisi leukositosis sebelum dilakukan operasi yaitu 24.000, dimana beresiko tinggi terjadinya IDO. Pasien belum terlalu paham perawatan terlebih saat dirumah karena dengan usia yang masih sangat muda sudah melahirkan dan harus operasi, jadi pasien juga merasa takut dan membatasi mobilisasinya. Sedangkan dilihat dari segi peralatan pasien sudah dilakukan sterilisasi dengan indikator internal & eksternal, pasien juga sudah melakukan mandi sebelum operasi dilakukan, dan saat itu pasien operasi darurat karena partus macet pada jam 23.30 malam tidak bersamaan dengan pasien lain dan kamar operasi terakhir digunakan pada jam 18.30 hari itu. Tidak ditemukan puss pada luka hanya saja luka terbuka pada bagian ujungnya.				
Masalah saat ini	1. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan setelah operasi pada ibu-ibu muda dengan kehamilan pertama. 2. Kondisi leukositosis beresiko tinggi terjadi infeksi pada luka jika dilakukan operasi.				
Permasalahan sebelumnya	3. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan setelah operasi / saat dirumah termasuk nutrisi dan mobilisasi yang harus dipenuhi untuk mempercepat penyembuhan luka dan bekal konseling pada pasien terutama pasien yang berduka. 4. Belum maksimalnya proses pembersihan ruang operasi pada operasi estafet dimana terjadi peningkatan jumlah pasien operasi pada waktu yang hamper bersamaan.				
Tindakan yang dilakukan	1. Monitoring proses edukasi pasien pasca operasi terutama pemahaman pasien saat perawatan setelah operasi termasuk kontroling mobilisasi. 2. Memberikan edukasi pada pasien untuk tetap mobilisasi secara normal dan makan makanan yang bergizi dan banyak minum air untuk melancarkan ASI. 3. Melakukan kolaborasi dengan DPJP terkait penggunaan antibiotik. 4. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai post operasi.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 2. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) 3. Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC). 4. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian	5. Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/PCN	Satu bulan

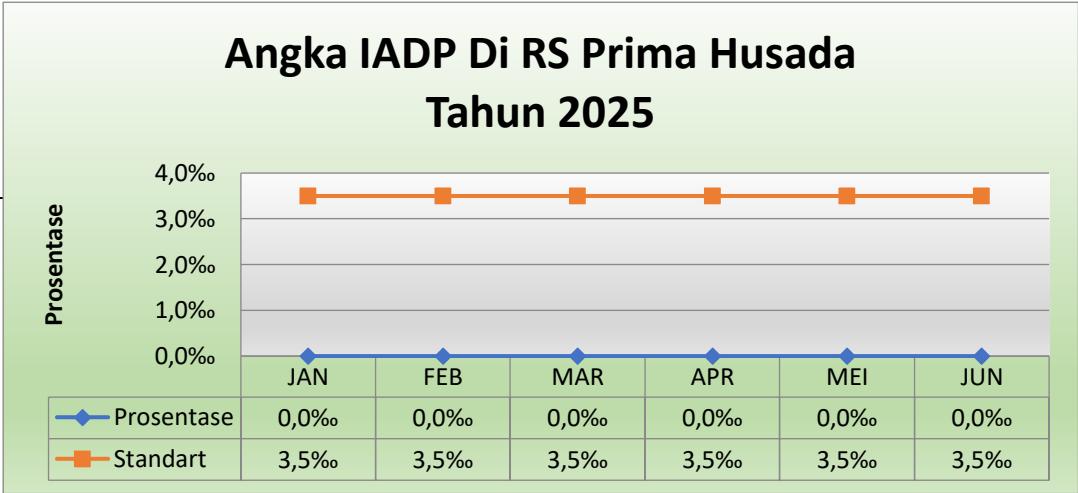
edukasi perawatan pasien pasca operasi	edukasi perawatan pasien post operasi.		edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feed back) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Bantu berikan dorongan afirmasi positif atas keadaan yang terjadi pada pasien agar tidak mengganggu proses penyembuhan agar pasien lebih semangat untuk sembuh. 5. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAI^s Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	11	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.2.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



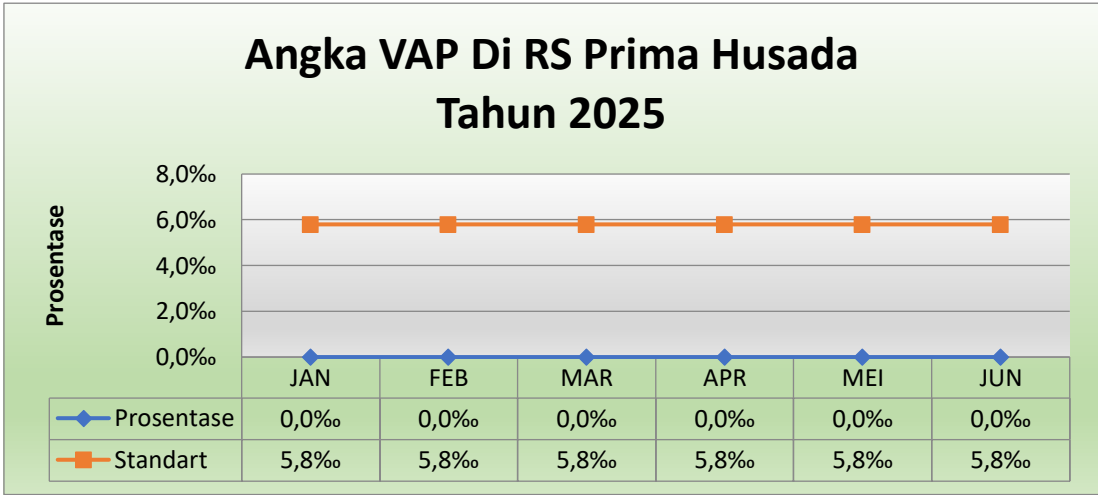
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 108 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	222	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 222 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

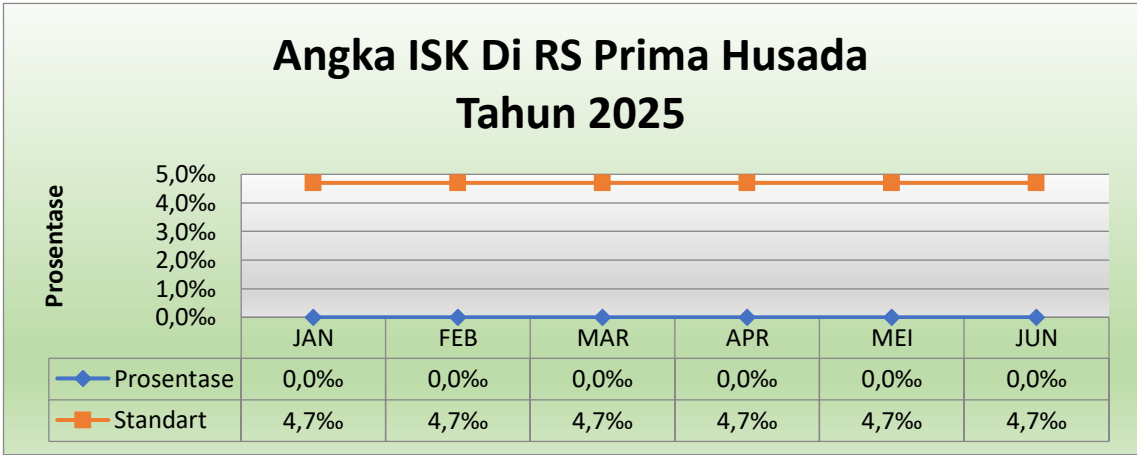
			5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.4 ISK

3.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	254	0‰
HCU	0	40	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.4.2 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)

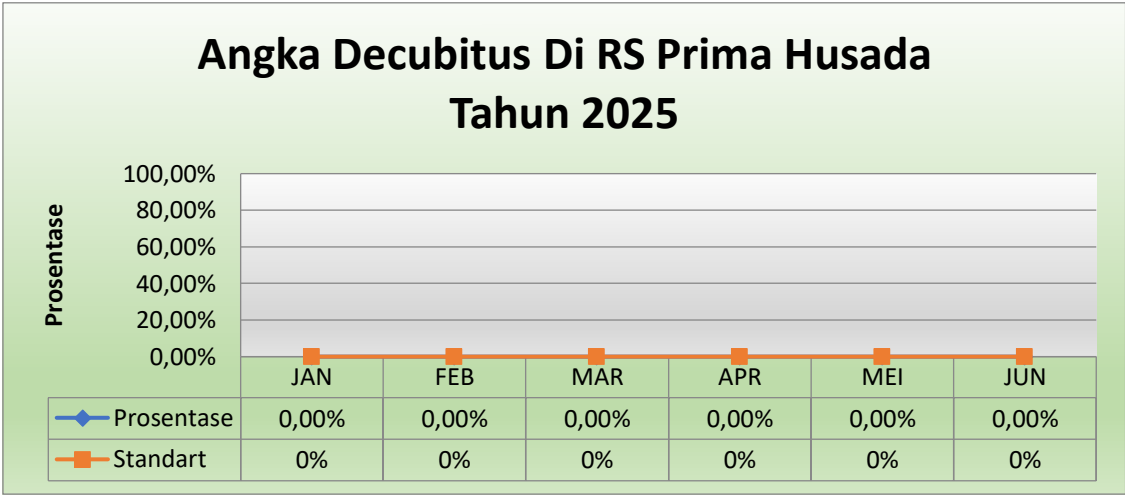


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1103 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
-----------------------------------	--	-------------------------------	---	--	------------

3.6.1.1.5 Decubitus

3.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus

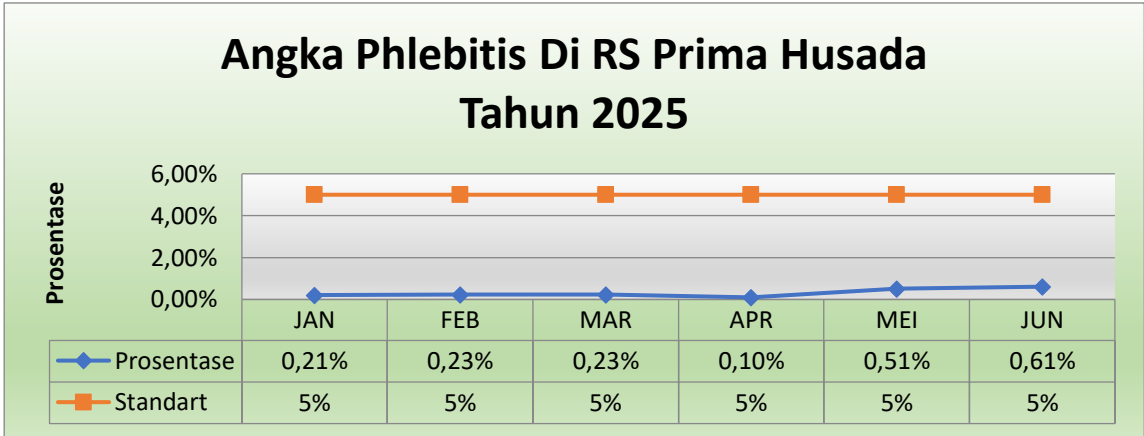


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 17 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

			5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

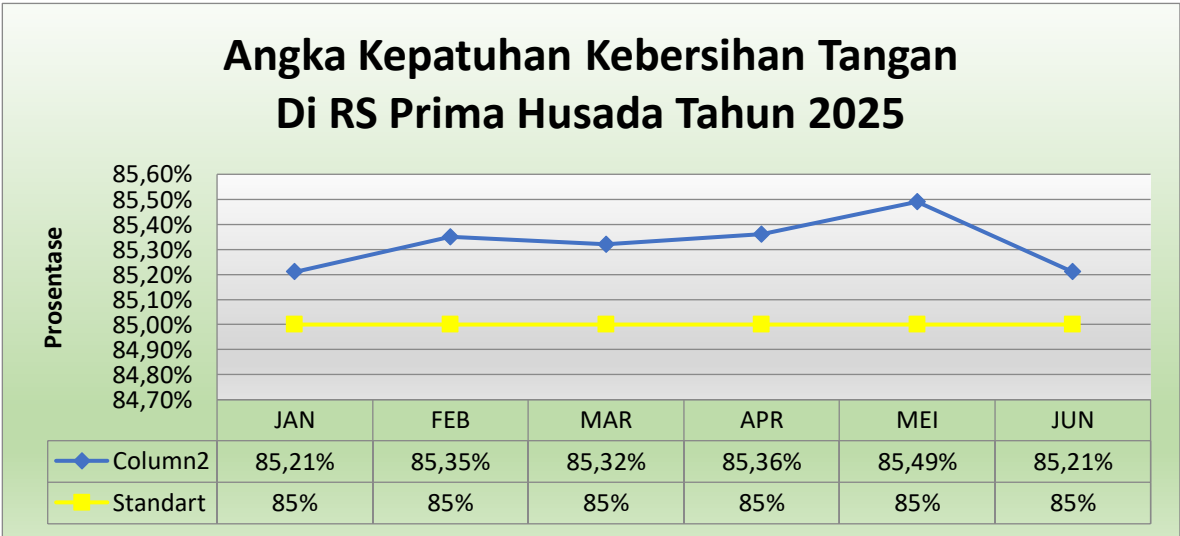


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2946 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,61%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh terdapat peningkatan kasus, 18 pasien yang mengalami phlebitis, 5 diantaranya merupakan pasien berusia >60 tahun, 2 pasien pada usia 50-60 tahun, 2 pasien balita dan sisanya pasien dewasa, dimana 50% masuk pada faktor usia beresiko phlebitis. 6 diantara 18 pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat seperti drip KCL, infus pekat, dan 1 orang mendapat 2 antibiotik dobel. Pasien lainnya tidak mendapatkan cairan pekat hanya mendapat 1 antibiotik dan injeksi pekat seperti metamizole. Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis). Terdapat peningkatan kesadaran petugas terhadap pelaporan phlebitis dan pemahaman skor phlebitis sehingga terjadi peningkatan laporan kejadian phlebitis juga, setelah dilakukan sosialisasi oleh bidang keperawatan terkait pemasangan infus dan phlebitis.				
Masalah saat ini	- Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga infus pekat dan antibiotik dobel. - Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Permasalahan sebelumnya	- Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, seperti KCL meskipun sudah diberikan dengan pengencer cairan infus. - Kesadaran pelaporan masih belum meningkat, pemahaman skoring phlebitis belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengkoordinasikan dengan kabid dan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. - Menganjurkan pada perawat pemasangan infus benar-benar harus menentukan posisi vena yang tepat dan memberikan edukasi setelah melakukan pemasangan infus terutama pada pasien beresiko tinggi. - Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. - Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

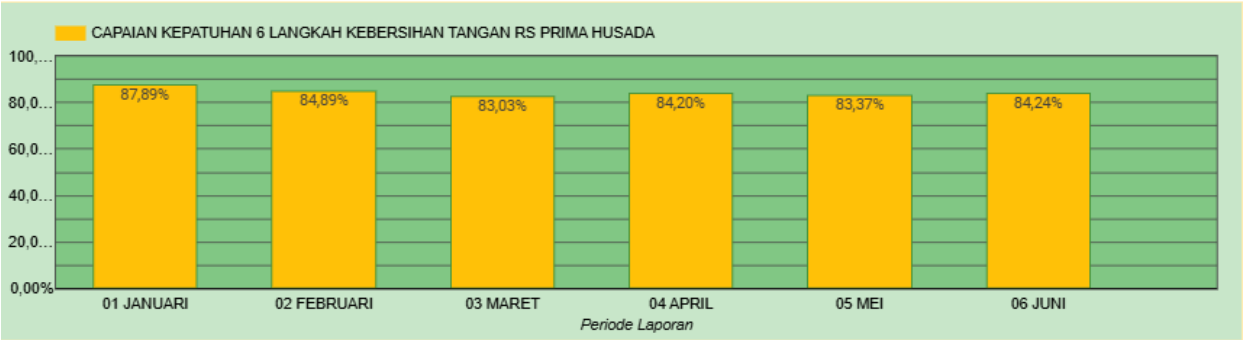
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan
---------------------------------------	---	-----------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

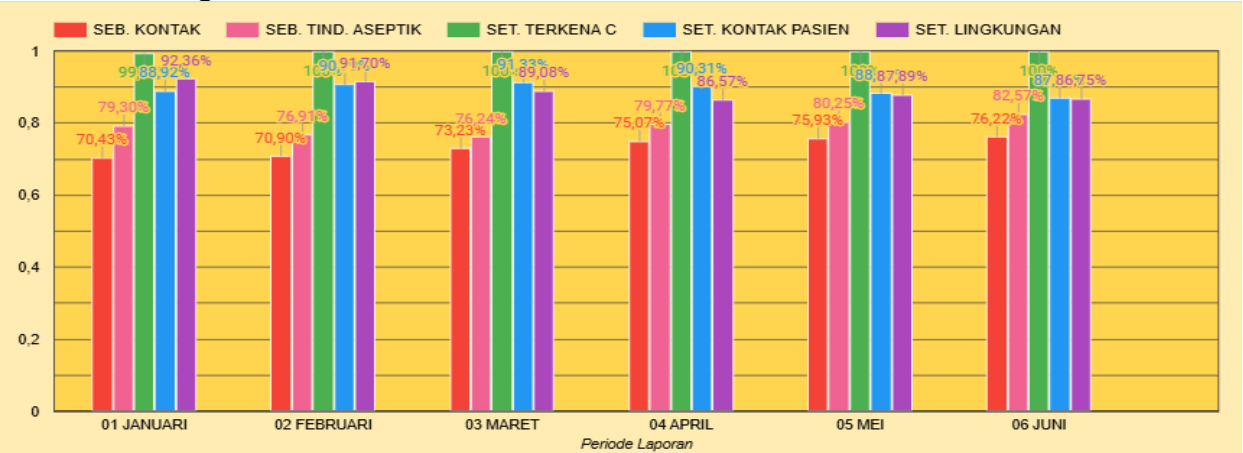
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



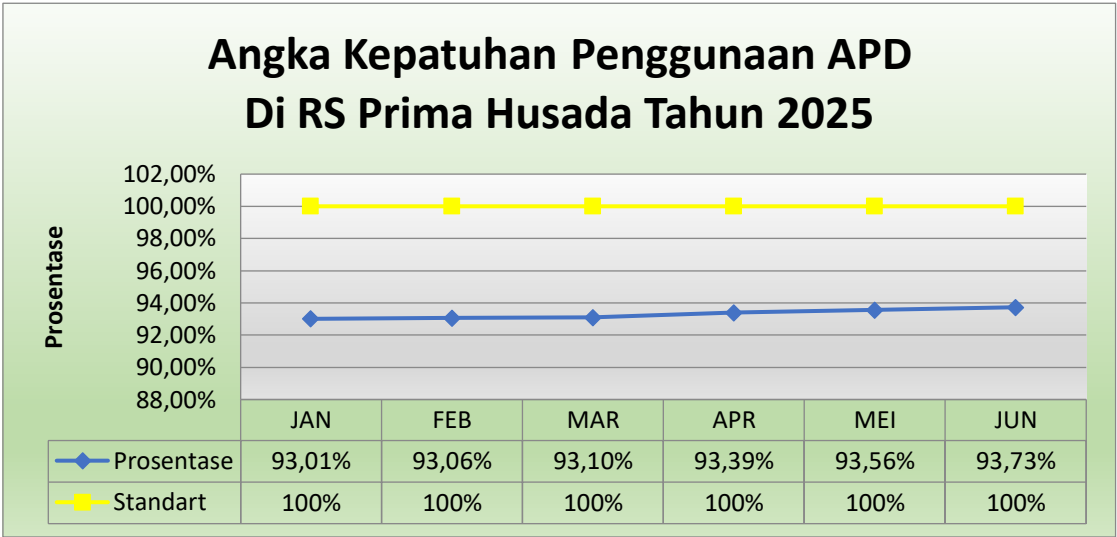
1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan



Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,21%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (76,22%) dan sebelum melakukan tindakan aseptik (82,57%). Terjadi penurunan kembali prosentase pada bulan ini, dikarenakan pada bulan ini sudah tidak dilakukan survey perbaikan standar akreditasi dan kebanyakan dari petugas kembali pada kebiasaannya malas menjalankan 5 momen cuci tangan terlebih lagi jika tidak ada yang mengamati. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 84,24% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik, karena pada saat supervisi dari tim PPI lebih gencar lagi menanyakan 6 langkah cuci tangan pada petugas yang berjaga. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cucinya.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa), hanya pada saat ada event saja terjadi peningkatan, belum menjadikan suatu kebiasaan petugas.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. 6. Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,73%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, kepatuhan petugas nakes dalam pemakaian APD sudah baik, namun masih tetap tidak pada dokter DPJP yang sering berlebihan memakai APD, seperti visite saja namun memakai APD lengkap mulai skort masker, nurse cap, dan sarung tangan. Selain itu, Penggunaan APD pada petugas penjamah makanan juga mengalami peningkatan semenjak dilakukannya resosialisasi terkait hygiene penjamah makanan. Namun pada petugas laundry masih sering ditemukan petugas tidak memakai celemek saat mencuci linen kotor dan petugas CSSD tidak memakai sepatu boot saat mencuci alat kotor. Petugas harus sering diingatkan agar kepatuhan penggunaan APD meningkat.				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Permasalahan sebelumnya	Kesadaran petugas sedikit meningkat terkait pemakaian APD dikarenakan adanya event tertentu saja, belum tertanam dan belum menjadikan kebiasaan sehari-hari jika tidak ada event.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. 2. Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. 3. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 5. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

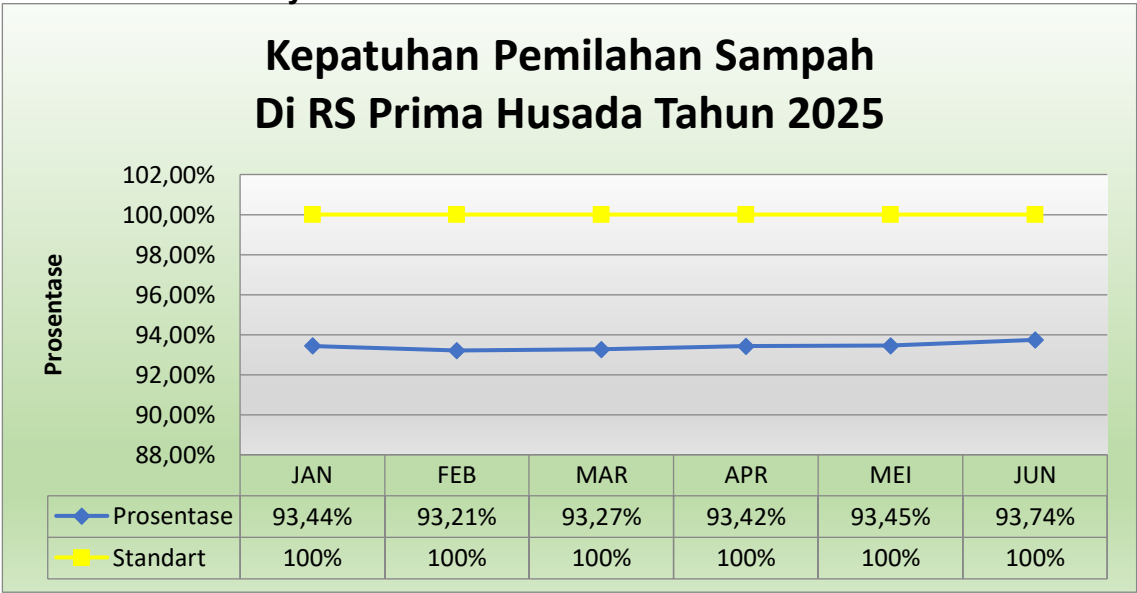
			6. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 7. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.9

Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1

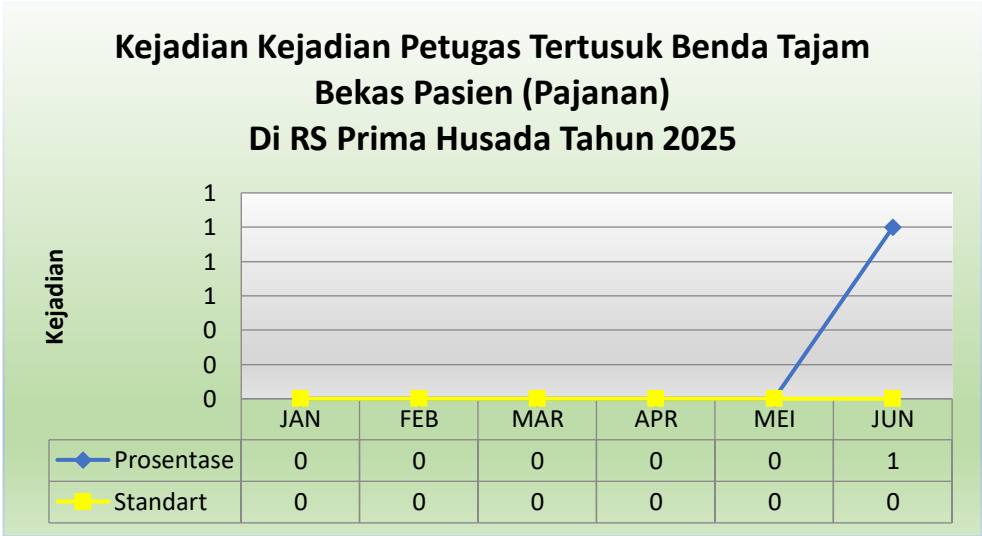
Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,74%. Dari hasil monitoring dan supervise, memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan terutama pembuangan bungkus spuit yang sering dibuang juga jadi satu dengan spuitnya di safety box dan yang paling sering adalah bungkus alkes seperti alcohol swab termasuk bungkus spuit di sampah infeksius. Sehingga akan menambah jumlah sampah yang seharusnya bisa menjadi sampah non infeksius akhirnya menjadi infeksius juga karena tidak dipilah diawal.				
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengajukan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius atau 2 bengkok. 2. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera mengajukan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 5. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Peletakkan tempat sampah baik infeksius dan non infeksius harus ditata dengan benar. 2. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 3. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 4. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan
---	---	----------------------------------	--	----------------------------------	------------

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam
 3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Ditemukan 1 kali kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas (dokter) vaksin di poli vaksin, dikarenakan jenis jarum yang keras dan mudah bengkok meskipun sudah ditutup.				
Masalah saat ini	Jarum suntuk yang bengkok meskipun sudah di tutup.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ada kejadian tertusuk jarum bekas pasien.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan untuk melakukan tatalaksana awal pajanan (mencuci dibawah air mengalir dan sabun, memberi alkohol 70%/betadine). 2. Melaporkan kejadian pada K3 dan SDM dan mencatat untuk selanjutnya dijadwalkan untuk MCU karyawan khusus (pemeriksaan HIV dan HbsAg). 3. Menganjurkan untuk tidak memegang area sepanjang tutup jarum, untuk menghindari jika ada jarum yang bengkok didalam tutupnya. 4. Melakukan monitoring teknik recapping saat menutup jarum saat menyiapkan obat pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan
---	---	----------------------------------	--	----------------------------------	------------

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

UNIT	TARGET	APR	MEI	JUN	%	MANDOK	KETERANGAN
IRNA 2C	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	Bagus dipertahankan
ICU\HCU	4x/Bulan	50%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU tidak ada kenaikan dari bulan MEI
IRNA 3C	4x/Bulan	100%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 3c tidak ada kenaikan dari bulan MEI
MATERNITAS	4x/Bulan	0%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS Tercapai dan mengalami kenaikan terlihat dari bulan Apret hingga Juni
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	100%	75%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI tercapai pertahankan
IRNA 5C	4x/Bulan	100%	0%	25%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C tidak tercapai dan mengalami penurunan
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	0%	50%	75%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A ada peningkatan kecil terlihat dari bulan Apret
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	0%	50%	0%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A mengalami penurunan dari bulan Feb,Apr, hingga Apr
IGD	4x/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IGD Tidak mengalami peningkatan terlihat di bulan April hingga sekarang
FARMASI	4x/Bulan	0%	75%	25%	Meningkat	Lampiran B	FARMASI ada peningkatan
GIZI	4x/Bulan	100%	50%	0%	Menurun	Lampiran B	Gizi tidak tercapai dan mengalami penurunan
IRJA	4x/Bulan	100%	50%	25%	Menurun	Lampiran B	IRJA tidak tercapai dan mengalami penurunan

ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Juni Petugas PKRS tiap unit tidak terlaksana dengan baik, dari data tersebut Unit ICU, IRNA 3C, 5C,

IRNA 2A,3A,4A, IRNA 6A,7A,8A FARMASI, IGD, IRJA belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal, dan beberapa UNIT mengalami penurunan

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar keteringgalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	APR	MEI	JUN	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	50%	100%	50%	Tercapai	Ada	Minggu ke 4 – Tanggal Merah
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	100%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

UNIT	TARGET	APR	MEI	JUN	%	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI ATAU KOLABORASI	KET
PONEK	4X/Bulan	0%	0%	25%	Tidak Tercapai	√	Edukasi Asi Eksklusif
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	25%	50%	25%	Tidak Tercapai	√	Edukasi KEK pada Ibu Hamil
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan Juni PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

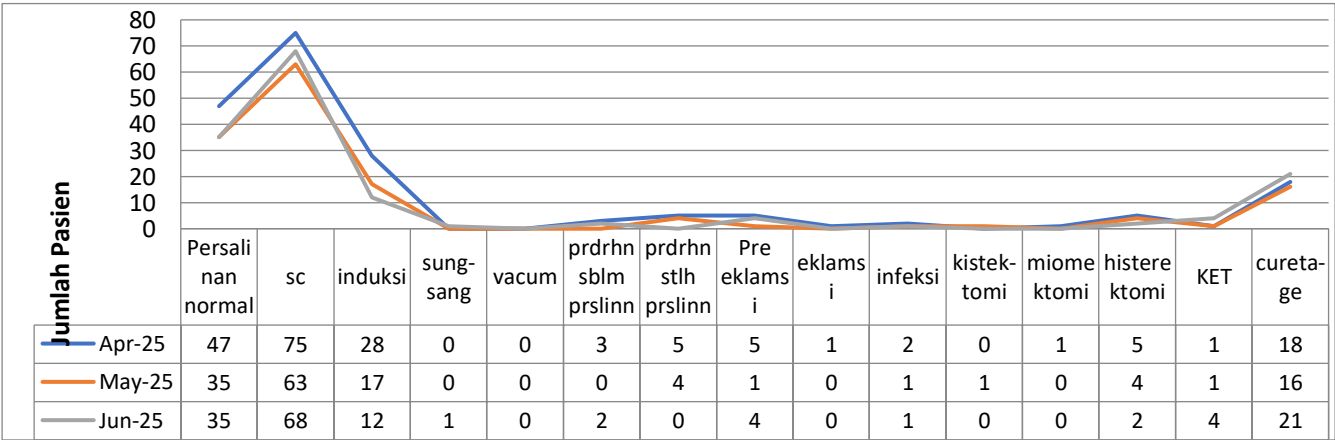
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Juni 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	47	35	35
	b. SectioCaesaria	75	63	68
2				
	a. Induksi / Drip	28	17	12
	b. Sungsang	0	0	1
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	3	0	2
	b. Perdarahan setelah Persalinan	4	4	0
	c. Pre Eklamsi	5	1	4
	d. Eklamsi	1	0	0
	e. Infeksi	2	1	1
4				
	a. Curretage	18	16	21
	b. Kistektomi	0	1	0
	c. Miomektomi	1	0	0
	d. Histerectomy	5	4	2
	e. KET	1	1	4

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Juni 2025 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 68 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Juni 2025 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 35 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan

- secara SC dan Persalinan normal pada bulan Mei menurun, hal ini dikarenakan jumlah pasien di maternitas yang menurun pada bulan Juni 2025.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
 3. Ada1 persalinan sungsang pada bulan Juni 2025, sedangkan pada bulan Mei dan April 2025 tidak ada. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Juni 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
 4. Induksi Persalinan pada bulan Juni mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 12 pasien
 5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Juni 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 4 pasien. Dan ada tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Juni 2025 dan 2 bulan sebelumnya
 6. Jenis pelayanan curretage di bulan Juni 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 21 pasien. *Curretage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

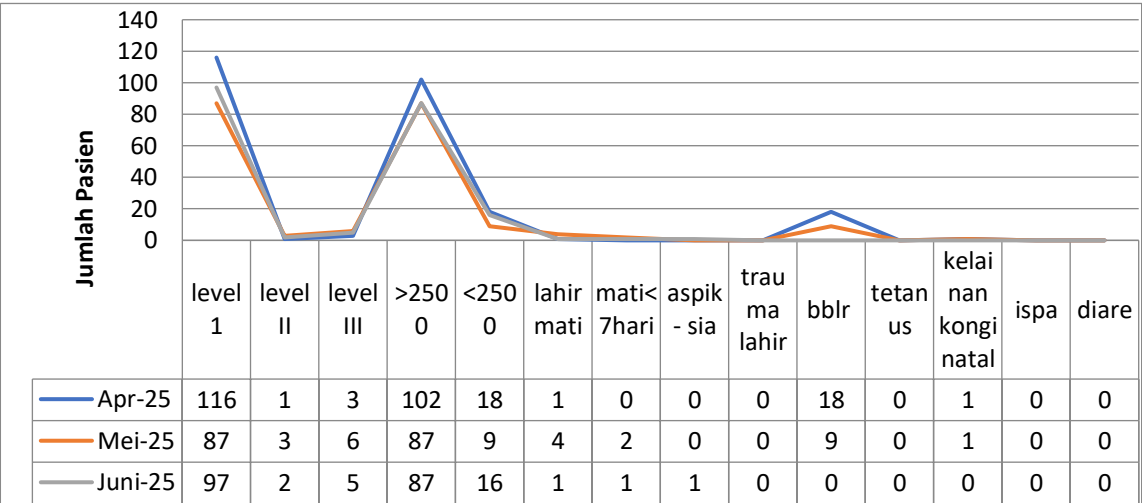
3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Juni 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1				
	a. Level 1	116	87	97
	b. Level II	1	3	2
	c. Level III	3	6	5
2				
	a. ≥ 2500 gram	102	87	87
	b. ≤ 2500 gram	18	9	16
3				
	a. Kelahiran Mati	1	4	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	2	1
4				
	a. Asphyxia	0	0	1
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	18	9	16

	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	1	1	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Juni 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Mei 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 87 bayi. Dan pada level 2 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Dan pada level 3 juga menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 5 bayi. Jumlah bayi bulan Mei 2025 sedikit meningkat seiring dengan jumlah persalinan pada bulan Juni 2025
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Juni 2025 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 87 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juni 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Juni 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 16 bayi.
5. Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan Juni 2025, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 4 kasus. Dan April 1 kasus.
6. Ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Juni, sedangkan pada bulan Mei 2025 ada 2 kasus dan tidak ada kasus pada bulan April 2025. Kematian bayi pada bulan Juni diakibatkan karena bayi lahir imatur dan BBLASR

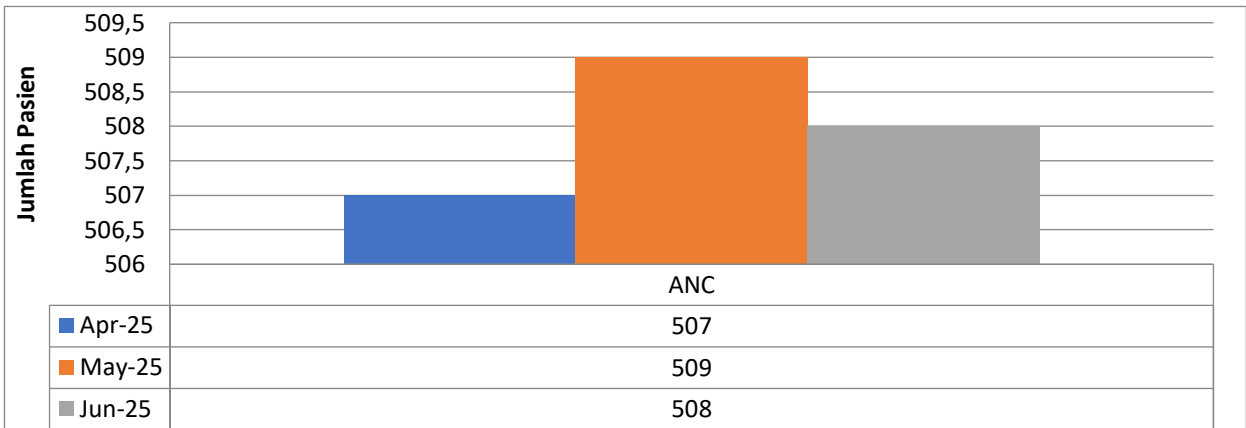
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek Juni 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	ANC	507	509	508

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Juni 2025



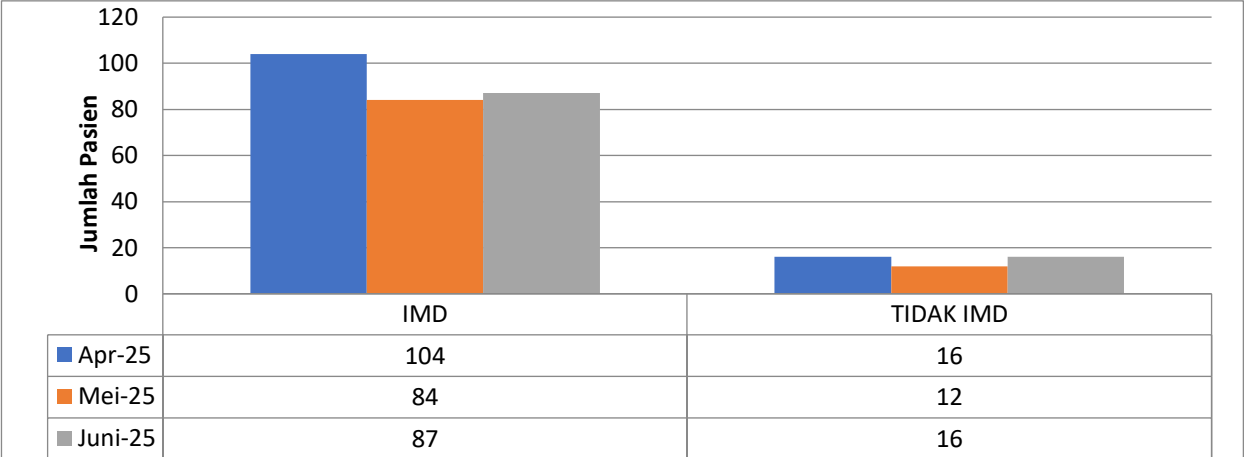
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Juni 2025 mengalami sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 508 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Juni 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	IMD	104	84	87
2	Tidak IMD	16	12	16

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juni 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 87 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juni juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi, Sedangkan pada bulan Mei sebanyak 12 bayi, dan April sebanyak 16 bayi.
3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2025

NO	NAMA BAYI	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	Ny Churi	NKB, BBLR	cuvis
2	Ny Any F	RDS, BBLR	Inkubator dan CPEP
3	Ny Indahwati 1	NKB, BBLR	Cuvis
4	Ny Indahwati 2	NKB, BBLR	Cuvis
5	Ny Winanda	NKB, BBLR	Cuvis
6	Ny Nabilla	NCB, BBLR	Cuvis
7	.Ny Rohmawati	NCB, Hipoglikemia	Cuvis
8	. Ny Evi	NKB, BBLR	Cuvis
9	.Ny Tamiase	RDS, BBLR	Inkubator dan CPEP
10	.Ny Indah	BBLASR, Obs distres Nafas, RDS	Inkubator dan CPEP
11	Ny Alifia 1	NCB, BBLR	Cuvis
12	Ny AlifiA 2	NCB, BBLR	Cuvis
13	Ny Nur Khusnul	NCB, BBLR	Cuvis
14	Ny Lia	RDS, BBLSR, NKB	Inkubator dan CPEP
15	Ny Nimas	RDS	Inkubator dan CPEP
16	Ny Tri	BBLR	Cuvis

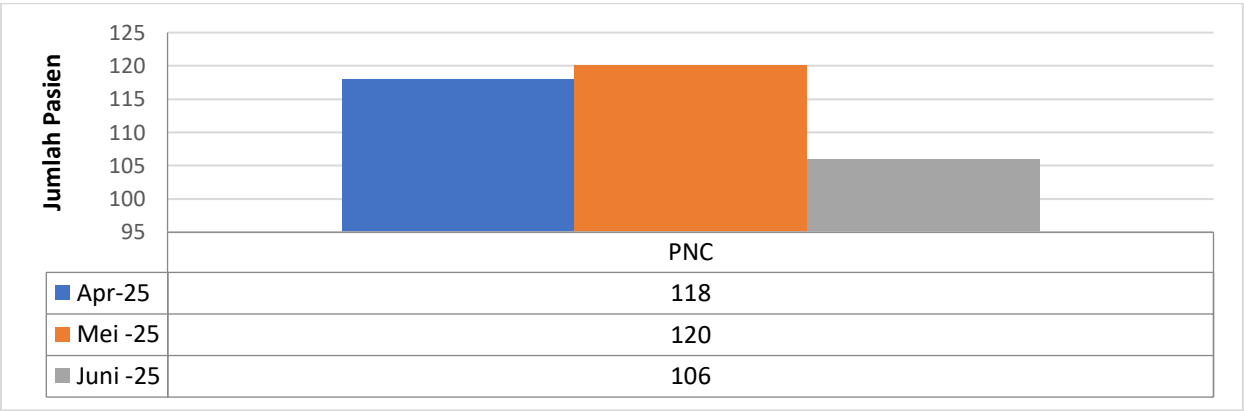
4. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Juni 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	PNC	118	120	106

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Juni 2025

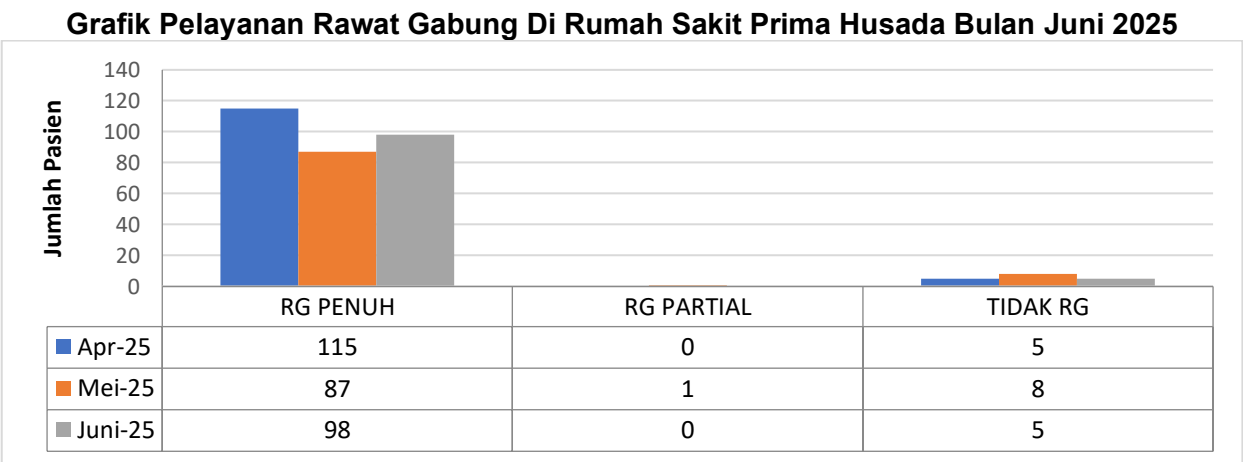


Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan Juni 2025 penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 106 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Juni 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	Rawat gabung penuh	115	87	98
2	Rawat gabung partial	0	1	0
3	Tidak Rawat gabung	5	8	5



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Juni 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 98 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Juni 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi.
- 3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	Ny Any F	RDS, BBLR	Inkubator dan CPEP
2	.Ny Tamiase	RDS, BBLR	Inkubator dan CPEP
3	.Ny Indah	BLASR, Obs distres Nafas, RDS	Inkubator dan CPEP
4	Ny Lia	RDS, BBLSR, NKB	Inkubator dan CPEP

- 4. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

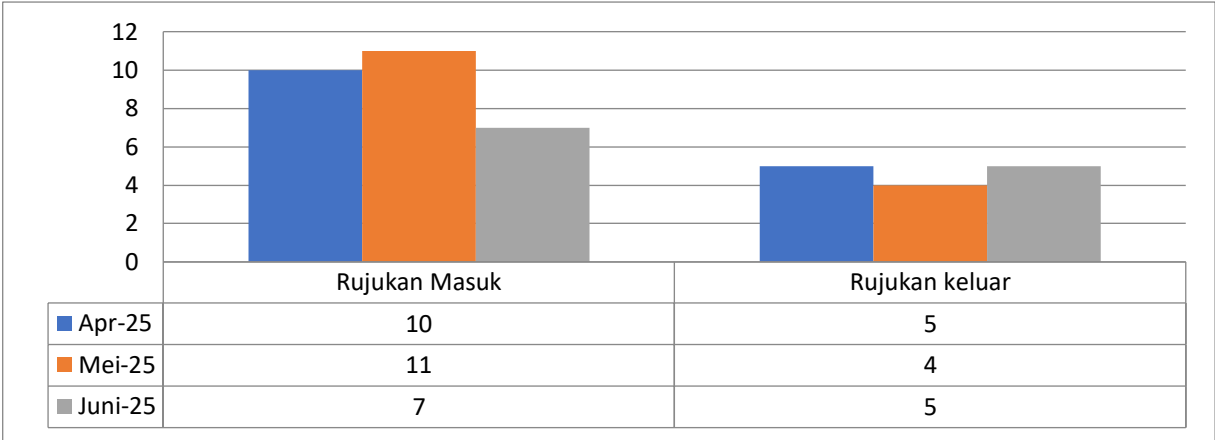
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Juni 2025

NO	RUJUKAN	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	Rujukan Masuk	10	11	7
2	Rujukan keluar	5	4	5

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Juni 2025

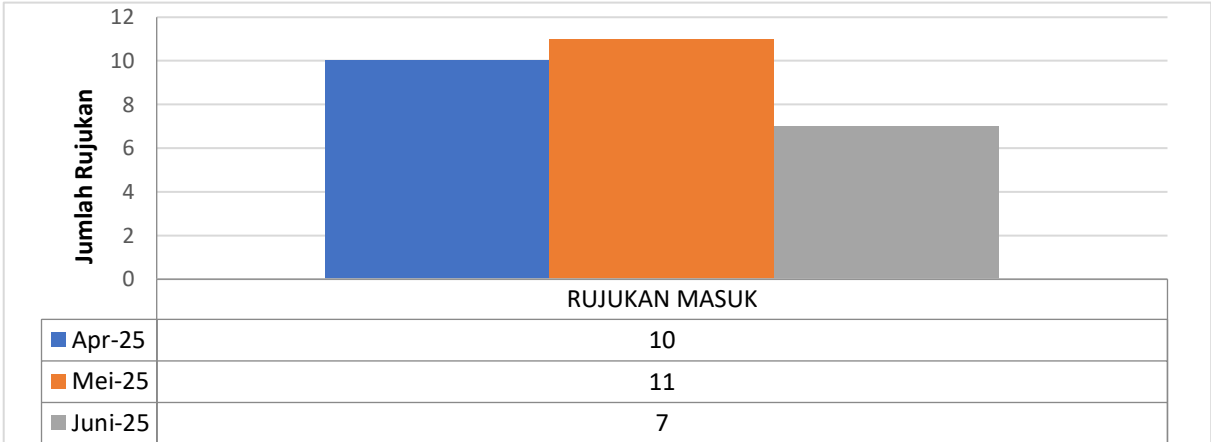


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Mei 2025

BULAN APRIL 2025			
1	Lady Ayu	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 MGG DG HT + FH	Klinik Mutiara Sehat
2	Ninis J	G2P1001AB000 UK 37-38 MG KPD + Prolong K1FA	PMB Tri Widiyawati
3	Novita A	G2 P1001 AB000 UK 37-38 MGG dgn KIFA	PMB Munawaroh
4	Elis S	G3P2AB0 UK 34-36 MGG dg PPI	PMB Tri Widiyawati
5	Nadia Marinka	G2P1001AB000 UK 10-12 MG dg susp.KET	RSUD lawang
6	Dela	G 2 P1001 AB0 UK 42-43 MGG dgn KIFL + Post date	RSUD lawang
7	Hima Aliyah	G1P000 ABOO UK 40- 41 mgg dg prolong KIFL	PMB Titik Sunaryati
8	Lusi A	G1 P0 AB 0 UK 41-42 MGG dgn KIFA + OF hari ke 3	PKM Ardimulyo
9	By Ny Ayu Agustin	Convulsion of Newborn	RSAU Munir
10	Lubna	Sust TTNB	BPM Tri Widiyawati
BULAN MEI 2025			
1	Triya Nanda	G2 P1001 Ab000 uk 37-38 mgg dg KIFA + IUD Insitu	Klinik Mutiara Sehat
2	Pinarti	P2002 Ab000 dg Post Partum + HPP ec Sisa plasenta	RSUD Lawang
3	Fernanda Alya	G1 P0000 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPM Siti Nurcahyaningsih
4	Carrolyn	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg KPD + KIFL	BPM Titik
5	Ni'matul	G1 P0000 Ab000 Uk 39-40 mgg dg kala 2 lama	PKM Singosari
6	Sumiasih	G4 P3003 Ab000 uk 39-40 mgg dg KPD + letak Obliq	PKM Singosari
7	Novi Prajna	G2 P1001 Ab000 uk 8-10 mgg dg vomiting +OF	Klinik Mutiara Sehat
8	Wiwin Defa	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFA + KPD	PKM Ardimulyo

9	Syafira	G1P0000 AB000 Uk 39-40 mgg dg KPD + KIFL	BPM Siti R
10	Sayidah	G2 P0000 Ab100 Uk 37-38 mgg dg KPD	PKM Singosari
11	Siska	G2 P1001 Ab000 uk 28-30 mgg dg PPI	BPM Tri
BULAN JUNI 2025			
1	Sri Wahyuni	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 mgg dg KIFA + letsu	PKM Singosari
2	Nimas Ayu M	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg d PEB	BPM Lilik A
3	Indahwati	G2 P1001 AB000 UK 35-36 mgg dg HT + Gemeli + PPROM	BPM Subaedah
4	Angesti Pina	G2 P1001 Ab000 UK 38-39 mgg dg KPD	Klinik Mutiara Sehat
5	Viqi Ijatul	G2 P1001 Ab000 UK 41-42 mgg dg Kala 2 Lama	BPM Sumaiyah
6	Siti Rosita	G2 P1001 Ab000 UK 41-42 mgg dg KIFL + APB EC Plasenta Previa + IUFD	PKM Singosari
7	By Ny lin K	RDS OK Neonatal	PKM Singosari

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan Juni 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 7 rujukan, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 11 dan 10 rujukan di bulan April.

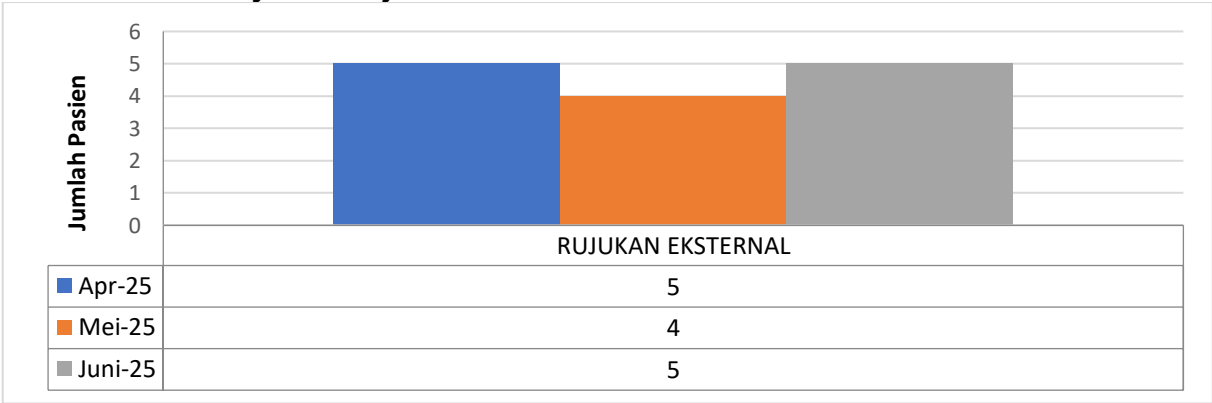
Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
 Tabel Rujukan Keluar Ponek Mei 2025

BULAN APRIL 2025						
1	By ny siti ulifah	0 hari	NICU	Atresia Ani tanpa fistel undesensus testis	Pro tindakan bedah	RS Saiful Anwar
2	By. Ny. Rusda Fauziah	2 hari	NICU	RDS, Prematur, NEC	pro ventilator	RS Lavalette
3	Ny. Dian Nihayattul	25 th	Maternitas	Post SC h-9, asites, dipsneu, anemia,	Pro Penanganan Lanjut	RS Saiful Anwar

	Islam			anuria		
4	Ny. Nadia Marinka Oktaviani	31 th	Maternitas	Abdominal Pregnancy	Penanganan Lebih Lanjut	RS Saiful Anwar
5	Ny.Nanik	33 Th	IGD	G2 P1001 Ab000 Uk 26-28 mgg dg Eklamsia + BSC	Penanganan Lebih Lanjut	RS Saiful Anwar
BULAN MEI 2025						
1	By Ny Eka Fani	1 hari	NICU	Neonatal bronchopneumonia, grandula thymus prominen, NEC	Pro ventilator	RS Lavalette
2	By Ny Arisa	3 hari	NICU	BBLR + hipoglikemia refrakter	Pro konsultan perinatologi dg konsultan endokrinologi	RS Lavalette
3	By Ny Kartina	2 hari	NICU	Neonatal pneumonia + BBLR	Pro ventilator	RS Soepraoen
4	By Ny Khusnul	3 hari	NICU	Neonatal pneumonia + BBLR	Pro ventilator	RS Lavalette
Bulan Juni 2025						
1	Ny Churi	30 th	Maternitas	P3104 Ab100 dg Post SC +VSD+ Hematuria + Akut Abdomen	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
2	By Ny Any	2 hari	NICU	RDS + BBLSR	Pro Ventilator	RS Saiful Anwar
3	By Ny Indah	4 hari	NICU	BBLASR + obs distress nafas dd RDS	Pro NIPPV dan tata laksana subspesialistik neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny lia	3 hari	NICU	RDS + BBLSR + NKB	Pro NIPPV dan tata laksana subspesialistik neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny lin	3 hari	NICU	RDS dd MAS, Neonatal seizure, susp HIE, neonatal pneumonia	Tatalaksana supneurologi anak, subspesialistik neonatologi	RST Soepraoen

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

Pada bulan Juni dan Mei 2025 jumlah rujukan eksternal sama yaitu 5 pasien dirujuk, sedangkan pada bulan Mei 5 pasien

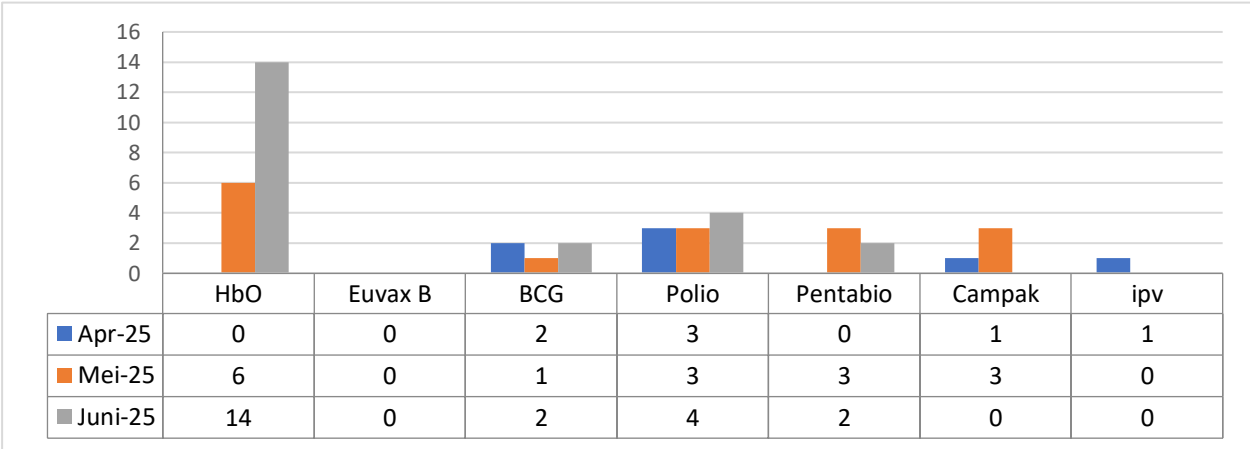
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Juni 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	HbO	0	6	14
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	2	1	2
3	Polio	3	3	4
4	Pentabio	0	3	2
5	Campak	1	3	0
6	IPV	1	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Juni 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Juni sebanyak 14 bayi, sedangkan bulan Mei sebanyak 6 bayi dan April tidak ada. Hal ini dikarenakan minimnya ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juni dan mei, sedangkan pada bulan April 2025 ada 1 bayi
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juni dan April sebanyak 2 bayi, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 1 bayi.
5. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi campak pada bulan Juni, sedangkan bulan Mei sebanyak 3 bayi, dan bulan April ada 1 bayi
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juni sebanyak 4 bayi, sedangkan bulan Mei dan April 2025 sebanyak 3 bayi
7. Bayi yg imunisasi Pentabio pada bulan Juni sebanyak 2 bayi, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 3 bayi dan tidak ada pada bulan April. imunisasi pentabio diberikan

bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

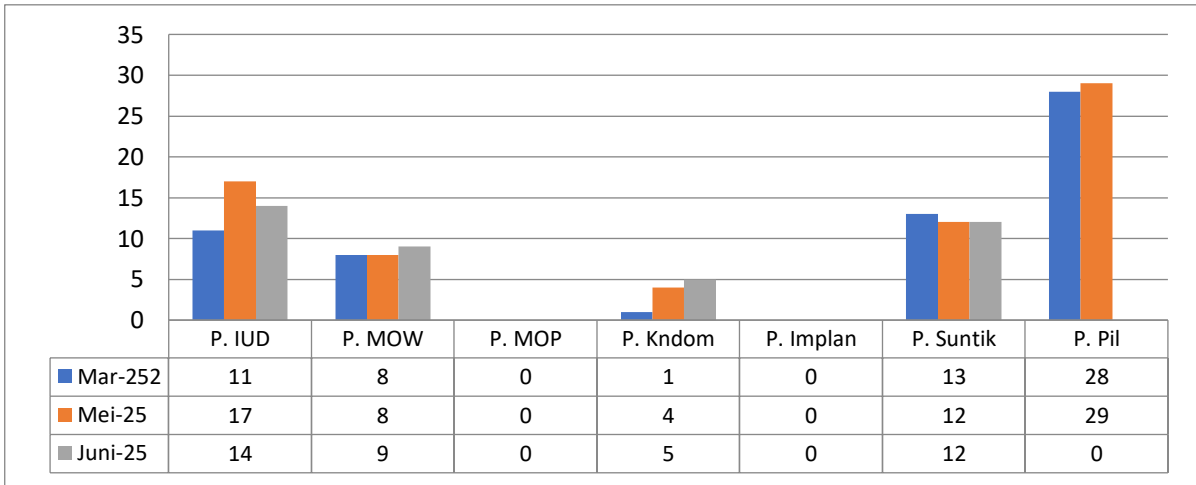
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponpek Juni 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	IUD	11	17	14
2	MOW	8	8	9
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	1	4	5
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	13	12	12
7	Pil	28	29	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2025



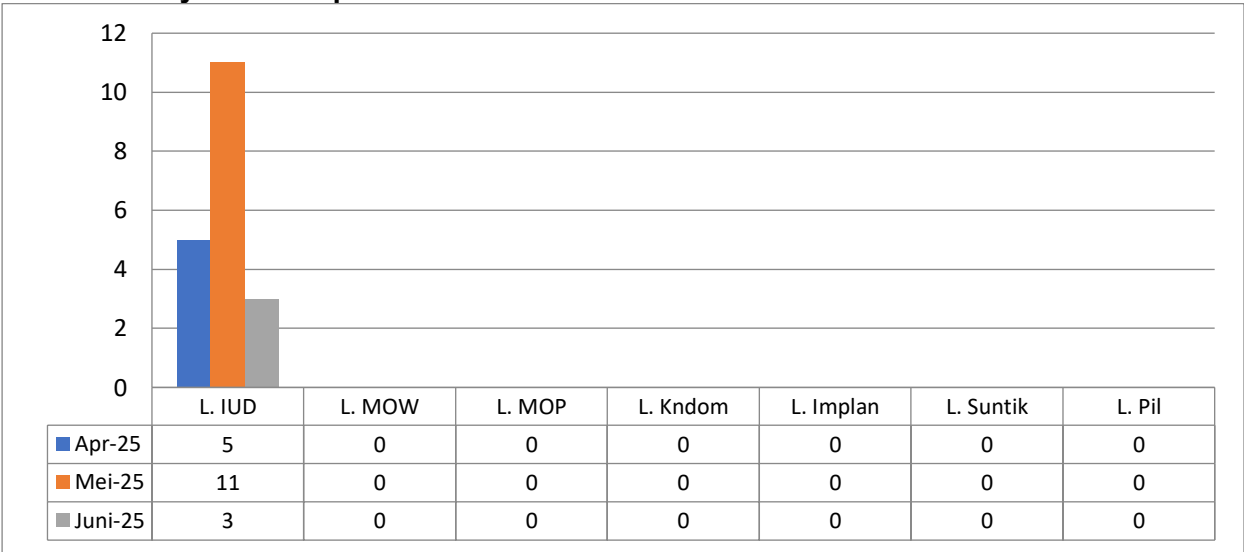
Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Juni 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 14 akseptor yang terdiri dari 10 akseptor IUD Nova T dan 4 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Juni 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 9 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Mei sebanyak 5 akseptor, meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 pengguna di bulan Mei dan April 1 pengguna
- 4. Tidak ada pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Juni, sedangkan Mei sebanyak 29 pengguna, sedangkan bulan april 28 pengguna.
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Juni dan Mei sama, yaitu 12 pengguna, sedangkan April 13 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

NO	JENIS	JUMLAH LEPAS		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	IUD	5	11	3
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2025



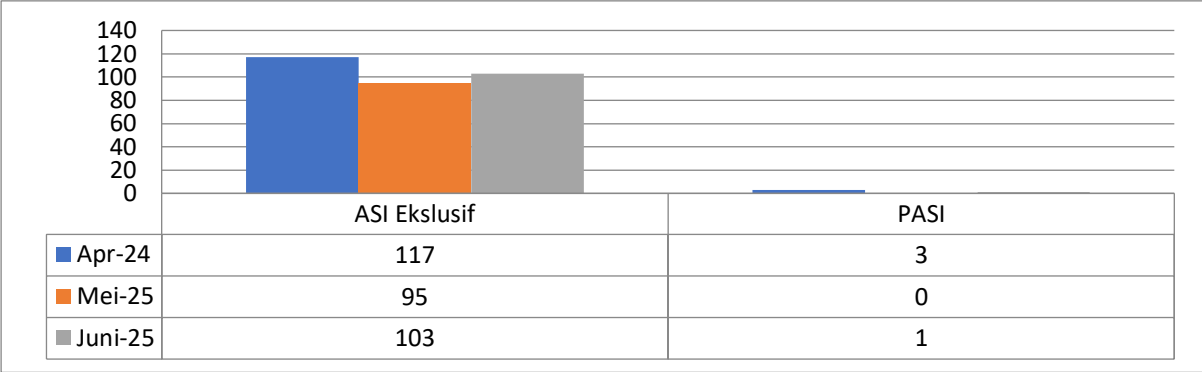
- Analisis :**
1. Pelepasan KB IUD pada bulan Juni menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 3 Akseptor, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 11 Akseptor dan April sebanyak 5 akseptor
 2. Tidak ada pelepasan KB Implan pada bulan Juni 2025 dan juga 2 bulan sebelumnya

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Juni 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	Asi eksklusif	117	95	103
2	Asi /PASI	3	0	1

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Juni meningkat yaitu 103 bayi, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 95 bayi, dan bulan April, yaitu 117 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Bayi yang mendapat PASI pada bulan Juni sebanyak 1 bayi, sedangkan pada bulan mei sebanyak 0, dan April 3 bayi. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Berikut daftar bayi yang tidak diberikan ASI

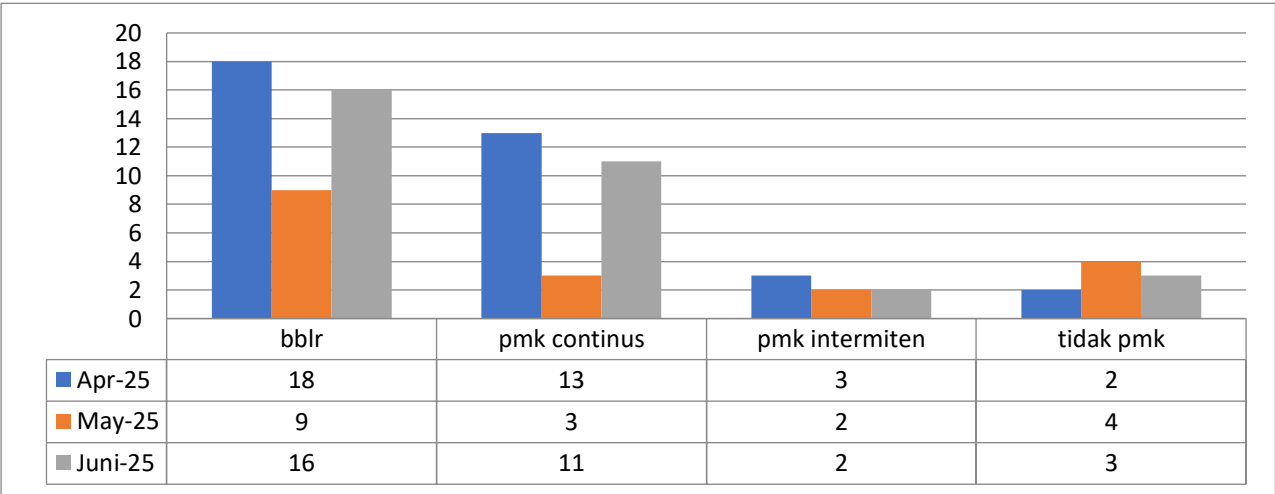
NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL	ALASAN
1	Ny Nimas	RDS	Inkubator dan CPEP	Bayi puasa, dan dirujuk ke RS lain

Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Juni 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	Bayi BBLR	18	9	16
2	PMK continuos	13	3	11
3	PMK Intermiten	3	2	2
4	Tidak PMK	2	4	3



Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Mei 2025

Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
 - 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Juni dan Mei 2025 sama, yaitu 2 bayi, sedangkan pada bulan April sebanyak 3 bayi. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
 - 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Juni 2025 meningkat yaitu 11 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil sedangkan pada bulan Mei sebanyak 3 bayi, dan April 2025 sebanyak 13 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
 - 4. Ada 3 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Juni, 4 bayi pada bulan Mei, dan 2 bayi pada bulan April.
- Berikut daftar bayi yang tidak dilakukan PMK

NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL	ALASAN
1	Ny Indah	RDS, BBLSR	Perawatan CPEP + Inkubator	Dirujuk
2	Ny Lia	RDS, BBLSR, NKB	Perawatan CPEP + Inkubator	Dirujuk
3	ny Any	RDS, BBLSR	Perawatan CPEP + Inkubator	Dirujuk

Rencana dan Tindak Lanjut

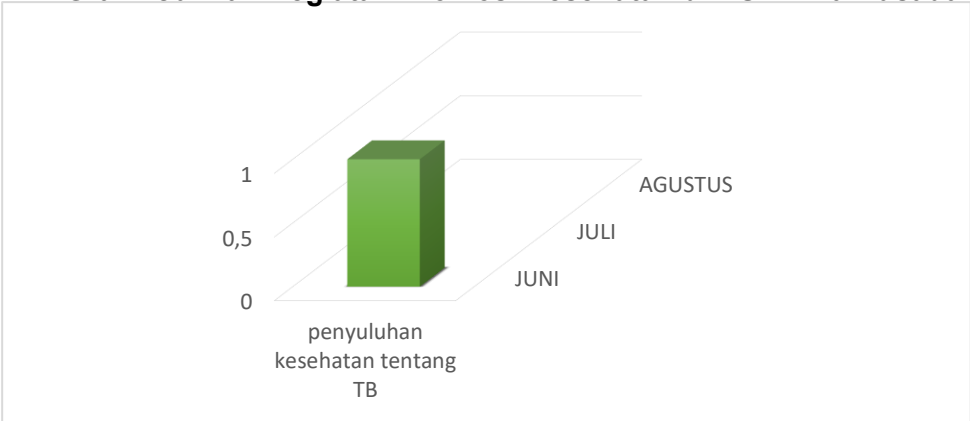
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1		

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

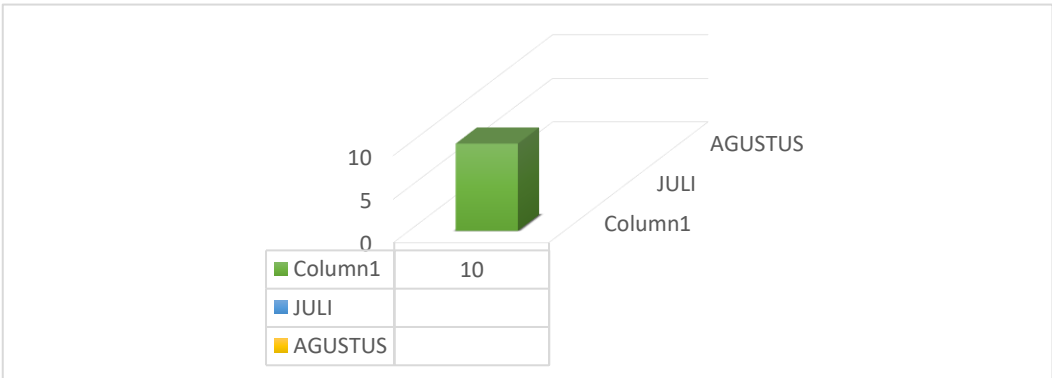
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian Masker	10		

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

- 1) Pada bulan Juni 2025 terdapat 10 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 2) Pada bulan Juli 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- 3) Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

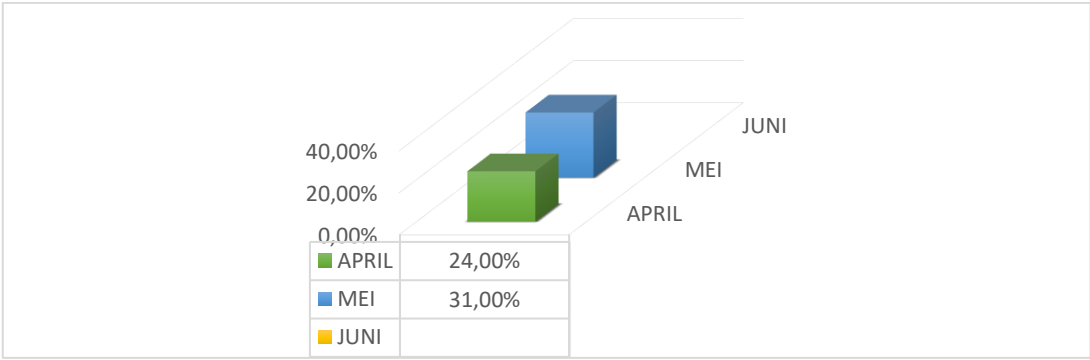
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	26		

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juni 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 26 orang
- 2. Pada bulan Juli 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0
- 3. Pada bulan Agustus 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0

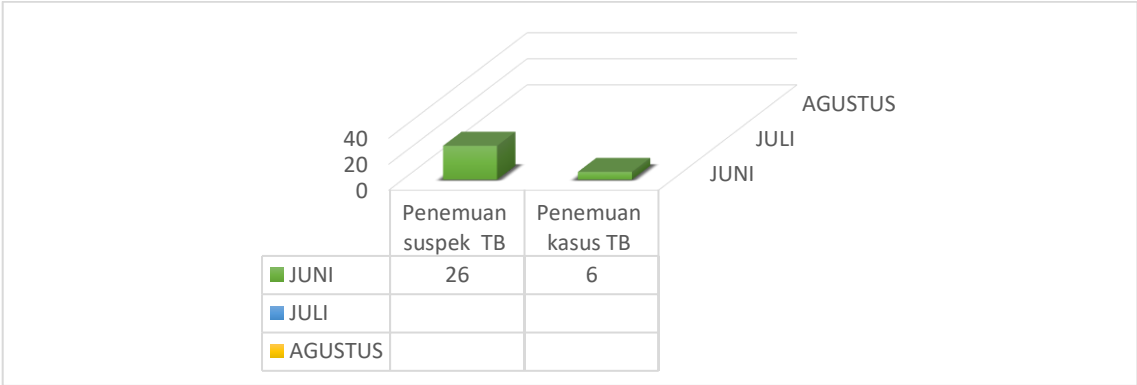
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Penemuan suspek TB	26		
2	Penemuan kasus TB	6		

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 26 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien
- 2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 0 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 0 pasien
- 3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 0 pasien

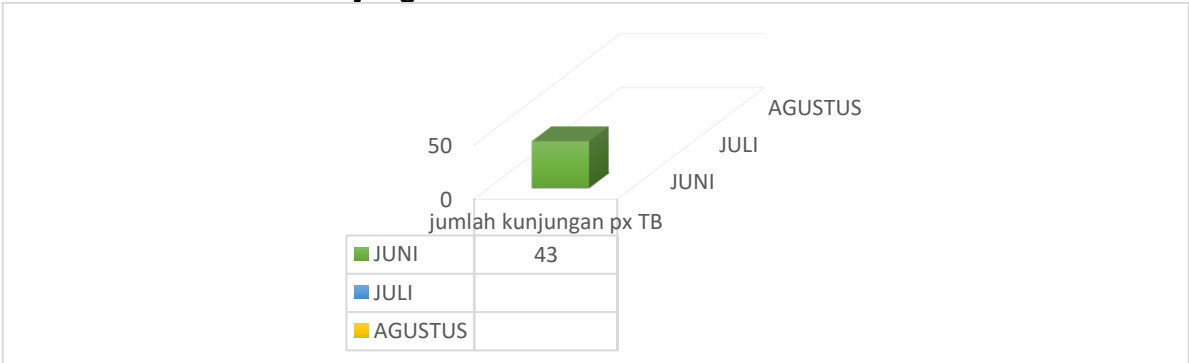
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	43		

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juni 2025 di poli pasien TBC mencapai 43 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juli 2025 di poli pasien TBC mencapai 0 pasien.
- 3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Agustus 2025 di poli pasien TBC mencapai 0 pasien.

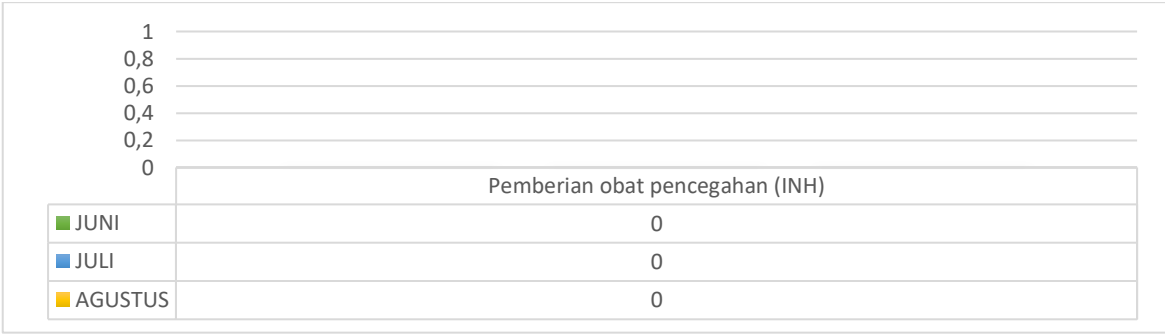
Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



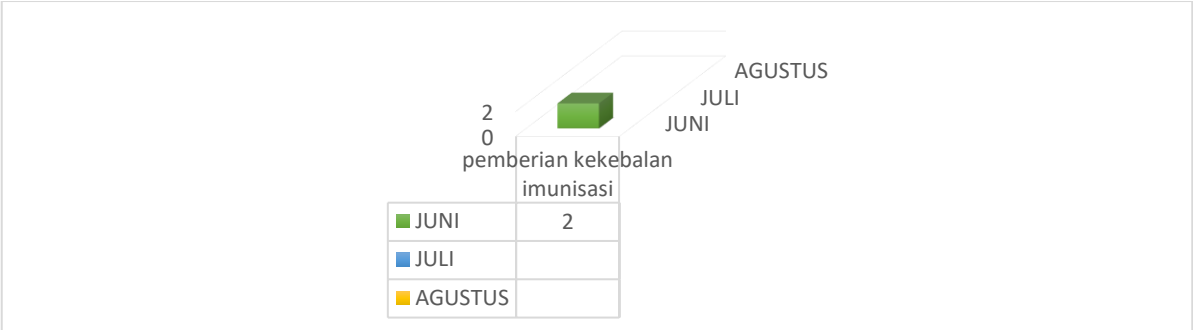
Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
 - 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian imunisasi BCG	2		

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Juli
- 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Agustus

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%		

Analisis :

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%		

Analisis:

Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penularan karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :

Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Penempatan pasien TB	100%		

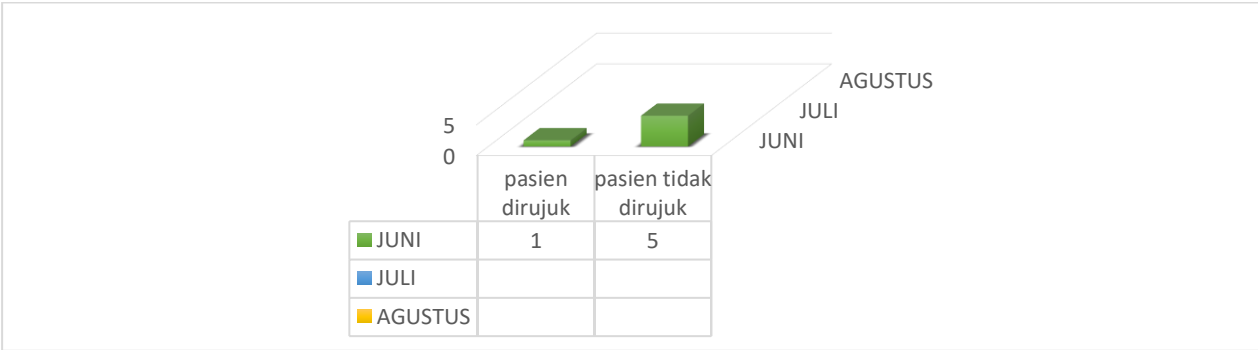
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien TB yang dirujuk	1		
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	5		

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

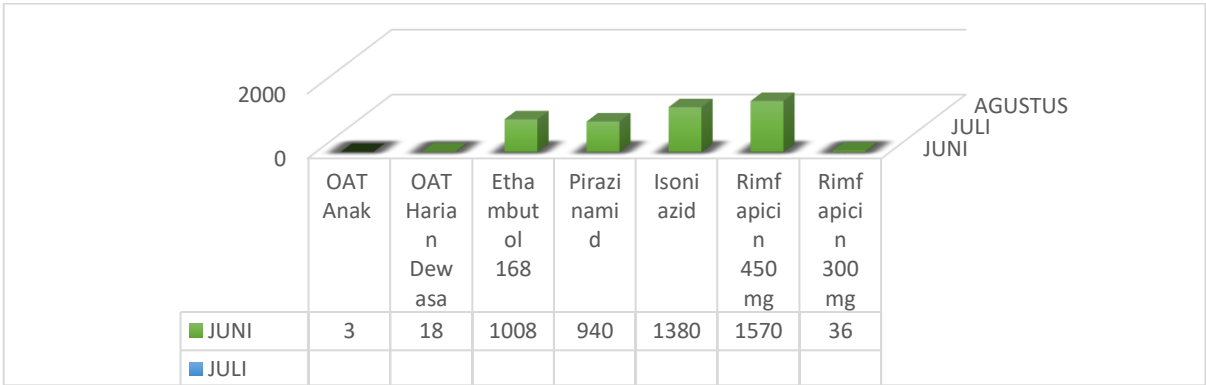
1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	OAT Anak	3		
2.	OAT Harian Dewasa	18		
3.	Ethambutol	1008		
4.	Pirazinamid	940		
5.	Isoniazid	1380		
6.	Rimfapicin 450 mg	1570		
7.	Rimfapicin 300 mg	36		

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



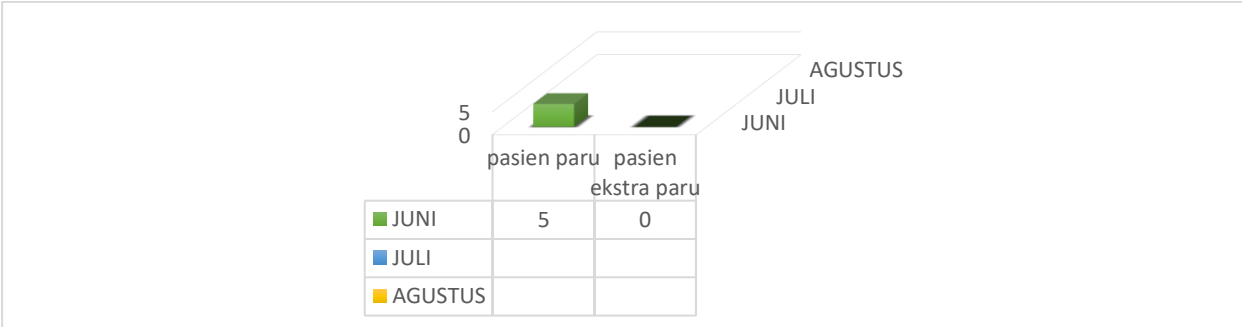
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien paru	5		
2.	Pasien Ekstra paru	0		

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

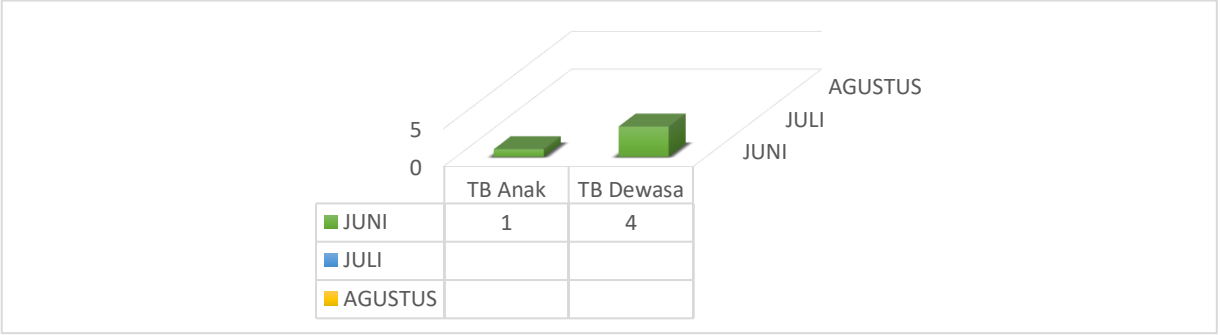
- 1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 5 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru
- 2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 0 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru
- 3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 0 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien Anak	1		
2.	Pasien Dewasa	5		

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



- Analisis :**
- 1. Pada bulan Juni terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien
 - 2. Pada bulan Juli terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 0 pasien
 - 3. Pada bulan Agustus terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Tn. M	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Ny. M	V		
		Ny. J	V		
		Ny. R	V		

Analisis :

Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

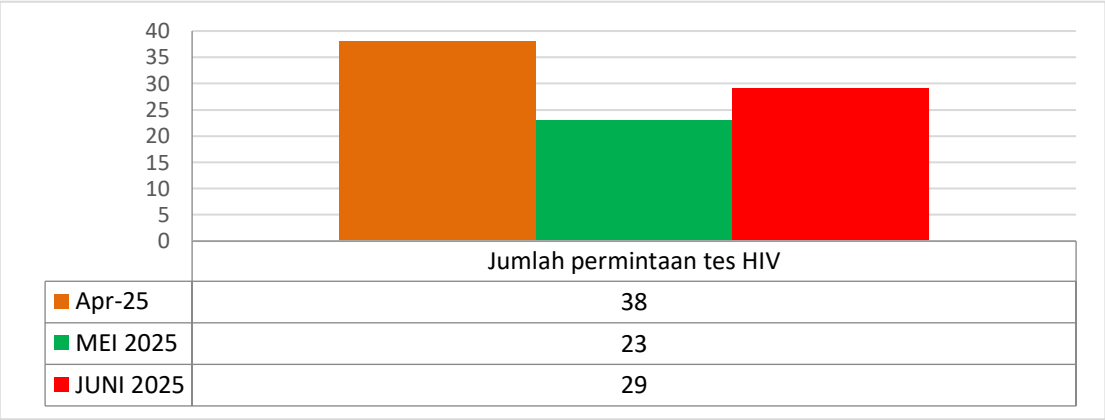
Rencana dan Tindak Lanjut :

Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Permintaan Test HIV	38	23	29

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan April 2025 sebanyak 38 pemeriksaan pada buln Me 2025 sebnyak 23 pmeriksaan Sedangkan pada bulan juni 2025 sebanyak 29 pemeriksaan.

Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	3	1	4
3	Poli Obgyn	17	8	13
4	Poli Penyakit Dalam	1	0	0
5	IGD	2	5	5
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	11	6	3

8	ICU	3	1	1
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	1	2	3

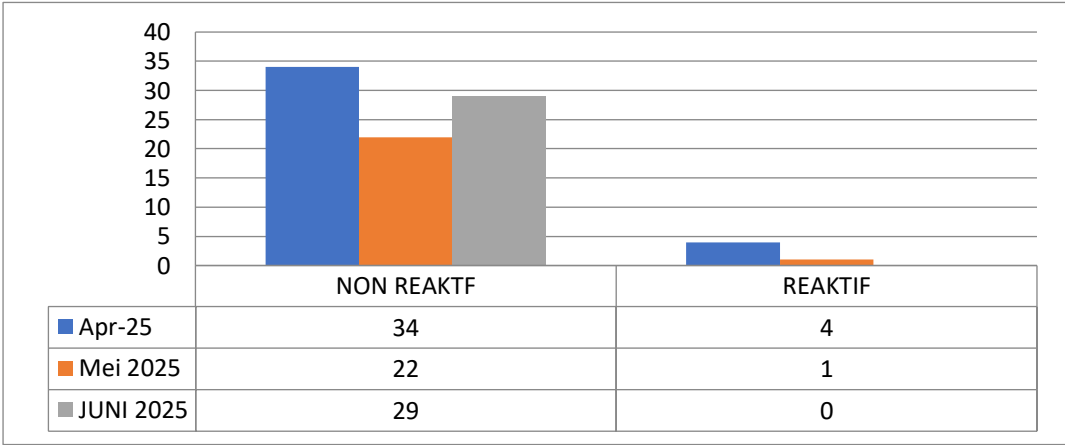
Analisis :
 Dari hasil diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan April 2025 sebanyak 17 pasien pada bulan mei 2025 sebanyak 7 pasien Sedangkan pada bulan Juni sebanyak 13 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
 Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Non Reaktif	34	22	29
2	Reaktif	4	1	0

Grafik Status HIV Juni 2025



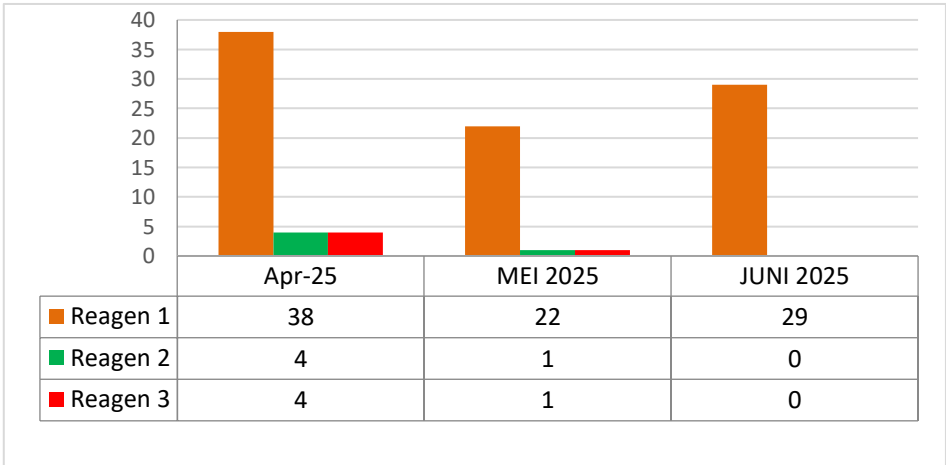
Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan April 2025 sebanyak 4 pasien. pada bulan Mei 2025 sebnyak 1 pasien Sedangkan pada bulan juni 2025 tidak ada pasien dengan status HIV reaktif

Rencana Tindak Lanjut :
 Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Reagen 1	38	23	29
2	Reagen 2	4	1	0
3	Reagen 3	4	1	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Juni 2025



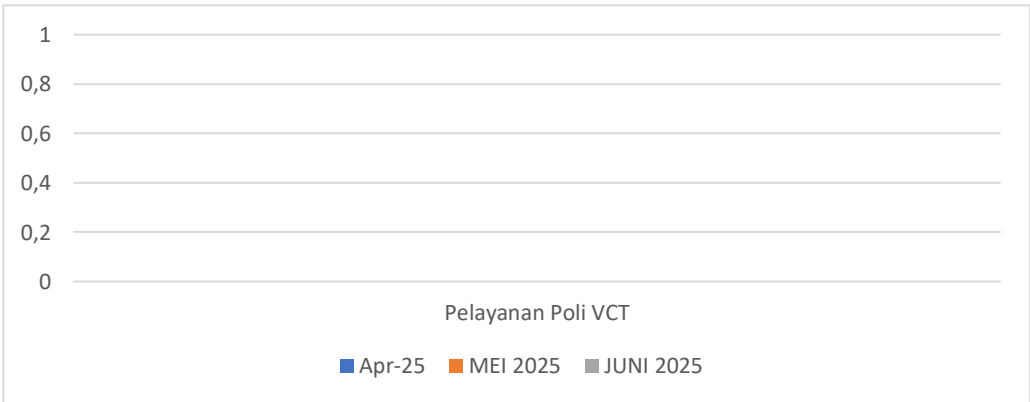
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan April memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 4 pasien. pada bulan mei 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2025 hanya memakai reagen 1 sebanyak 29 pasien

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Juni 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

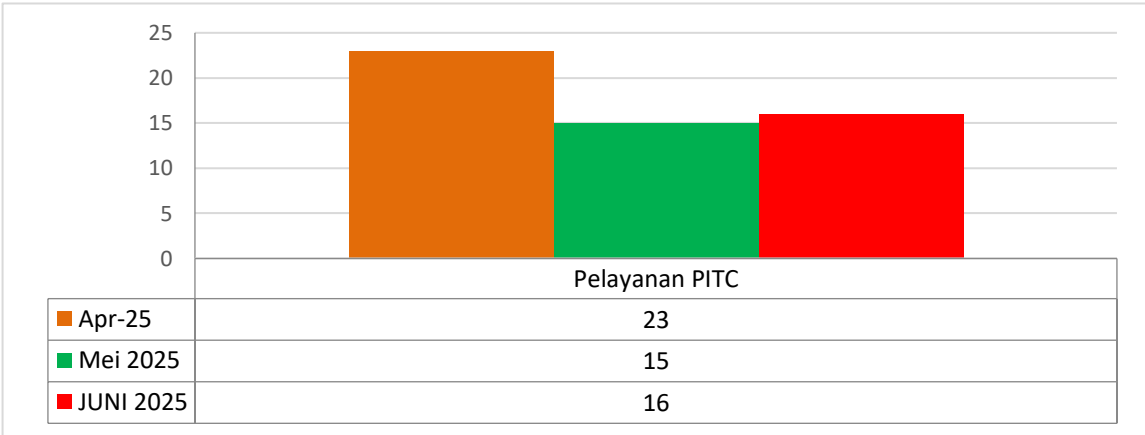
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenakan asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Pelayanan PITC	23	15	16

Grafik Pelayanan PITC Juni 2025



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan maret sebanyak 23 pasien. pada Bulan Mei 2025 sebanyak 15 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2025 sebanyak 16 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

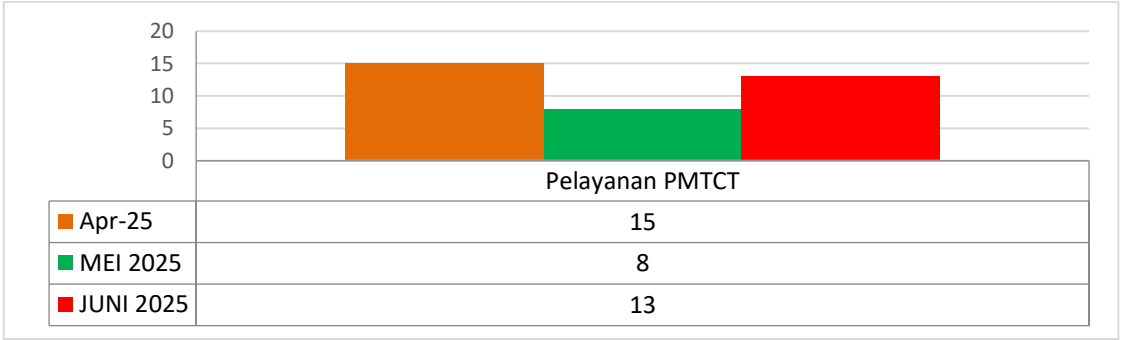
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Pelayanan PMTCT	15	8	13

Grafik Pelayanan PMTCT Juni 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan pada bulan April 2025 sebanyak 15 pasien. pada bulan Mei 2025 sebnya 8 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2025 sebanyak 13 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

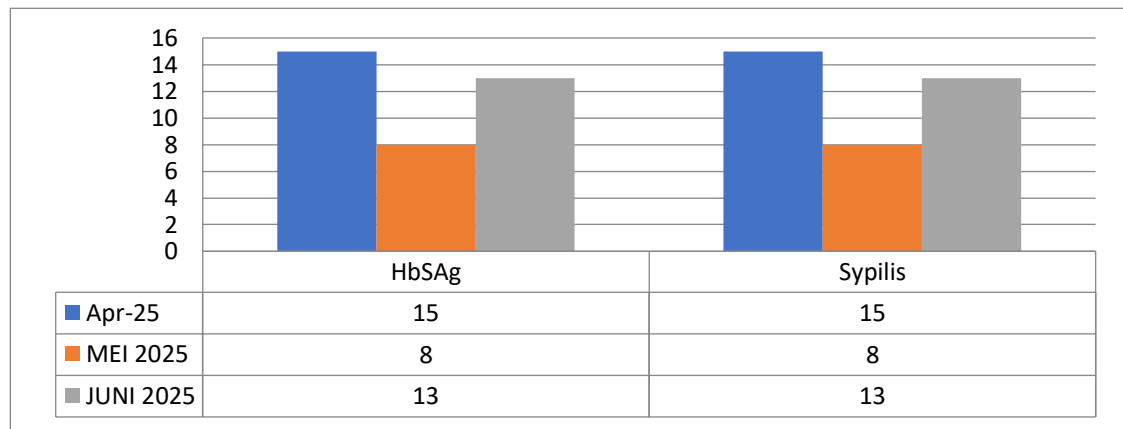
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	HbSAg	15	8	13
2	Sypilis	15	8	13

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Juni 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan pada bulan April 2025 sebanyak 15 pasien pada bulan Mei 2025 sebanyak 8 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2025 sebanyak 13 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan

Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan

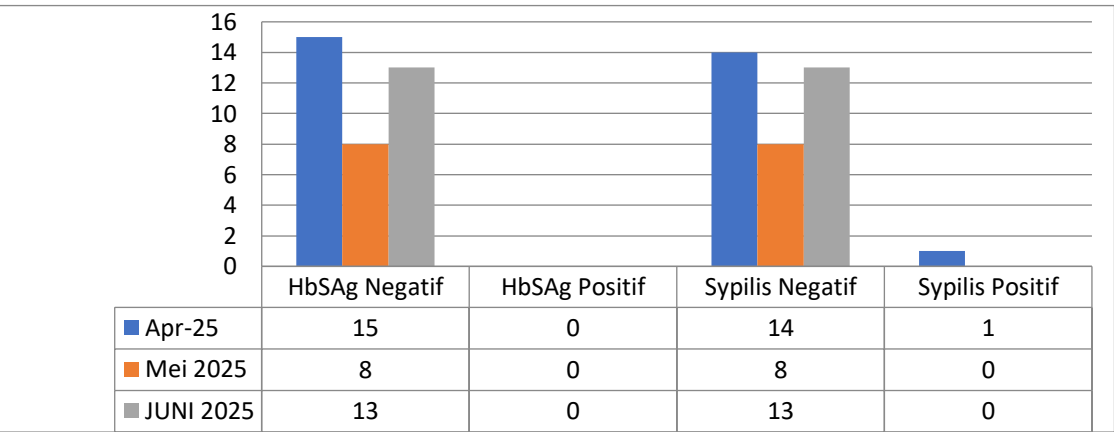
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	HbSAg			
	Negatif	15	8	13
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	14	8	13
	Positif	1	0	0

**Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Juni 2025**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan April, Mei dan Juni 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif. Sedangkan pada bulan april 2025 ditemukan 1 pasien positif Sypilis.

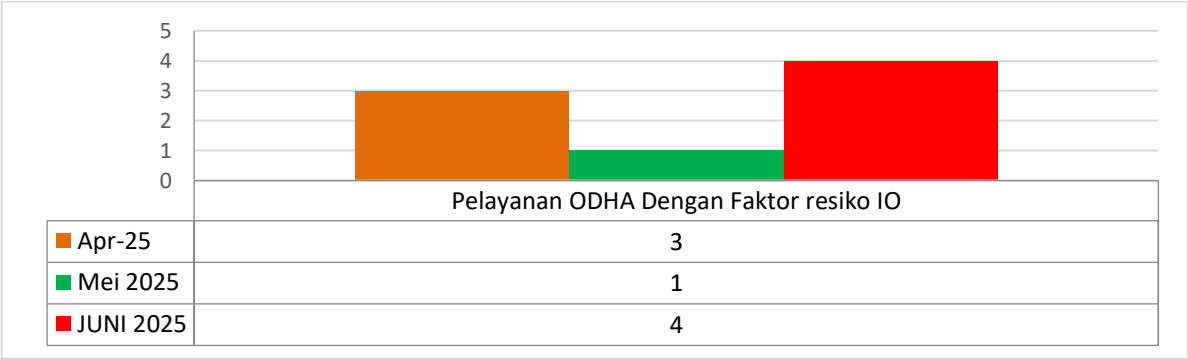
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	3	1	4

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Juni 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan april 2025 sebanyak 3 pasien. pada bulan Mei 2025 sebanyak 1 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2025 sebanyak 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

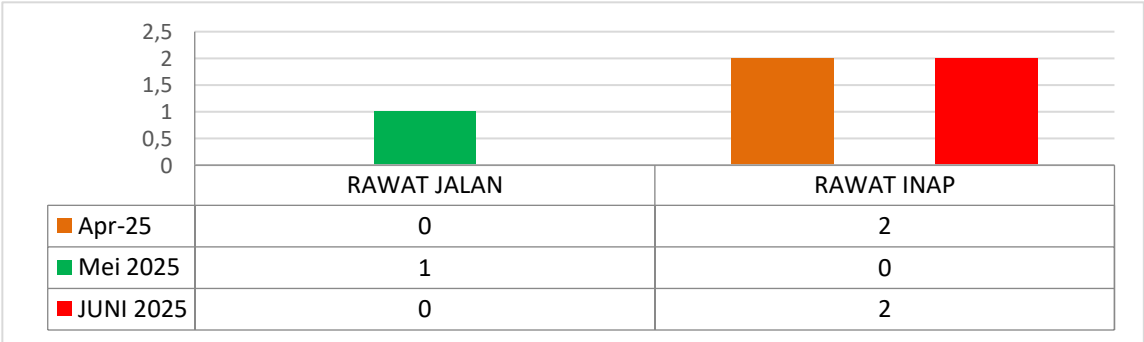
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
1	Rawat Jalan	0	1	0
2	Rawat Inap	2	0	2

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Juni 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan April 2025 terdapat 4 pasien yang dilakuka rujuk, 3 dari rawat inap dan 1 rawat jalan. pada bulan Mei 2025 terdapat 1 asien yang dirujuk dari rawat jalan. Sedangkan pada bulan juni 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Juni 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
7	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
8	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
9	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
10	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
11	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.

12	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.
----	---------------------------------	--

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1

Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1

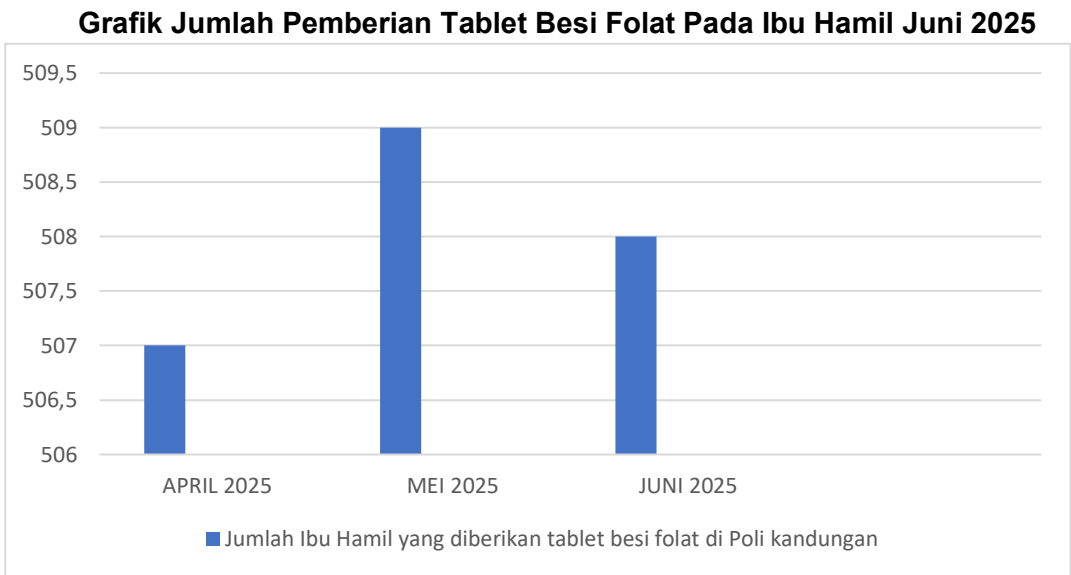
	ketersediaan bahan pangan di lingkungan					
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	507	509	508



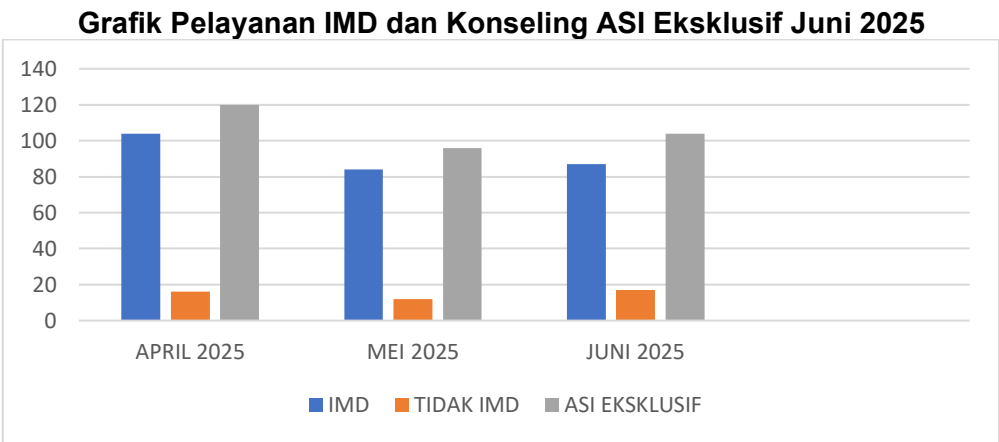
Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 509 di bulan Mei menjadi 508 pada bulan Juni yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	IMD	104	84	87
2	Tidak IMD	16	12	17
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	120	96	104



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juni sebanyak 87 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Juni 2025 yaitu sebanyak 104 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

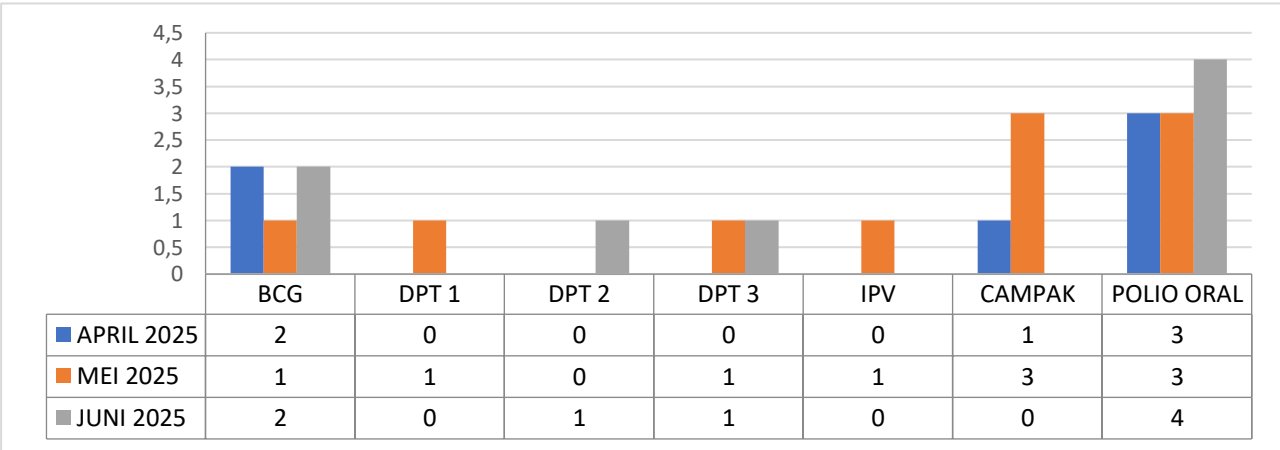
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	BCG	2	1	2
2	DPT 1	0	1	0
3	DPT 2	0	0	1
4	DPT 3	0	1	1
5	DPT 4	0	1	0
5	IPV	1	0	0
6	Campak	1	3	0
7	Polio Oral	3	3	4

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Mei 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 2 balita yang melakukan imunisasi BCG di bulan Juni 2025.
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi DPT 1, IPV, dan campak pada bulan Juni 2025.
- 3. Pada periode Juni 2025 terdapat 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio.
- 4. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi DPT 2 dan DPT 3 di RS. Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

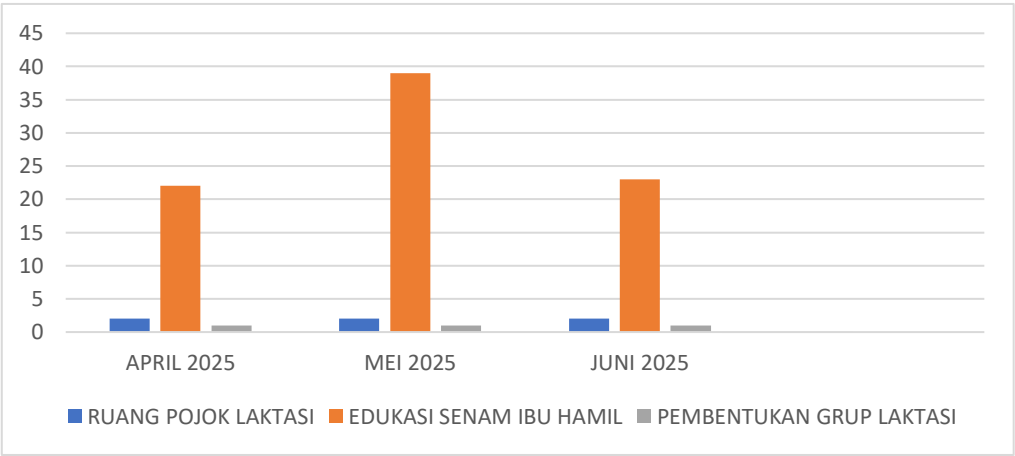
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter

spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	22	39	23
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Juni 2025



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Juni edukasi pada senam ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil sebanyak 13 peserta senam ibu hamil dan 10 peserta pasien rawat jalan di poli obgyn.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Maret	-	-	-	-

April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Juni 2025



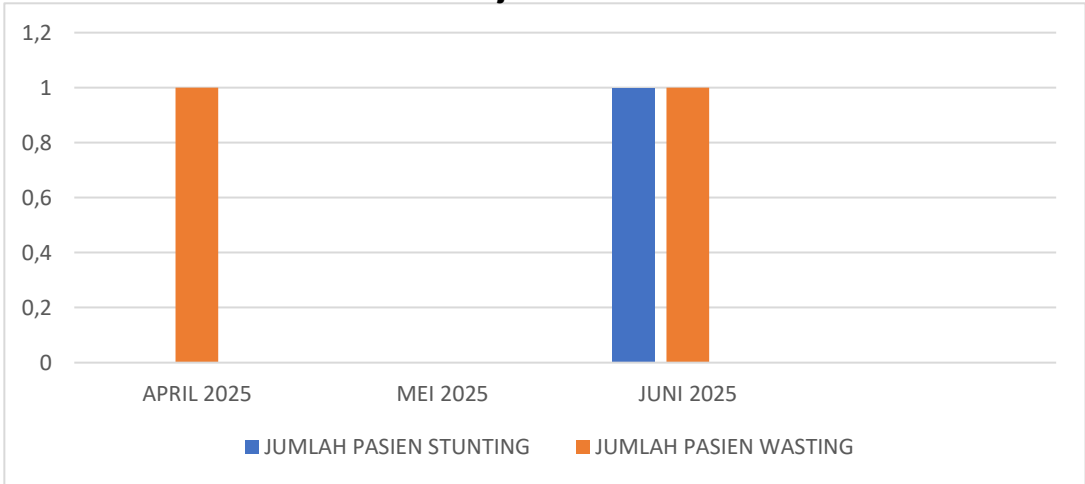
Analisis :
 Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
 Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting .

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	0	1
Jumlah Pasien Wasting	1	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Pada bulan Juni 2025 terdapat 1 pasien stunting dan wasting. Hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan makan yang kurang adekuat pada pasien. Ibu pasien mengatakan anak suka makan namun kurang beragam, contohnya sekali makan nasi degan abon saja. Di mana kebutuhan energi anak tidak adekuat, makanan yang dimakan tidak dapat memenuhi kebutuhan energinya. Selain itu, aktivitas fisik anak sangat aktif sehingga makanan harus lebih beragam dan tinggi kalori dan protein. Berdasarkan berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan pasien termasuk kategori *stunting* dan *wasting*.

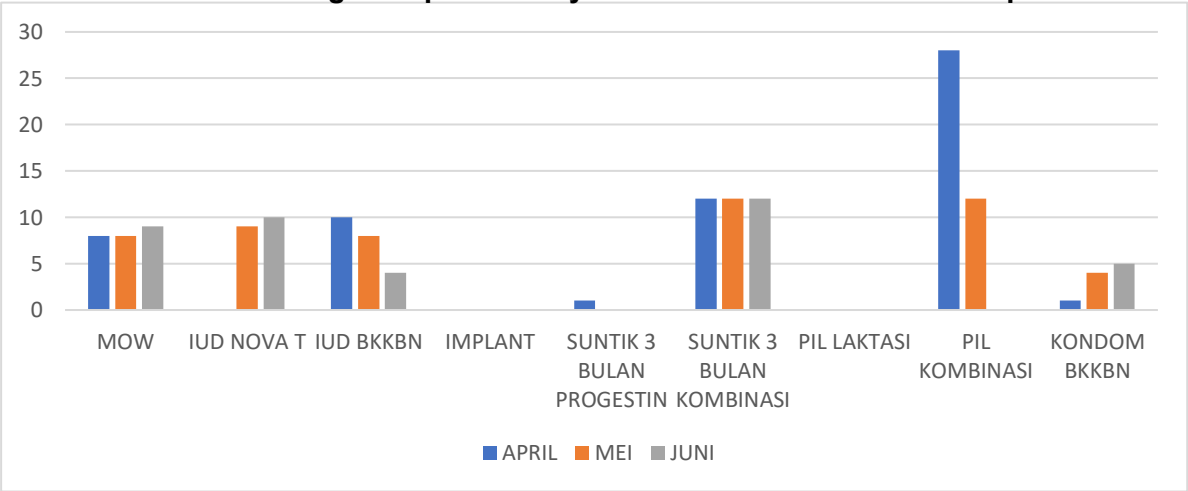
Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada telah melakukan kunjungan rumah pasien Bersama ahli gizi Puskesmas Lawang, bidan desa setempat, dan kader wilayah kerja.

3.1.2.5 KBRS
3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	MOW	8	8	9
2	IUD Nova T	0	9	10
3	IUD BKKBN	10	8	4
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	1	0	0
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	12	12	12
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	28	29	0
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	1	4	5

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan April turun (8)Mei tetap(8) Juni naik (9)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan April turun (0) Mei naik(9) Juni (10)
- 3. Peserta IUD BKKBN April turun (10) Mei (8) Juni (4)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan April turun (1) Mei (0) Juni

- 5. Peserta KB suntik progestin April tetap (12) Mei tetap(12) Juni (12)
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan April (28) Mei naik (29) Juni (0)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan April turun (12) Mei naik(48) Juni (5)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

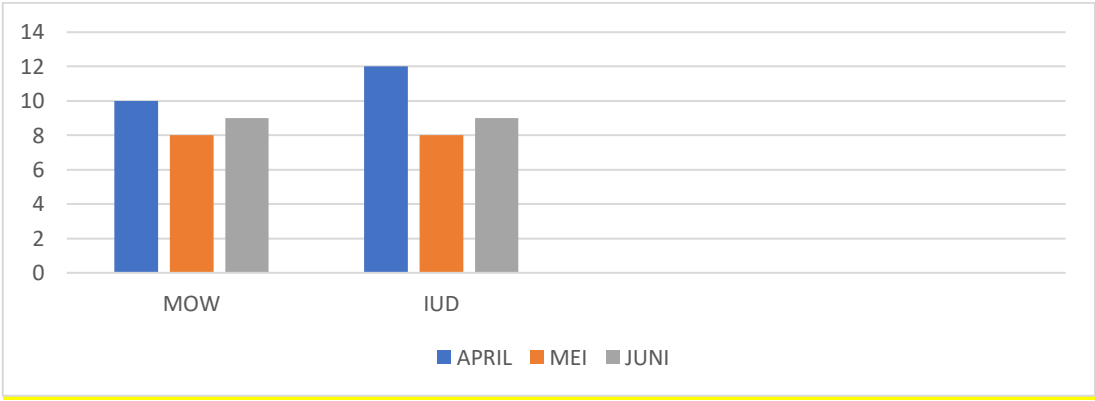
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

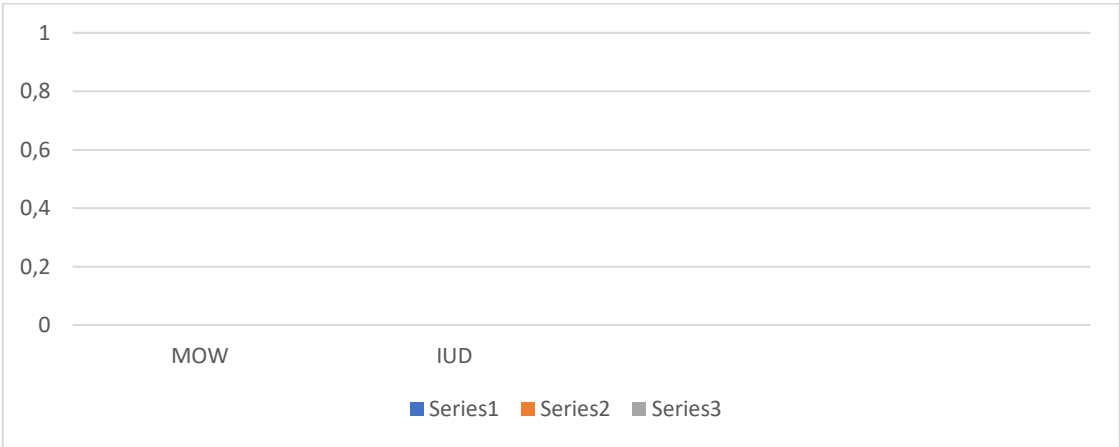
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	MOW	8	8	9
2	IUD	11	8	9

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN JUNI 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan April-Mei-Juni meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan April-Mei-Juni menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Nadiya F	P/27	dr.Aji, Sp.Pd	212900	TF	01/04/2025	03/04/2025	3	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
2	Titik Rustanti	P/60	dr. Zora, Sp.BP	159231	DM Hiperglikemi	03/04/2025	06/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
3	Kunainah	P/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	212694	General Weaknes + DM	05/04/2025	09/04/2025	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	Indy Belva A	P/18	dr. Sigit, Sp.BP	229437	CKR 456	06/04/2025	09/04/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
5	Sri Asnanik	P/68	dr. Yoga, Sp.JP	224631	Chest pain	07/04/2025	11/04/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin inf		1x0,4	1,6	0,8	2
6	Isman Hadi	L/42	dr. Zaky, Sp.B	228110	Hernia Ingunalis (S)	08/04/2025	10/04/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
7	Askur	L/72	dr. Heri, Sp. Pd	229547	DM Hiperglikemi	09/04/2025	11/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
8	Moch Dja'far	L/49	dr. Elvi, Sp. P	229771	Hemaptoe	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
9	Ninik Farida	P/53	dr. Anton, Sp.B	087303	CKR 456	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
10	Chindi M	P/30	dr. Aida, Sp. OG	075162	SC Eracs	14/04/2025	16/04/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Parto	L/65	dr.Ardhany, Sp. Pd	229814	CKD st V + Pneumoni	14/04/2025	17/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Purnomo Edi	L/73	dr. Anton, Sp.B	162566	Gangren necrotic diabeticum	15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5

13	Faizatul K	P/27	dr. Aida, Sp. OG	065799	SC	15/04/2025	18/04/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Hadi Mulyo	L/43	dr. Arianto, Sp.B	056807	Fracture of other parts	15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Suramah	P/64	dr. Ard hany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	16/04/2025	20/04/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5
16	Sutiani	P/57	dr. Zora, Sp. Pd	178669	Gatroenteritis	17/04/2025	20/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	1	2x0,2	1,4	0,8	1,75
17	Nofi C	P/42	dr. Zora, Sp. Pd	172291	TF	20/04/2025	24/04/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1	0,5	2
18	Anggi Annur	P/24	dr. Anton, Sp.B	230259	Necrotizing facitis coli	23/04/2025	25/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
19	Moch Ridwan	L/60	dr. Yoga, Sp. JP	182365	DM krisis hiperglikemi, ALO	23/04/2025	28/04/2025	6	Levofloxacin po	2	1x0,5	2	0,5	4
									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
20	Jumanah	P/71	dr. Ard hany, Sp. Pd	230369	CHF	25/04/2025	28/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Rubi'ati	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	204084	DM Type 2	04/05/2025	07/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,75	3	0,5	6
									Metronidazole inf		2x0,5	4	1,5	2,67
2	Kasiati	P/49	dr. Humaira, Sp.OG	203066	Endometriosis	06/05/2025	08/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
3	Ainun Ulumi	P/22	dr. Aida, Sp.OG	206805	SC	08/05/2025	10/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
4	Ida Rahmawati	P/27	dr. Aida, Sp.OG	071885	SC	09/05/2025	11/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Santoso	L/80	dr. Mira, Sp.JP	081276	Heart Failure	10/05/2025	13/05/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
6	Ari Anita	P/36	dr. Andi, Sp.BP	231095	Necrotizing Fascitis	12/05/2025	15/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone		2x1	4	4	1
7	Muchlis Hanafi	L/62	dr. Ardhi, Sp.Pd	186772	OF	13/05/2025	15/05/2025	3	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
8	Elisabet G	P/27	dr. Ardhany, Sp.Pd	231152	TF	14/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
9	Sri Widodo	P/62	dr. Ardhany, Sp.Pd	058182	TF	15/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
10	Badriyah	P/61	dr. Anton, Sp.B	116956	Necrotizing Fascitis	16/05/2025	18/05/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
11	Titus Sukriwani	L/64	dr.Ardhany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	17/05/2025	21/05/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5

12	Catur Priyo	L/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	231309	Febris	19/05/2025	22/05/2025	4	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
13	Sumini	P/ 61	dr.Andy, Sp. P	143421	Hemoptysis	21/05/2025	23/05/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
14	Adi Sumarto	L/48	dr. Oka, Sp.OT	231518	Injury of unspecified body region	21/05/2025	23/05/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Fikri	L/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	231562	Cronic Fever	22/05/2025	25/05/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
16	Siti Djumainah	P/56	dr. Zora, Sp.Pd	231203	Septic syok	22/05/2025	27/05/2025	6	Metronidazole inf	2	3x0,5	9	1,5	6
									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
17	Ahmad Fikri	L/21	dr. Zaky, Sp.B	231019	Ganglion Curpi	23/05/2025	25/05/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,2
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	3
18	Asri Ramasari	P/ 30	dr.Andy, Sp. P	201226	Atshma	24/05/2025	27/05/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
19	Siti Rochmah	P/53	dr. Andi, Sp.B	231691	Susp Appendic	25/05/2025	28/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
20	Nurhayati	P/65	dr. Zaky, Sp.B	101888	Colic Abdomen	26/05/2025	29/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3

3.2.3.1.4 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1.	Dewi Agung	P/46	dr. Zaki, Sp.B	155781	Gangrenen	03/06/2025	04/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
2.	HJ. Praptini	P/69	dr. Ira, Sp.JP	223270	ALO	04/06/2025	07/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	0,5	0,5	1
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
3.	Syafa Nabila	P/16	dr. Anton, Sp. B	232241	Abdominal pain	06/06/2025	09/06/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
4.	Tasmi	P/85	dr. Zaki, Sp.B	232263	Hemoroid	07/06/2025	08/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
5.	Sa'i	L/65	dr. Andi A, Sp. B	232330	Carcinoma thyroid	08/06/2025	11/06/2025	4	Cefoperazone	1	2x1	6	4	1,5
6.	Tri Agustinayanti	P/34	dr. Ardhi, Sp.Pd	232331	TF	08/06/2025	11/06/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
7.	Asniwati	P/61	dr. Ardhany, Sp.Pd	232373	Cholelithiasis	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1	0,5	2
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8.	Mutmainah	P/82	dr. Ira, Sp.JP	232361	Venticular premature	09/06/2025	11/06/2025	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
9.	Misri	L/41	dr. Yoga, Sp.JP	206726	NSTEMI	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,75	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
10.	Nike Chusnul	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	214788	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11.	Nasrul Ilham M	L/25	dr. Pradana, Sp. U	175034	Hydronephrosis	10/06/2025	12/06/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
12.	Erista Yustiana	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	224330	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
13.	Ngatoko	L/68	dr. Elvi, Sp. P	232410	Pulmonary Hypertension	10/06/2025	15/06/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Meropenem		2x1	7	3	2,3
	Solicha	P/28	dr. Farid, Sp.N	135511	Stroke	13/06/2025	17/06/2025	5	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3

14.									Ceftriaxone		2x1	8	2	4
15.	Clarisa Venta	P/25	dr. Zaki, Sp.B	199240	Neoplasm of breast	17/06/2025	19/06/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
16.	Sri Ari Bawaning	P/62	dr. Elvi, Sp.P	217237	Asthma	20/06/2025	24/06/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
17.	Harwati H	P/70	dr. Mira, Sp. JP	180211	Syok condition	21/06/2025	26/06/2025	6	Cefoperazone	1	3x1	14	4	3,5
18.	Isnaniyah	P/60	dr. Zaki, Sp.B	211220	Gangren Necrotic	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefoperazone	3	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
19.	Endang Tri	P/54	dr. Zaki, Sp.B	227974	Diabetic foot	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefoperazone	3	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
20.	Latifatul Z	P/23	dr. Aida, Sp.OG	232991	Premature	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

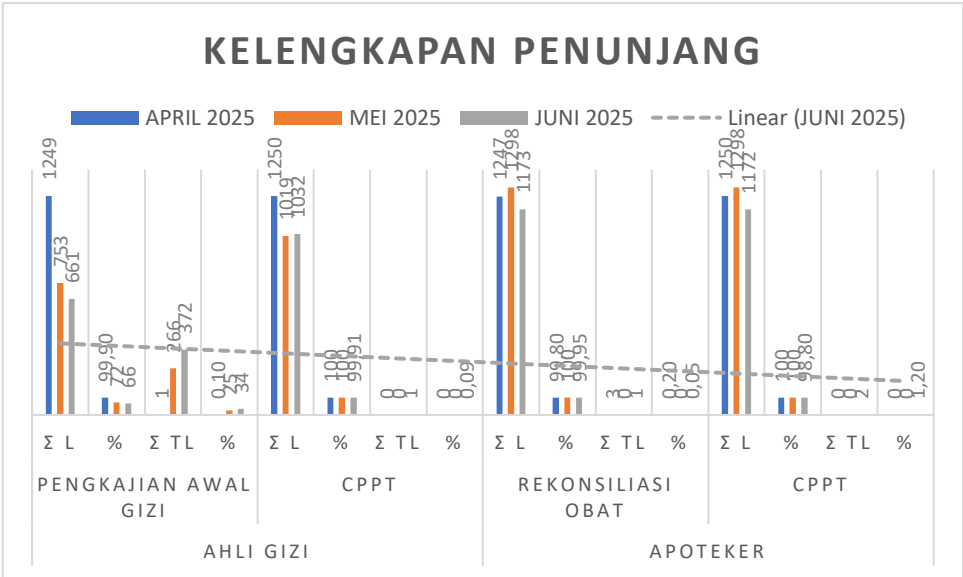
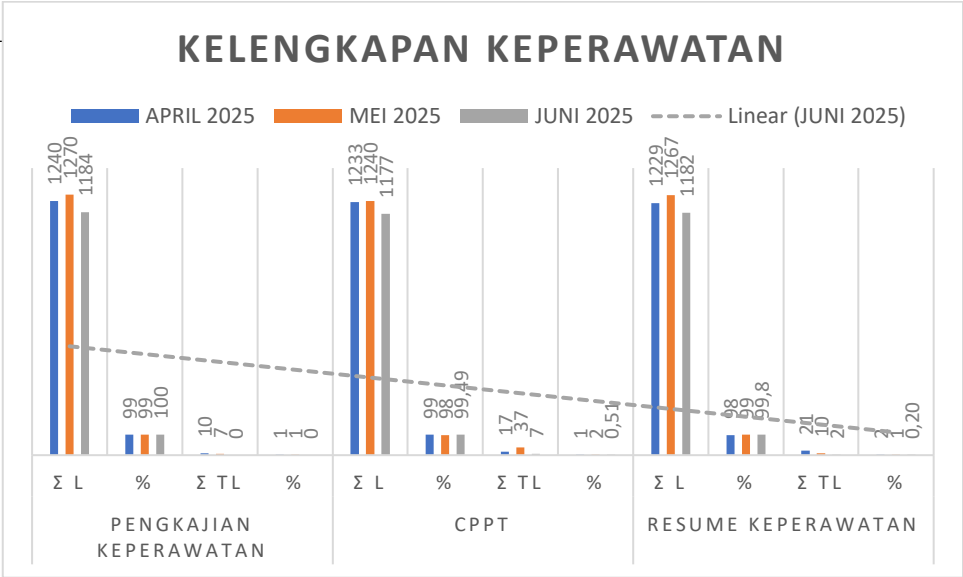
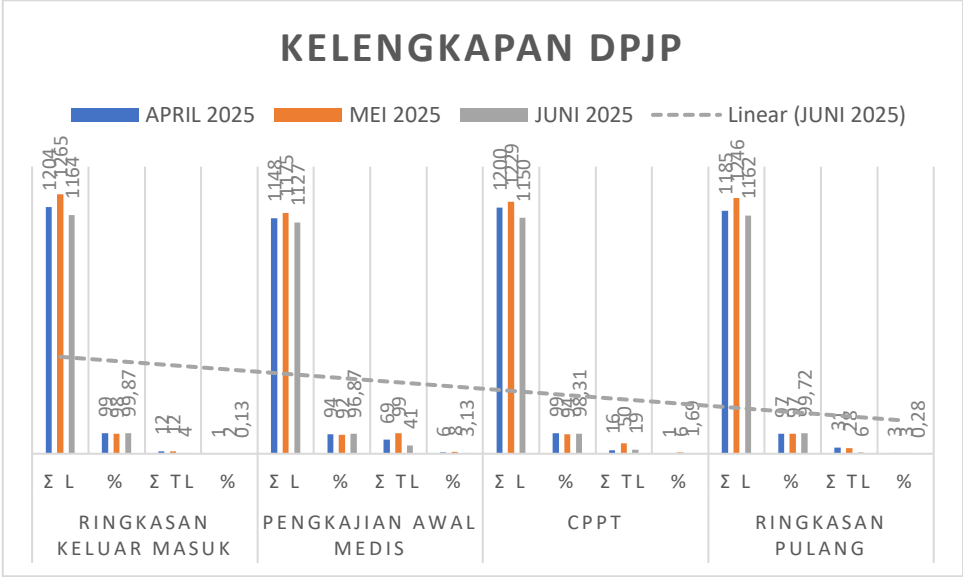
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Juni Tahun 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2

3.6.6.2 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Juni 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi mengalami peningkatan pada dokumen pengkajian awal medis gizi, dari 25% menjadi 34% yaitu sebanyak 372 dokumen tidak lengkap.
- 2. Pengkajian keperawatan 100% lengkap pada Bulan Juni 2025.

- Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Juni 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- Menginformasikan kepada Kepala Ruang hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- Melakukan supervise secara berkala.
- Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- Membuat rapot ketidaklengkapan .
- Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	2 Pasien batal operasi karena kondisi Dua pasien membatalkan operasi karena kondisinya menurun, sementara BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) sudah dibuka sehingga tidak bisa digunakan untuk pasien lain.	P	1.Susun SOP baru :BMHP hanya di buka 30 menit sebelum anestesi setelah verivikasi kondisi pasien 2.Sosialisasi kepada tim bedah,anestesi,dan penunjang medis 3.Siapaikan checklist”ready-for BMHP” yang di isi sebelum pembukaan
		D	Terapkan SOP pembukaan BMHP sesuai dengan ceklist Catat setiap proses,siapa,kapan,kondisi pasien,status BMHP, apakah operasi lanjut atau batal Dokumentasi kendala
		S	Apakah menggunakan SOP yang baru banyak perubahan atau tidak terkait BMHP
		A	Lakukan evaluasi terhadap SOP yang baru jika berhasil lakukan dengan rutin
2	Ditemukan jarum di area Laundry sebagai akibat kelalaian petugas iko yang tidak melakukan pengecekan sesuai dengan SOP	P	1.Revisi SOP laundry: wajib double -check alat tajam oleh petugas dan supervisor 2.Sosialisasikan perubahan ke seluruh tim laundry
		D	Terapkan SOP untuk double chek di laundry
		S	Evaluasi selama 2 minggu
		A	Lakukan evaluasi terhadap SOP yang baru jika berhasil lakukan dengan rutin

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Banyaknya pemasangan infus yang kurang standart di IGD	P	Sosialisasi ulang SPO pemasangan infus kepada seluruh perawat IGD Supervisi langsung oleh kepala ruangan
		D	Sosialisasi selama 1 minggu secara berturut turut Kepala ruangan dan tim mutu melakukan

			supervisi harian selama 2 minggu
		S	Lakukan pendampingan pada jam sibuk Perlu membuat dokumentasi cepat
		A	Evaluasi berkala melalui audit kepatuhan pemasangan infus Menjadwalkan peserta mencari pasien untuk dilakukan penginfusan
2	Pelayanan di IGD yang masih sering ada komplain terkait komunikasi pasien	P	1. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi pasien dan keluarga pasien di IGD 2. Pelatihan petugas: Memberikan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi 3. Pengembangan protokol komunikasi: Mengembangkan protokol komunikasi yang jelas dan standart untuk digunakan di IGD
		D	1. Implementasi pelatihan: Melakukan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi yang efektif 2. Penggunaan protokol komunikasi: Menggunakan protokol komunikasi yang telah dikembangkan di IGD
		S	1. Evaluasi kualitas komunikasi: Mengevaluasi kualitas komunikasi di IGD melalui survei pasien dan keluarga pasien 2. Analisa Data: Menganalisis data yang diperoleh dari survei untuk mengetahui apakah kualitas komunikasi di IGD telah meningkat
		A	1. Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
3	Awal awal ERM di iGD banyak kendala terkait pengisian	P	Melakukan sosialisasi singkat penggunaan ERM Menyusun panduan pengisian ERM yang mudah di pahami Lakukan pendampingan saat awal awal ERM
		D	Pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan focus pada fitur utama ERM Panduan pengisian dibagikan dalam bentuk file Petugas mendampingi secara terus
		S	Mengevaluasi pengisian rekam medis setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan untuk ERM
		A	Membuat video tutorial dalam pengisian
4	Kurang patuhnya pengisian rigester di IGD terutama jam transfer pasien	P	1. Edukasi ulang tentang pentingnya jam transfer 2. Supervisi harian oleh kepala jaga untuk memeriksa rigester 3. Buat sistem pelaporan kepatuhan harian/mingguan
		D	1. Lakukan edukasi dalam 3 shif (pagi, sore, malam) 2. Kepala shift atau koordinator perawat IGD menegecek rigester setiap akhir shif 3. Membuat table monitoring mingguan untuk tracking kepatuhan pengisian
		S	1. 2 dari 5 shift masih menunjukkan kelalaian,

			terutama saat IGD ramai 2. Petugas merasa terbantu dengan checklist dan pengingat visual
		A	1.Revisi SOP: sebelum pasien di pindahkan ,pengisian rigester wajib-verifikasi oleh kepala jaga 2.Buat sistem penanggung jawab pencatatan per shif
5	Penanggung jawab shift IGD saat ini kurang optimal dalam menjalankan perannya untuk memastikan kelancaran pelayanan.”	P	1.Lakukan biefing shift berdurasi 5 menit sebelum shift dimulai 2.Terapkan monitoring harian dan supervisor utama terhadap peran
		D	1.Supervisi dilakukan selama 1 minggu
		S	Apakah ada masalah tertangani lebih cepat dengan dilakukan monitoring dan briefing
		A	Terapkan briefing di semua shift Dan tetapkan supervisor untuk memantau

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Operan keliling di unit rawat inap tidak berjalan dengan baik	P	Membuat checklist operan yang harus di bahas di unit
		D	Gunakan ceklist selama operan dan dokumentasikan secara konsisten Ambil catatan kendala atau resistensi dari staf
		S	1.Kumpulkan feedback dari staf 2.Lihat dokumentasi operan 3.Observasi langsung beberapa operan untuk menilai kualitas komunikasi 4.Bandingkan data kepuasan pasien dan staf sebelum dan sesudah
		A	1.Jadikan checklist bagian dari sop operan keliling
2	Kurang pekanya petugas perawat ke pasien	P	1.Terapkan program 5 S 2. Supervisor melakukan observasi pendek harian ke pasien
		D	1.Implementasikan program 5S dan umpan balik harian selama 2 minggu 2. Supervisor mencatat observasi perilaku empatik
		S	1.Tingkat kepuasan pasien akan meningkat 2.Jumlah komplain akan menurun 3.Kedekatan pasien dan perawat akan lebih dekat
		A	1. Mengintegrasikan program empati ke dalam alur kerja, contoh mengganti infus 2. Lanjutkan observasi supervisor dan rotasi pelatihan untuk staf baru
3	Banyaknya pemasangan infus yang kurang standart di IRNA	P	Sosialisasi ulang SPO pemasangan infus kepada seluruh perawat IRNA Supervisi langsung oleh kepala ruangan
		D	Sosialisasi selama 1 minggu secara berturut turut Kepala ruangan dan tim mutu melakukan supervisi harian selama 2 minggu
		S	Lakukan pendampingan pada jam sibuk Perlu membuat dokumentasi cepat

		A	Evaluasi berkala melalui audit kepatuhan pemasangan infus Menjadwalkan peserta mencari pasien untuk dilakukan penginfusan
4	Banyaknya masalah terkait ERM terkait bug dan sistem yang belum sempurna	P	Koordinasi dengan tim programmer terkait ERM yang bermasalah
		D	Membuat group yang ada programernya sehingga jika ada masalah bug langsung bisa di tindak lanjut
		S	Respons cepat berhasil meningkatkan pengguna
		A	Sediakan bfeedback rutin ke user tentang status bug yang sudah di perbaiki
5	"Ditemukan pasien dengan kondisi klinis yang memburuk dirawat di bangsal rawat inap, padahal seharusnya mendapatkan perawatan di ICU."	P	Pantau form NEWS apakah berjalan dengan baik
		D	Mencatat data pasien yang seharusnya ke ICU tetapi tidak masuk ICU
		S	Kumpulkan feedback ke dokter DPJP pasien dengan kondisi menurun tetapi tidak di rawat di ICU
		A	Menghubungi DPJP jika ada data yang tidak masuk ICU

3.7.4
Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	"Kelengkapan ERM harus dicek kembali karena ke depannya tidak ada pengecekan ulang dari bagian verifikasi."	P	1.Mensosialisasikan program dari manajemen terhadap ERM yang tidak akan di cek ulang oleh bagian verifikator ke bagian perawat yang asisten dokter
		D	1.Mengumpulkan perawat rawat jalan terhadap program ERM ini
		S	Di temukan banyak ERM yang masih kurang lengkap
		A	1.Selalu mengecek ERM sebelum di kirim ke verif
2	Kurangnya sosialisasi dari pihak farmasi ke DPJP terkait kekosongan obat	P	1.Membuat sistem early warning list obat kosong/terbatas yang di update harian oleh farmasi 2.Menunjuk PIC farmasi yang bertanggungjawab menyampaikan update
		D	Farmasi membuat list obat kosong/kritis tiap pagi jam 08.00 PIC farmasi mencatat siapa saja yang sudah menerima informasi Uji coba sistem ini selama 2 minggu
		S	Jumlah resep kosong teratasi DPJP merasa lebih mudah mengantisipasi pergantian obat
		A	Terapkan sistem digital Evaluasi mingguan oleh tim farmasi
3	Kurangnya service excellent dari petugas terkait keramahan petugas	P	Mengadakan pelatihan singkat terkait service excellent dan komunikasi empatik Supervisi harian diam-diam oleh kepala unit
		D	Laksanakan pelatihan di semua shift Supervisi melakukan pengamatan diam-diam terhadap minimal 3 interaksi petugas/hari

		S	Hasil evaluasi 1-2 minggu awal Ditemukan bahwa beberapa area (contoh:IGD) lebih sulit menerapkan service excellent saat over load
		A	Melanjutkan pelatihan jika evaluasi berhasil
4	“Tim umum melakukan pengambilan barang dari poli tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak poli terkait.”	P	Menyusun SOP yang mewajibkan konfirmasi sebelum pengambilan barang Melakukan sosialisasi kepada seluruh tim umum dan staf poli terkait
		D	Menerapkan SOP selama 2 minggu di unit 1 poli sebagai uji coba Melakukan konfirmasi sebelum setiap pengambilan barang
		S	Menganalisi data yang dikumpulkan selama periode implementasi
		A	Melakukan sop yang baru

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT			
1.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban	Selisih	Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan		
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0		
		A	- Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. - Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. - Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. - Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO		

			berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. - Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan
2.	Pengambilan obat tertinggal sudah tidak ada batas waktu karena pelayanan farmasi 1x24 jam	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas agar tidak menolak pasien yang mengambil obat tertinggal
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan TTK
		S	Evaluasi informasi waktu pengambilan obat di farmasi : Senin – jumat pukul 06.30 – 21.00 WIB Sabtu – minggu pukul 06.30 – 14.00 WIB
		A	Farmasi melayani 24 jam jika ada pasien yang mengambil obat tertinggal
3.	Kasus pasien komplain karena akan pesan vaksin namun oleh farmasi diarahkan ke kasir untuk pembayaran, kasir menolak karena tidak tau nama vaksinnya sehingga di arahkan ke CSO, kemudian oleh CSO di arahkan ke marketing. Seharusnya unit bisa saling koordinasi melalui telpon dan konsul ke direksi untuk dibuatkan alur sehingga pasien tidak bingung.	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas alur pelayanan vaksin non pemerintah
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan TTK
		S	Belum ada alur yang jelas terkait dengan vaksin non pemerintah tanpa kontrol ke poli
		A	1. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasein) 2. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. 3. Resep kemudian di fotokan untuk diorderkan oleh gudang farmasi. 4. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. 5. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan berdasar kwitansi manual sebelumnya. 6. Pasien melakukan suntik di poli vaksin
4.	Retur barang dari rawat inap : - Obat tak bertuan → gudang retur (secara sistem), namun fisiknya dikembalikan ke rak barang retur di depo farmasi → setelah diretur ke gudang, kains akan order obat dengan jumlah sesuai yang ada di gudang retur agar dapat	P	Pelaksanaan retur obat tidak bertuan dan obat bertuan berjalan rutin
		D	Sosialisasi alur retur obat untuk meminimalkan selisih stok
		S	Tidak perlu ada gudang retur karena menambah rantai proses retur yang tidak diperlukan. Untuk efisiensi, seluruh obat dari unit baik bertuan atau tidak harus dikembalikan melalui depo farmasi.

	dimasukkan kembali menjadi stok depo. - Obat bertuan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan. Retur barang dari rawat jalan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan	A	1. Obat bertuan dikembalikan melalui fitur Retur Penjualan. 2. Obat tidak bertuan dikembalikan melalui fitur sesuai dengan kondisinya yaitu : - Penerimaan Barang Konsinyasi - Penerimaan Obat yang Dibeli Antar RS - Penerimaan Obat Tidak Bertuan 3. Fitur penerimaan farmasi lainnya dibuat berjenjang : diajukan oleh Kains Farmasi (dengan adanya fitur keterangan untuk menjelaskan alasan penerimaan obat lainnya) → diapprove oleh PT → baru bisa menambah ke stok depo. Berita Acara tetap dilampirkan sebagai arsip RS. 4. Buat PJ retur tiap shift di depo yang bertanggung jawab terhadap proses retur mulai dari penerimaan barang fisik, penginputan ke sistem, penilaian obat layak/tidak, pengembalian obat retur di rak obat depo
5.	Perubahan alur stok opname	P	Perhitungan stok opname dimulai ketika pelayanan rawat jalan sudah sepi tidak menunggu PT datang pukul 19.00
		D	PJ rak mulai perhitungan dan PJ input dilanjutkan oleh shift siang serta dilanjutkan verifikasi perhitungan ulang yang selisih.
		S	Evaluasi alur stok opname
		A	Perhitungan stok opname bisa dicicil (shift pagi tidak perlu kembali ke RS jam 19.00) mulai jam 14.00 selesai pelayanan poli rawat jalan sampai selesai. 2 orang TTK depo perbantuan perhitungan di gudang. Petugas shift siang menjadi PJ input dan mobile penyiapan IGD. Resep yang di proses diatas jam 14.00, ditulis dikertas untuk nanti dikurangi di akhir perhitungan. Resep umum, minta nota manual ke kasir dan resep di proses setelah SO. Jam 19.00 mulai menginput hasil SO dan diserahkan ke bagian PT untuk validasi.
6.	Perubahan Alur Kombinasi ODD-UDD	P	Perubahan jadwal TTK dan alur kombinasi ODD-UDD
		D	Plotingan jaga rawat inap pada shift pagi dan siang dibuat 1 atau 2 orang sehingga yang lainnya fokus di rawat jalan. Pelayanan resep ODD shift siang ditiadakan dan komposisi shift malam 2 TTK.
		S	Waktu tunggu farmasi meningkat sehingga perlu ada evaluasi jadwal TTK dan alur Kombinasi ODD - UDD
		A	Perubahan alur kombinasi ODD - UDD pada Perawat/ Bidan : 1. Peresepan obat dimulai pukul 19.00-21.00. 2. Lengkapi obat oral maupun injeksi dengan signa, aturan pakai (sebelum/sesudah makan),

			keterangan (menggunakan pagi, siang, malam). - KECUALI untuk obat yang berinteraksi dan indeks terapi sempit, berikan jam pemberian pada keterangan (akan di stabilo oleh apoteker di DPOnya). - Peresepan diatas jam 21.00 yang akan diambil segera, dituliskan pada keterangan "diambil sekarang". - Peresepan obat diatas jam 21.00 yang akan ikut ODD dan tidak diambil sekarang DIINPUTKAN KEMBALI dan DIPISAH dengan resep obat yang diambil segera. - Peresepan obat diatas jam 21.00 yang terdapat obat puyer/racikan tetap diikuti ODD (dituliskan keterangan : pagi, siang, sore (diambil sekarang 2 bungkus/kapsul)). - Jika ada pasien yang pindah ruangan setelah resep ODD selesai diinput, maka perawat asal ruangan pasien wajib WhatsApp dan telfon farmasi menginformasikan pasien pindah ke ruangan mana. - Perawat memberikan obat ke pasien secara UDD (dosis satu kali pemberian). Perubahan alur kombinasi ODD - UDD pada Farmasi : - Shift pagi, Jam 07.00 pagi (diberi 1 jam pengecekan) double check 1 orang untuk semua obat, TTK lain membantu IRJA dan pelayanan IGD dan RF. - Shift siang fokus pelayanan IRJA, tetap ada PJ IRNA untuk pelayanan IGD dan RF. - Shift malam mengerjakan obat ODD mulai dari print resep, etiket, penyiapan obat dan BMHP di depo dan juga pelayanan IGD. - Penyiapan obat tetap dipisah sesuai waktu pemberian (UDD).
7.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. April 2025 = +5.327.247 Mei 2025 = -237.537 Juni 2025 = +5.601.563 Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT.	P D S A	Perencanaan scan barcode. - Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. - Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien. Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner

			barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
8.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 54.88% dan waktu tunggu obat racikan 31.23%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Follow up ke Programmer. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 128 KPO.
9.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaiki kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	1. Obat tertinggal bulan Juni mengalami peningkatan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Primantara sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Admin primantara tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
10.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	1. Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
11.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan indikator vaksin pemerintah yang berubah warna sehingga tidak layak	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali.

	digunakan.		2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.
12.	Floorstok IKO	P	Mendisiplinkan perawat untuk menjalankan SPO.
		D	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.
		S	Kendala di FS IKO dimana perawat anestesi belum menjalankan inputan resep terlebih dahulu kemudian disiapkan oleh farmasi dikarenakan tidak menyanggupi jika operasi berlangsung berturut-turut. Dan informasi SPO sudah diedarkan dan dijelaskan namun perawat belum menjalankan sesuai SPO.
		A	Monitoring dan evaluasi.
13.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). April 2025 = 47 resep Mei 2025 = 39 resep Juni 2025 = 38 resep	P	Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol. 2. Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" : a. Input resep IU di apol b. Copy no apol c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Konfirmasi ke grup whatsapp Surat Kontrol jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format : Form Order Perubahan Tanggal Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa

			c. Pendaftaran mengubah di V-Claim d. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. e. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.
--	--	--	---

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberika kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.
		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu. 3) Petugas magang secara bergilir setiap 2 minggu sekali.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3. Menentukan stok minimal untuk order

			reagen.
5.	Pengadaan rectal swab di Lab RS Prima Husada Malang	P	Mengajukan TOR pelayanan rectal swab.
		D	Diskusi dengan Kains Laboratorium RS, dr Ari Putri, Sp.PA
		S	Utilitas jarang tidak direkomendasikan, kecuali jika bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk MCU.
		A	Proses perhitungan unit cost, jika sudah maka akan diajukan TOR.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan. Kolaborasi dengan Programmer PT untuk menambahkan fitur surat control fisioterapi.
		S	Perawat fisioterapi masih belum bisa menginput surat kontrol pasien bpjs yg berasal dari surat rujukan utama, sehingga masih pasien masih diarahkan ke pendaftaran untuk mencetak surat kontrol
		A	1. Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Follow up ke Programmer PT.
3.	Pendaftaran masih mendaftar pasien pada waktu jam praktik dokter sudah selesai.	P	Membuat kebijakan terkait pendaftaran pasien.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Dokter spesialis Gigi Anak drg. Ajeng, Sp.KGA komplain karena ada 1 pasien yang didaftar oleh pendaftaran pada waktu jam prakteknya sudah selesai.
		A	1. Menutup pendaftaran poli spesialis di H-10menit sebelum jam praktik selesai. 2. Konfirmasi DPJP jika ada tambahan pasien yang mendekati jam praktik selesai.
4.	ERM Rawat Inap belum terlaksana, ERM rawat jalan masih ditemukan kendala.	P	Merealisasikan pelaksanaan ERM rawat Inap dan rawat Jalan pada tahun 2025.
		D	Kolaborasi dengan Programmer PT.
		S	ERM Rawat jalan sudah terlaksana,

			tetapi masih banyak ketidaklengkapan dalam penginputan ERM.
		A	1. Follow up terus menerus ke programmer dengan cara screenshot permasalahan dan dikirimkan via whatsapp guna menindaklanjuti permasalahan tersebut agar proses validasi ERM berjalan lancar. 2. Trial ERM Rawat Inap Bulan Maret 2025.
5.	Pasien BPJS TK dari IGD tidak diberikan pengantar rujukan ke Poli Spesialis.	P	Perbaikan alur rujukan pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ada 1 pasien dari IGD yg tidak diberikan pengantar rujukan untuk ke poli spesialis bedah plastik dan tidak diarahkan ke pendaftaran untuk informasi jadwal praktek dokter tersebut. Pasien ke pendaftaran pada hari H tidak membawa surat rujukan dan datang pada hari yang tidak ada jadwal dokter tersebut.
		A	Mengingatkan ke KARU IGD terkait alur pasien BPJS TK dan selalu mengarahkan pasien ke pendaftaran untuk informasi jadwal dokter apabila pasien ada kontrol Lanjutan.
6.	Ketidak lengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA.	P	Perubahan alur analisa rekam medis.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh semua PPA.
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap.
7.	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	Pengajuan fitur Rujuk Penuh di SIMRS ke programmer
		D	Karu koordinasi dengan programmer
		S	Surat rujukan penuh tidak lagi manual tetapi bisa langsung terhubung ke VCLAIM sehingga bisa mengurangi waktu tunggu di pendaftaran
		A	1. Follow up ke programmer 2. Monitoring dan evaluasi SIMRS
8.	Perubahan surat kontrol pasien tidak sesuai tanggal IU	P	Mengadakan rapat untuk alur perubahan surat kontrol
		D	Koordinasi dengan Karu IFSRS dan Karu Poli
		S	Untuk perawat poli lebih teliti kembali bila akan menginputkan surat kontrol pasien
		A	Bila terjadi perubahan surat kontrol maka farmasi menarik surat kontrol yang di bawa pasien untuk selanjutnya dan mengarahkan pasien ke CSO untuk ubah dan cetak surat kontrol terbaru

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid.	P	Memperbaiki pencatatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan. Pencatatan real per lantai.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Memperbaiki respon time pelayanan radiologi.
		D	Kolaborasi antara perawat dan radiographer dengan DS Radiologi.
		S	Pencatatan dapat diketahui respon time pelayanan radiologi dari selesai pemeriksaan sampai dengan selesai hasil.
		A	Melakukan pencatatan waktu permintaan dan selesai hasil di Google Spreadsheet.
2.	Menerima permintaan pemeriksaan pasien IGD tanpa ada inputan di SIMRS.	P	Perbaiki alur pelayanan pemeriksaan radiologi dari unit.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan sesuai SPO.
		S	Petugas IGD sering kali meminta pemeriksaan sebelum dilakukan input untuk menegaskan diagnosis. Perawat juga menghapus inputan tanpa konfirmasi petugas radiologi setelah selesai pemeriksaan dan hasil sudah

			dicetak.
		A	Pemeriksaan dilakukan jika sudah ada inputan di SIMRS. Pemeriksaan yang dihapus tanpa konfirmasi maka menjadi beban petugas yang menghapus.
3.	Pemeriksaan Cito Bed tidak sesuai dengan kriteria	P	1. Mengidentifikasi kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Melakukan analisis akar masalah untuk mengetahui penyebab pemeriksaan cito bed tidak sesuai dengan kriteria. 3. Mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed.
		D	1. Mengadakan pelatihan untuk tim medis dan tim keperawatan tentang kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Mengembangkan checklist untuk memastikan pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 3. Mengimplementasikan sistem pelaporan untuk memantau kualitas pemeriksaan cito bed.
		S	1. Peningkatan kualitas pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 2. Identifikasi masalah yang masih ada dan perlu diperbaiki.
		A	1. Menyusun SPO pemeriksaan cito bed berdasarkan kriteria. 2. Mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed. 3. Mengembangkan rencana untuk memantau dan mempertahankan kualitas pemeriksaan cito bed. 4. Mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pemeriksaan cito bed tetap sesuai dengan kriteria.

3.7.11 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Pendistribusian alat makan tidak tercatat dengan baik	P	Memperbaiki alur pengecekan fasilitas RS sebelum pasien KRS.
		D	Kolaborasi Ahli Gizi dengan Pendaftaran IGD, Perawat, CS Pantry, CS Ruang dan Kasir.
		S	Fasilitas RS resiko hilang karena pasien jika tidak dibuatkan alur yang jelas. Petugas wajib memberikan edukasi untuk meminimalisir kehilangan/kerusakan.
		A	Membuat SPO "Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS". Sosialisasi kepada Unit Terkait
2.	Selisih antara jumlah barang pada kartu stok dan jumlah fisik bahan makanan	P	Pendisiplinan pengisian kartu stok.
		D	Kolaborasi dengan tim pengolahan dan penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.
		S	Risiko kehabisan stok bahan makanan apabila tidak teratur mengisi kartu stok bahan makanan.

		A	Sosialisasi ulang kepada tim pengolahan dan tim penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.
--	--	---	---

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	41	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		9	2	7	0
		SMK		4	3	1	0
		SMA		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0

		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi		1	1	0	0

		Perkantoran					
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0

	Jantung dan Pembuluh Darah						
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			460				

Keterangan :
Pada bulan Juni 2025 terdapat 3 perawat resign

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta menterbitkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Juni 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Mei 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Juli 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/II/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025